

Bunga Rampai

PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE

STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN BERMARTABAT

Astin Nur Hanifah • Lely Khulafa'ur R • Binarti Dwi Wahyuningsih
Leza Fidyah Restiana • Arnetty

Editor: Mega Indah Permana Ningrum



BUNGA RAMPAI
PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE:
STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN
BERMARTABAT

Penulis:

Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.

Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.

Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.

Drg, Arnetty, M.Kes.

Editor:

Mega Indah Permana Ningrum, SST., M.Kes.



BUNGA RAMPAI PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE: STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN BERMARTABAT

Penulis: Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.

Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.

Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.

Drg, Arnetty, M.Kes.

Editor: Mega Indah Permana Ningrum, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-06-2

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku BUNGA RAMPAI PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE: STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN BERMARTABAT kami hadirkan sebagai ikhtiar ilmiah untuk memperkuat peran bidan dalam mendampingi perempuan memasuki perimenopause hingga postmenopause. Menempatkan “bermartabat” sebagai Kompas Nilai, buku ini menegaskan bahwa setiap perempuan berhak melalui transisi biologisnya dengan informasi yang akurat, dukungan emosional yang hangat, layanan yang aman dan berbasis bukti, serta penghormatan terhadap otonomi dan konteks budaya. Karya ini ditujukan bagi dosen dan mahasiswa kesehatan, bidan praktik, perawat, dokter, pengelola program, dan pengambil kebijakan di layanan primer, rumah sakit, maupun komunitas.

Struktur buku mengikuti alur praktis dan komprehensif. Bab 1 (Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.) menegaskan konsep dasar menopause dan kompetensi inti bidan sebagai pendidik kesehatan yang peka budaya. Bab 2 (Lely Khulafa’ur R, S.ST., M.Kes.) menguraikan pengelolaan gejala secara holistik, menggabungkan pendekatan non-farmakologis, dukungan psikologis, terapi komplementer terpilih, dan integrasi farmakologis yang bijak. Bab 3 (Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.) memperkuat aspek skrining: tujuan, landasan ilmiah, jenis dan frekuensi skrining yang direkomendasikan, peran tenaga kesehatan, serta strategi peningkatan partisipasi.

Dimensi psikososial diperdalam di Bab 4 (Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.) yang membahas pendampingan psikologis landasan teori, dampak, prinsip etika, teknik, materi, evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor. Bab 5 (Drg. Arnetty, M.Kes.) menegaskan pilar nutrisi dan gaya hidup: fisiologi dan implikasi gizi, pola makan seimbang, mikronutrien kunci, adaptasi kuliner Nusantara berbasis bukti, hidrasi cerdas dan kesehatan urogenital, aktivitas fisik terstruktur, higiene tidur dan manajemen stres, serta tinjauan suplemen dan herbal yang aman. Setiap bab dilengkapi referensi dan glosarium, dan diakhiri profil penulis; semoga buku ini menjadi panduan yang mencerahkan serta memperkuat praktik kebidanan yang humanis, peka budaya, dan berbasis bukti menuju menopause yang sehat dan bermartabat.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAN BIDAN DALAM EDUKASI MASA MENOPAUSE 1

Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Menopause	2
C. Peran Bidan	7
D. Peran Bidan dalam Edukasi Masa Menopause.....	9
E. Kesimpulan	18
F. Referensi.....	19
G. Glosarium.....	20

CHAPTER 2 PENGELOLAAN GEJALA KLINIS MENOPAUSE SECARA HOLISTIK

.....	23
Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Gambaran Umum Gejala Klinis Menopause.....	24
C. Prinsip Dasar Pendekatan Holistik pada Menopause	26
D. Pendekatan Non-Farmakologis dalam Manajemen Gejala	27
E. Intervensi Psikologis dan Dukungan Emosional	29
F. Terapi Komplementer dan Alternatif dalam Menopause	32
G. Integrasi Pendekatan Farmakologis dalam Pendekatan Holistik.....	34
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pendampingan Holistik.....	36
I. Simpulan.....	38
J. Referensi.....	39
K. Glosarium.....	41

CHAPTER 3 SKRINING KESEHATAN PADA MASA PERIMENOPAUSE DAN POSTMENOPAUSE 43

Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Tujuan Skrining Kesehatan	45

C. Landasan Ilmiah Skrining pada Perimenopause dan Postmenopause.....	47
D. Jenis Skrining Kesehatan yang Direkomendasikan.....	50
E. Panduan Frekuensi dan Metode Skrining	53
F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Skrining.....	56
G. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Skrining.....	59
H. Strategi Peningkatan Partisipasi dalam Skrining	62
I. Simpulan.....	65
J. Referensi.....	67
K. Glosarium.....	70

CHAPTER 4 PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DALAM TRANSISI MENOPAUSE

.....	73
Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.....	73
A. Pendahuluan/Prolog	73
B. Landasan Teoritis Pendampingan Psikologis.....	74
C. Dampak Psikologis Transisi Menopause	75
D. Tujuan dan Sasaran Pendampingan Psikologis	76
E. Prinsip dan Etika Pendampingan.....	79
F. Teknik dan Pendekatan Pendampingan	82
G. Materi Pendampingan Psikologis.....	84
H. Peran Tenaga Kesehatan dan Kolaborasi Lintas Sektor	88
I. Evaluasi Keberhasilan Pendampingan.....	91
J. Tantangan dan Strategi Mengatasi Hambatan	94
K. Simpulan.....	96
L. Referensi.....	98
M. Glosarium.....	100

CHAPTER 5 NUTRISI OPTIMAL DAN GAYA HIDUP SEHAT SELAMA

MENOPAUSE.....	103
Drg. Arnetty, M.Kes.....	103
A. Pendahuluan/Prolog	103
B. Fisiologi Menopause dan Implikasi Gizi.....	105
C. Prinsip Pola Makan Seimbang Selama Menopause	109
D. Mikronutrien Kunci: Kalsium, Vitamin D, B12, Folat, dan Antioksidan.....	112
E. Pola Makan Berbasis Bukti dan Adaptasi Nusantara	115
F. Hidrasi Cerdas serta Kesehatan Urogenital	118
G. Aktivitas Fisik: Aerobik, Kekuatan, Keseimbangan, dan Latihan Dasar Panggul.....	121

H. Higiene Tidur dan Manajemen Stres.....	124
I. Suplemen dan Herbal: Bukti, Keamanan, serta Interaksi Obat	127
J. Implementasi Praktis, Peran Keluarga, Monitoring, dan Tindak Lanjut.....	130
K. Simpulan.....	133
L. Referensi.....	134
M. Glosarium.....	135
PROFIL PENULIS	141

CHAPTER 1

PERAN BIDAN DALAM EDUKASI MASA MENOPAUSE

Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Menopause merupakan transisi biologis yang dialami oleh setiap perempuan, biasanya terjadi antara usia 45 hingga 55 tahun, ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Fase ini bukan sekadar perubahan fisiologis, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kesehatan mental, emosional, dan sosial perempuan. Gejala seperti hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan penurunan kepadatan tulang sering kali menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang dapat memengaruhi kualitas hidup.

Dalam konteks ini, edukasi kesehatan menjadi kunci utama untuk membantu perempuan memahami dan mengelola perubahan yang terjadi selama masa menopause. Sayangnya, masih banyak perempuan yang kurang mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai fase ini, sehingga mereka cenderung menghadapi menopause dengan rasa takut, stigma, atau bahkan penolakan.

Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan komunitas, memegang peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi yang bersifat promotif dan preventif. Peran bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan kebidanan seperti kehamilan dan persalinan, tetapi juga mencakup pendampingan perempuan dalam setiap tahap kehidupan reproduksinya, termasuk masa menopause. Melalui kelas edukasi, konseling individual, dan penyuluhan komunitas, bidan dapat menyampaikan informasi tentang perubahan hormonal, cara mengelola gejala, pentingnya nutrisi dan aktivitas fisik, serta strategi menjaga kesehatan mental.

Lebih dari sekadar penyampai informasi, bidan berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis empati, bidan mampu membangun kepercayaan dan membuka ruang dialog yang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan kekhawatiran mereka. Edukasi yang diberikan oleh bidan juga dapat memperkuat dukungan sosial, mendorong keterlibatan pasangan dan keluarga, serta mengurangi stigma yang sering melekat pada masa menopause sebagai "akhir dari masa produktif." Dengan demikian, peran

bidan dalam edukasi masa menopause bukan hanya penting, tetapi juga strategis dalam membentuk generasi perempuan yang lebih siap, sehat, dan berdaya dalam menghadapi fase kehidupan yang tak terhindarkan ini.

B. Konsep Dasar Menopause

Menopause adalah suatu fase fisiologis dialami oleh setiap wanita, ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat berhentinya fungsi ovarium dalam memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Menopause biasanya terjadi pada rentang usia 45–55 tahun, dengan rata-rata usia di Indonesia sekitar 50 tahun. Secara medis, menopause baru dapat ditegakkan apabila seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa adanya penyebab patologis lain.

Menopause bukanlah suatu penyakit, melainkan proses biologis alami yang merupakan bagian dari penuaan. Namun, perubahan hormonal yang terjadi seringkali menimbulkan berbagai gejala, baik fisik maupun psikologis, yang dapat memengaruhi kualitas hidup wanita. Perubahan fisik yang umum dialami antara lain hot flushes, keringat malam, kekeringan vagina, gangguan tidur, serta perubahan distribusi lemak tubuh. Sementara itu, perubahan psikologis dapat berupa mudah marah, cemas, depresi, dan gangguan konsentrasi.

Selain itu, menopause juga berdampak pada kesehatan jangka panjang, karena berkurangnya kadar estrogen meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolik. Oleh karena itu, pemahaman tentang menopause sangat penting agar wanita dapat mempersiapkan diri menghadapi masa ini dengan pola hidup sehat serta dukungan dari tenaga kesehatan, termasuk bidan yang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, dan pendampingan.

Menopause merupakan suatu proses fisiologis yang ditandai dengan berhentinya fungsi ovarium secara permanen. Hal ini menyebabkan tidak adanya ovulasi dan menstruasi, serta penurunan produksi hormon-hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron. Proses ini berlangsung secara bertahap, diawali dengan fase perimenopause, berlanjut ke menopause, dan kemudian masuk ke masa postmenopause.

Secara biologis, menopause terjadi karena folikel ovarium yang tersisa semakin sedikit dan tidak lagi responsif terhadap rangsangan hormon gonadotropin. Pada usia reproduktif, ovarium wanita berisi sekitar 1–2 juta folikel primer sejak lahir, kemudian berkurang menjadi 300.000–500.000 saat pubertas. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 400 folikel yang akan matang menjadi ovum selama masa reproduktif, sedangkan sisanya mengalami proses atresia. Memasuki usia 40–50 tahun,

cadangan folikel ovarium semakin menipis hingga akhirnya habis, yang berakibat pada berhentinya menstruasi.

Menopause adalah proses alami yang dialami setiap wanita seiring bertambahnya usia, ditandai dengan berhentinya fungsi ovarium dalam memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kekurangan kedua hormon ini menimbulkan berbagai dampak fisiologis yang memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek (gejala langsung) maupun jangka panjang (komplikasi kronis).

1. Dampak pada Sistem Reproduksi

Atrofi urogenital (penipisan epitel vagina, penurunan elastisitas, dan berkurangnya lubrikasi menyebabkan kekeringan vagina, rasa nyeri, dan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual). Dispareunia (nyeri saat berhubungan akibat perubahan jaringan vagina). Inkontinensia urin (sulit menahan kencing akibat melemahnya otot dasar panggul). Atrofi uterus dan ovarium (ukuran rahim mengecil, ovarium tidak lagi aktif, payudara juga mengalami perubahan bentuk akibat berkurangnya jaringan kelenjar).

2. Dampak pada Sistem Tulang

Estrogen berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang. Kekurangan estrogen menyebabkan resorpsi tulang lebih cepat sehingga kepadatan tulang menurun. Osteopenia (penurunan kepadatan tulang awal). Osteoporosis (pengerosan tulang yang berat, meningkatkan risiko patah tulang (terutama tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan)).

3. Dampak pada Sistem Kardiovaskular

Estrogen memiliki efek protektif terhadap jantung dan pembuluh darah. Saat menopause, berkurangnya estrogen meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Peningkatan kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan penurunan HDL (kolesterol baik). Aterosklerosis (penumpukan plak di dinding arteri). Hipertensi dan penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada wanita pascamenopause dibanding sebelum menopause.

4. Dampak pada Sistem Saraf dan Psikologis

Perubahan hormonal juga berpengaruh pada sistem saraf pusat, khususnya neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Hot flushes dan keringat malam akibat ketidakstabilan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Gangguan tidur (insomnia, sering terbangun di malam hari). Mood swing (mudah marah, sensitif, menangis tanpa sebab). Kecemasan dan depresi karena penurunan serotonin. Gangguan kognitif (menurunnya konsentrasi dan daya ingat jangka pendek).

5. Dampak pada Sistem Kulit dan Rambut

Estrogen berperan dalam menjaga kolagen dan elastin kulit. Penurunan hormon ini mengakibatkan: Kulit kering dan tipis mudah keriput. Penurunan elastisitas kulit menjadi kendur. Rambut lebih rapuh dan rontok. Pertumbuhan rambut halus di wajah akibat perubahan rasio hormon androgen dan estrogen.

6. Dampak pada Sistem Metabolisme

Perubahan hormonal juga berdampak pada metabolisme tubuh: Perubahan distribusi lemak penumpukan lemak lebih dominan di perut (abdominal obesity). Resistensi insulin meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2. Sindrom metabolik kombinasi hipertensi, obesitas, dislipidemia, dan resistensi insulin.

7. Dampak Jangka Panjang

Selain gejala langsung, menopause juga berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kronis jangka panjang, antara lain: Osteoporosis dan fraktur tulang. Penyakit kardiovaskular (hipertensi, stroke, jantung koroner). Gangguan metabolik (diabetes, dislipidemia). Gangguan neurodegeneratif (misalnya peningkatan risiko Alzheimer pada sebagian wanita).

Perubahan hormonal yang terjadi pada masa menopause memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, karena hormon reproduksi tidak hanya berperan dalam siklus menstruasi, tetapi juga dalam metabolisme, kesehatan tulang, sistem kardiovaskular, dan kestabilan psikologis. Perubahan hormonal utama pada menopause meliputi penurunan estrogen dan progesteron, peningkatan kadar gonadotropin (FSH dan LH), serta perubahan pada hormon androgen.

1. Penurunan Estrogen

Estrogen adalah hormon utama yang diproduksi oleh ovarium, terutama estradiol. Hormon ini berfungsi mengatur siklus menstruasi, menjaga kepadatan tulang, elastisitas kulit, kesehatan urogenital, dan metabolisme lipid. Pada menopause, kadar estrogen menurun drastis karena habisnya cadangan folikel ovarium. Akibatnya terjadi gangguan vasomotor (hot flushes, keringat malam, palpitasi), atrofi urogenital (kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan, inkontinensia urin), osteoporosis (peningkatan resorpsi tulang), risiko kardiovaskular meningkat karena penurunan HDL dan peningkatan LDL sehingga terjadi perubahan kulit dan rambut (kulit kering, keriput, rambut rontok).

2. Penurunan Progesteron

Progesteron diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi. Karena pada menopause tidak terjadi ovulasi, produksi progesteron juga menurun drastis. Dampak penurunan progesteron: Gangguan tidur (insomnia), perubahan mood seperti mudah marah atau depresi, tidak adanya efek pelindung progesteron terhadap endometrium, sehingga keseimbangan hormon terganggu.

3. Peningkatan Gonadotropin (FSH dan LH)

Hormon gonadotropin (FSH dan LH) dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Pada masa reproduksi, kadar FSH dan LH diatur oleh mekanisme umpan balik negatif estrogen dan progesteron. Ketika estrogen dan progesteron menurun, mekanisme umpan balik negatif hilang, sehingga hipofisis meningkatkan produksi FSH dan LH. FSH meningkat lebih tinggi dibanding LH, sehingga pemeriksaan kadar FSH sering dijadikan parameter laboratorium untuk menentukan menopause (nilai FSH > 40 IU/L umumnya menandakan menopause). Peningkatan FSH dan LH tidak mampu merangsang folikel yang sudah habis, sehingga siklus menstruasi tidak lagi terjadi.

4. Perubahan Hormon Androgen

Selain estrogen dan progesteron, ovarium juga menghasilkan androgen dalam jumlah kecil (testosteron dan androstenedion). Pada menopause, produksi androgen ovarium berkurang, meskipun sebagian masih dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dampaknya: Penurunan libido dan gairah seksual, perubahan komposisi tubuh, dengan penumpukan lemak di perut, penurunan massa otot dan energi.

5. Hormon Lain yang Terpengaruh

Selain hormon reproduksi, beberapa hormon lain ikut terpengaruh oleh proses menopause, antara lain: Kortisol: kadar kortisol bisa lebih mudah meningkat akibat stres, sehingga wanita menopause rentan mengalami kelelahan kronis. Hormon tiroid pada sebagian wanita dapat terjadi perubahan metabolisme yang meniru gejala menopause, sehingga pemeriksaan fungsi tiroid kadang diperlukan untuk membedakan kondisi ini.

Tanda dan gejala menopause tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui transisi yang panjang dengan berbagai gejala klinis yang bervariasi. Tanda dan gejala menopause sangat dipengaruhi oleh perubahan hormonal, khususnya penurunan estrogen dan progesteron, serta peningkatan gonadotropin (FSH dan LH). Gejala menopause dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu gejala vasomotor, psikologis, urogenital, dan somatik.

1. Gejala Vasomotor

Gejala ini merupakan keluhan khas dan paling sering dialami wanita menopause. Hot flashes rasa panas yang muncul tiba-tiba terutama di wajah, leher, dan dada, disertai kemerahan dan keringat berlebih. Keringat malam (night sweats) sering mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan di siang hari. Palpitasi (jantung berdebar) akibat stimulasi sistem saraf otonom. Gejala vasomotor biasanya muncul pada masa perimenopause dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun setelah menopause.

2. Gejala Psikologis

Fluktuasi hormon estrogen berpengaruh terhadap neurotransmitter otak (serotonin, dopamin, norepinefrin), sehingga memengaruhi kestabilan emosi dan fungsi kognitif. Mood swing perubahan suasana hati yang cepat. Mudah marah, gelisah, atau cemas tanpa sebab jelas. Depresi ringan hingga sedang. Gangguan tidur (insomnia), baik sulit tidur maupun sering terbangun di malam hari. Penurunan konsentrasi dan daya ingat jangka pendek.

3. Gejala Urogenital

Menurunnya kadar estrogen menyebabkan perubahan pada organ reproduksi dan saluran kemih, yang dikenal sebagai sindrom genitourinary menopause. Kekeringan vagina (vaginal dryness). Dispareunia nyeri saat berhubungan seksual akibat berkurangnya lubrikasi. Atrofi vagina penipisan dan hilangnya elastisitas jaringan vagina. Inkontinensia urin sulit menahan buang air kecil. Infeksi saluran kemih berulang karena perubahan pH vagina dan flora normal.

4. Gejala Somatik (Fisik)

Selain memengaruhi sistem reproduksi, menopause juga berdampak pada kondisi tubuh secara umum. Nyeri otot dan sendi (arthralgia, myalgia). Sakit kepala atau pusing. Kelelahan kronis meskipun tanpa aktivitas berat. Perubahan bentuk tubuh lemak lebih banyak menumpuk di area perut (abdominal obesity). Perubahan kulit menjadi kering, tipis, mudah berkeriput. Perubahan rambut lebih rapuh, rontok, bahkan tumbuh rambut halus di wajah.

5. Faktor yang Mempengaruhi Keparahan Gejala

Tidak semua wanita mengalami gejala menopause dengan intensitas yang sama. Beberapa faktor yang memengaruhi adalah: Usia menopause dini (<45 tahun) cenderung lebih berat. Status gizi obesitas atau malnutrisi dapat memperparah gejala. Gaya hidup perokok, kurang olahraga, dan konsumsi alkohol meningkatkan keparahan gejala. Faktor psikososial dukungan keluarga dan lingkungan sangat memengaruhi kemampuan beradaptasi dengan gejala menopause.

Menopause tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi ovarium dan kadar hormon reproduksi wanita. Proses ini umumnya terbagi menjadi empat tahapan utama, yaitu premenopause, perimenopause, menopause, dan postmenopause.

1. Premenopause

Premenopause adalah fase reproduksi normal sebelum munculnya tanda-tanda penurunan fungsi ovarium. Pada tahap ini wanita masih mengalami siklus menstruasi teratur dan subur. Biasanya mulai dari pubertas hingga sekitar usia 40 tahun. Kondisi hormonal: produksi estrogen dan progesteron masih normal,

meskipun perlahan mulai menurun menjelang usia 35-40 tahun. Ciri klinis: menstruasi tetap teratur, tidak ada gejala khas menopause, namun cadangan ovarium mulai berkurang.

2. Perimenopause

Perimenopause adalah periode transisi menuju menopause, dimulai saat wanita mulai merasakan gejala akibat penurunan hormon meskipun masih mengalami menstruasi, dan berakhir satu tahun setelah menstruasi terakhir. Biasanya dimulai sekitar usia 40-50 tahun. Kondisi hormonal: terjadi fluktuasi estrogen dan progesteron yang signifikan. Estrogen bisa naik turun tajam sehingga menimbulkan gejala tidak menentu. Ciri klinis: Siklus menstruasi menjadi tidak teratur (lebih pendek, lebih panjang, atau perdarahan yang lebih sedikit/lebih banyak), timbul gejala vasomotor seperti hot flushes dan keringat malam, gangguan tidur, mood swing, dan cemas mulai muncul. Perimenopause bisa berlangsung selama 2-8 tahun sebelum seorang wanita benar-benar masuk menopause.

3. Menopause

Menopause adalah fase ketika seorang wanita sudah tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut akibat berhentinya fungsi ovarium secara permanen. Rata-rata terjadi pada usia 45–55 tahun (di Indonesia sekitar 50 tahun). Kondisi hormonal: kadar estrogen dan progesteron sangat rendah, sementara FSH dan LH meningkat tajam. Ciri klinis: Menstruasi benar-benar berhenti, gejala vasomotor (hot flushes, keringat malam) biasanya paling terasa, kekeringan vagina, penurunan libido, dan gangguan urogenital semakin nyata.

4. Postmenopause

Postmenopause adalah masa setelah seorang wanita memasuki menopause, dimulai setahun setelah menstruasi terakhir dan berlangsung hingga akhir hayat. Kondisi hormonal: estrogen dan progesteron tetap rendah secara konsisten. Ciri klinis: Gejala vasomotor bisa berkurang, tetapi sebagian wanita masih mengalaminya, risiko jangka panjang meningkat, seperti osteoporosis, penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan metabolik dan perubahan urogenital (atrofi vagina, inkontinensia) lebih menonjol.

C. Peran Bidan

Peran bidan merupakan aspek fundamental dalam praktik kebidanan yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan seorang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya sebatas mendampingi proses persalinan, melainkan mencakup seluruh aspek kesehatan reproduksi perempuan dan anak, mulai dari prakonsepsi,

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga masa antara kehamilan berikutnya. Para ahli mendefinisikan peran bidan dengan cakupan dan penekanan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam menegaskan bahwa bidan adalah tenaga profesional yang berkompeten, mandiri, serta berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Menurut World Health Organization (WHO, 2022), bidan adalah seorang tenaga kesehatan yang telah menjalani pendidikan formal kebidanan yang diakui, memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan secara menyeluruh, dan mampu melaksanakan praktik dengan profesional. WHO menekankan bahwa peran bidan tidak terbatas pada pelayanan klinis saja, melainkan juga sebagai pendidik dan konselor yang mendukung kesehatan ibu, bayi baru lahir, serta komunitas dalam konteks kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa bidan berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di dunia.

Sementara itu, International Confederation of Midwives (ICM, 2017) mendefinisikan peran bidan secara lebih komprehensif, yaitu sebagai care provider, educator, counselor, leader, manager, researcher, and advocate. Dengan demikian, bidan tidak hanya memberikan asuhan langsung kepada klien, tetapi juga berperan dalam pendidikan kesehatan, advokasi hak-hak reproduksi, melakukan penelitian, serta mengembangkan kepemimpinan dalam sistem pelayanan kesehatan. Definisi ini menegaskan bahwa peran bidan bersifat multidimensional dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Di tingkat nasional, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI, 2007) menegaskan bahwa bidan memiliki peran sebagai pemberi asuhan, pendidik, konselor, pengelola, peneliti, dan pembaharu. Dengan peran ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang komprehensif, berkualitas, dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan paradigma sehat yang dicanangkan pemerintah Indonesia, di mana bidan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di masyarakat pedesaan maupun daerah terpencil.

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan kemandirian dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Landasan hukum peran bidan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yaitu mengatur praktik kebidanan, kewenangan bidan, serta perlindungan hukum bagi bidan dan klien. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yaitu mengatur kewenangan bidan dalam praktik mandiri maupun di fasilitas kesehatan. Kode Etik Bidan Indonesia (IBI) yaitu menjadi pedoman sikap profesional bidan dalam menjalankan perannya.

D. Peran Bidan dalam Edukasi Masa Menopause

Menopause merupakan fase alamiah dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi akibat penurunan fungsi ovarium. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek biologis, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, emosional, bahkan sosial perempuan. Banyak perempuan yang kurang siap menghadapi masa menopause, sehingga memerlukan pendampingan dan edukasi dari tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Dalam konteks masa menopause, peran bidan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendampingi, memotivasi, dan memberdayakan perempuan agar mampu melewati fase ini dengan kualitas hidup yang optimal. Adapun peran bidan dalam edukasi masa menopause antara lain:

1. Sebagai Pelaksana (*Care Provider*)

Sebagai tenaga kesehatan profesional, bidan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan asuhan kebidanan secara menyeluruh kepada perempuan dalam setiap tahap siklus kehidupannya. Tidak hanya berfokus pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, bidan juga memiliki peran penting dalam mendampingi perempuan yang memasuki masa menopause. Pada fase ini, perempuan mengalami perubahan fisiologis, psikologis, maupun sosial akibat menurunnya fungsi ovarium dan berhentinya siklus menstruasi.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana (*care provider*), bidan bukan hanya bertugas memberikan pelayanan medis atau tindakan langsung, tetapi juga melaksanakan fungsi edukasi kesehatan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan perempuan dalam menghadapi masa menopause.

a. Melakukan Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi

Bidan berperan penting dalam mendeteksi dini masalah kesehatan yang sering muncul pada masa menopause, seperti osteoporosis, penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan metabolisme. Melalui edukasi, bidan dapat menanamkan kesadaran kepada perempuan tentang pentingnya pencegahan komplikasi sejak dini. Implementasi nyatanya yaitu melakukan skrining kesehatan, seperti pemeriksaan tekanan darah, indeks masa tubuh, dan konseling terkait risiko osteoporosis. Memberikan edukasi tentang pentingnya asupan kalsium, vitamin D, dan aktivitas fisik untuk menjaga kepadatan tulang. Mengarahkan perempuan agar rutin melakukan pemeriksaan Papsmear,

mammografi, atau cek kesehatan sesuai anjuran. Memberikan Tindakan Asuhan Langsung.

- b. Selain edukasi, bidan juga memberikan tindakan asuhan langsung yang mendukung kesehatan perempuan pada masa menopause. Implementasi nyata yaitu memberikan terapi non-farmakologis seperti relaksasi, senam kegel, atau pijat relaksasi untuk mengurangi ketidaknyamanan. Merujuk pasien ke dokter spesialis bila ditemukan gejala yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

2. Sebagai Pendidik (*Educator*)

Sebagai *Educator*, bidan berperan utama dalam memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada perempuan yang memasuki masa menopause. Edukasi ini bertujuan agar perempuan dapat memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya, mengetahui cara mengelola gejala yang muncul, serta mencegah terjadinya komplikasi kesehatan yang sering timbul pada periode ini. Materi edukasi yang diberikan bidan meliputi:

- a. Perubahan fisiologis dan hormonal

Menjelaskan tentang penurunan hormon estrogen dan progesteron yang memengaruhi siklus menstruasi. Edukasi tentang gejala umum menopause seperti hot flushes, keringat malam, gangguan tidur, dan kekeringan vagina.

- b. Kesehatan reproduksi dan seksual

Edukasi mengenai penurunan libido, pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, serta cara mengatasi kekeringan vagina dengan pelumas atau terapi non-hormonal.

- c. Pencegahan penyakit degeneratif

Bidan memberikan informasi pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah osteoporosis, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang lebih berisiko setelah menopause.

- d. Gaya hidup sehat

Pentingnya olahraga teratur, konsumsi gizi seimbang (terutama kalsium, vitamin D, protein), menjaga berat badan ideal, serta berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol/kafein.

- e. Kesehatan mental dan sosial

Bidan mengedukasi perempuan mengenai manajemen stres, teknik relaksasi, serta pentingnya dukungan keluarga untuk menjaga keseimbangan emosional.

Peran edukator yang dijalankan bidan tidak hanya berupa teori, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Penyuluhan Kesehatan di Komunitas: Bidan mengadakan penyuluhan di posyandu lansia, arisan ibu-ibu, kelompok PKK, atau majelis taklim.
- b. Kelas Edukasi Menopause: Bidan membuat program kelas khusus untuk perempuan usia 40 tahun ke atas, mirip seperti kelas ibu hamil, tetapi fokus pada persiapan dan adaptasi menopause.
- c. Konseling Individu: Bidan menyediakan konsultasi tatap muka di praktik mandiri, puskesmas, atau rumah sakit.
- d. Media Edukasi: Bidan menggunakan leaflet, poster, video pendek, bahkan media sosial untuk menyebarkan informasi sederhana mengenai menopause.
- e. Kolaborasi dengan Posyandu Lansia: Bidan berperan aktif memberikan edukasi saat kegiatan posyandu lansia, yang biasanya dihadiri perempuan usia 45 tahun ke atas.

Sebagai edukator, bidan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing, memberi motivasi, dan mendampingi perempuan secara praktis melalui berbagai media dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Sebagai Konselor

Masa menopause merupakan fase alami dalam siklus kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi akibat penurunan fungsi ovarium. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, emosional, hingga sosial. Banyak perempuan yang mengalami kecemasan, depresi ringan, rasa tidak percaya diri, bahkan ketakutan terhadap penuaan dan penurunan fungsi reproduksi. Dalam situasi ini, peran bidan sebagai konselor sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, serta pendampingan psikologis yang membantu perempuan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

a. Memberikan Konseling Individual

Bidan berperan sebagai konselor yang mendengarkan keluhan dan kekhawatiran perempuan secara personal. Konseling ini bersifat rahasia, empatik, dan menghargai martabat klien. Melalui pendekatan individual, bidan dapat memahami kebutuhan spesifik setiap perempuan dan memberikan edukasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Implementasi nyata yaitu mendengarkan keluhan perempuan tentang hot flushes, sulit tidur, atau penurunan gairah seksual. Memberikan penjelasan bahwa gejala tersebut adalah hal yang normal pada masa menopause. Menawarkan strategi mengatasi masalah, misalnya teknik relaksasi, perubahan gaya hidup, atau diskusi dengan pasangan.

b. Memberikan Konseling Kelompok

Selain konseling individual, bidan dapat memfasilitasi konseling kelompok agar perempuan saling berbagi pengalaman. Hal ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menciptakan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan pada masa menopause. Implementasi nyatanya yaitu menyelenggarakan kelas menopause di posyandu lansia atau kelompok PKK. Mengajak peserta berdiskusi tentang pengalaman perubahan fisik dan psikologis yang mereka alami. Memberikan edukasi terstruktur tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, hingga cara menjaga kesehatan mental.

c. Konseling Keluarga

Peran keluarga sangat besar dalam membantu perempuan melewati masa menopause. Bidan sebagai konselor berperan memberikan edukasi kepada pasangan maupun anggota keluarga lain agar memahami perubahan yang dialami perempuan dan mampu memberikan dukungan yang tepat. Implementasi nyatanya yaitu mengedukasi suami tentang pentingnya komunikasi terbuka dan dukungan emosional pada istri. Memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa perubahan emosi ibu adalah bagian dari proses menopause. Menjelaskan peran keluarga dalam menciptakan suasana rumah yang nyaman dan harmonis.

d. Memberikan Dukungan Psikologis

Sebagai konselor, bidan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada kesejahteraan emosional klien. Bidan harus mampu menciptakan hubungan saling percaya, sehingga perempuan merasa aman dan dihargai dalam mengungkapkan perasaannya. Implementasi nyatanya yaitu menenangkan klien yang merasa takut kehilangan daya tarik atau fungsi reproduksi. Membantu perempuan menemukan cara berpikir positif tentang penuaan dan peran baru dalam keluarga maupun masyarakat. Memberikan motivasi agar perempuan tetap aktif, produktif, dan percaya diri.

e. Membantu Pengambilan Keputusan

Bidan sebagai konselor juga membantu perempuan mengambil keputusan terkait pilihan penanganan gejala menopause, baik dengan terapi non-farmakologis maupun farmakologis (seperti HRT-Hormone Replacement Therapy). Edukasi diberikan secara objektif agar perempuan mampu memilih yang terbaik sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Implementasi nyatanya yaitu menjelaskan keuntungan dan risiko terapi hormonal. Memberikan informasi tentang alternatif herbal atau terapi komplementer. Mendampingi perempuan dalam menentukan pilihan metode yang sesuai dengan keyakinan dan kondisi kesehatannya.

f. Menghubungkan dengan Sumber Daya Lain

Bidan sebagai konselor juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan klien dengan tenaga kesehatan lain atau layanan yang lebih spesifik bila dibutuhkan. Implementasi nyatanya yaitu merujuk klien ke dokter spesialis kandungan jika gejala menopause sangat mengganggu. Mengarahkan ke psikolog atau psikiater bila ditemukan tanda depresi berat. Menghubungkan perempuan dengan komunitas pendukung (support group) agar lebih mendapat dukungan sosial.

4. Sebagai Advokat (*Advocate*)

Dalam profesi kebidanan, bidan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi juga memiliki peran sebagai advokat, yaitu pembela hak dan kepentingan klien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa menopause, peran ini menjadi sangat penting karena masih banyak perempuan yang kurang memahami fase menopause, bahkan mengalami diskriminasi sosial dan stigma akibat perubahan yang dialami.

Bidan sebagai advokat berperan memastikan perempuan mendapatkan informasi yang benar, akses layanan kesehatan yang memadai, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, maupun sistem kesehatan. Fungsi advokasi bidan juga mencakup pemberdayaan perempuan agar mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri dalam bidang kesehatan reproduksi dan kualitas hidup.

a. Membela Hak Perempuan untuk Mendapatkan Informasi dan Edukasi

Bidan bertugas memperjuangkan hak perempuan menopause agar memperoleh edukasi yang akurat, jelas, dan sesuai kebutuhan. Hal ini penting karena banyak perempuan mengalami menopause tanpa pemahaman memadai, sehingga menimbulkan kecemasan, salah persepsi, bahkan penggunaan terapi yang tidak tepat. Implementasi nyatanya yaitu memberikan informasi tentang perubahan fisik dan emosional pada masa menopause secara sederhana dan mudah dipahami. Meluruskan mitos atau anggapan salah, misalnya bahwa menopause adalah tanda sakit atau akhir dari produktivitas perempuan. Memastikan perempuan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya, baik melalui penyuluhan, buku panduan, maupun media digital.

b. Memastikan Akses Layanan Kesehatan yang Adil

Sebagai advokat, bidan berperan menjembatani perempuan menopause dengan sistem layanan kesehatan agar mereka mendapatkan pemeriksaan, konseling, dan perawatan yang diperlukan. Implementasi nyatanya yaitu mengarahkan perempuan untuk melakukan pemeriksaan rutin (Pap smear, pemeriksaan payudara, skrining osteoporosis). Membantu perempuan

memanfaatkan program pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, untuk meringankan biaya layanan kesehatan. Menyuarakan pentingnya layanan kesehatan reproduksi bagi usia lanjut di forum masyarakat atau organisasi profesi.

c. Melibatkan Keluarga dan Masyarakat dalam Dukungan

Bidan juga berperan sebagai advokat yang memperjuangkan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar, agar perempuan menopause tidak merasa terasingkan atau terbebani. Implementasi nyata yaitu memberikan edukasi kepada suami tentang pentingnya dukungan emosional terhadap istri yang mengalami perubahan mood atau fisik. Mengajak anak-anak untuk lebih memahami kondisi ibu, sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam keluarga. Menyuarakan pentingnya peran masyarakat dalam menerima dan mendukung perempuan menopause, misalnya melalui kegiatan posyandu lansia atau kelas menopause.

d. Melindungi Perempuan dari Diskriminasi dan Stigma

Perempuan menopause seringkali dianggap sudah tidak produktif, lemah, atau kehilangan daya tarik. Sebagai advokat, bidan harus memperjuangkan hak perempuan untuk tetap dihargai, dihormati, dan diberdayakan. Implementasi nyata yaitu mengedukasi masyarakat bahwa menopause adalah proses fisiologis, bukan penyakit. Menghargai setiap keputusan perempuan terkait pilihan terapi (farmakologis maupun non-farmakologis). Membantu perempuan menemukan peran baru yang bermakna di masyarakat, misalnya sebagai kader kesehatan atau mentor bagi generasi muda.

e. Menyuarakan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Bidan sebagai advokat tidak hanya berperan di tingkat individu, tetapi juga di level komunitas dan kebijakan. Mereka dapat menjadi jembatan suara perempuan menopause agar mendapat perhatian dalam program kesehatan pemerintah. Implementasi nyata yaitu mendorong adanya program khusus kesehatan reproduksi lansia di puskesmas. Berpartisipasi dalam organisasi profesi (IBI) untuk menyuarakan pentingnya peningkatan layanan kesehatan perempuan menopause. Melakukan advokasi ke pemerintah desa agar menyediakan kegiatan edukasi rutin, misalnya kelas menopause atau posyandu lansia terintegrasi.

Sebagai advokat (advocate), bidan berperan membela hak perempuan menopause dalam mendapatkan informasi, layanan kesehatan, dukungan keluarga dan masyarakat, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Bidan juga menjadi suara perempuan di level komunitas dan kebijakan, sehingga kebutuhan kesehatan mereka tidak terabaikan. Dengan peran ini, bidan

membantu perempuan menopause tetap dihargai, sehat, percaya diri, dan mampu menjalani kehidupannya secara bermartabat.

5. Sebagai Peneliti (*Researcher*)

Profesi bidan menuntut praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), yaitu pelayanan yang diberikan harus didukung oleh hasil penelitian, bukan hanya pengalaman atau tradisi semata. Dalam konteks masa menopause, bidan tidak hanya menjadi pemberi layanan dan edukasi, tetapi juga berperan sebagai peneliti (*researcher*) yang menggali, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan tentang kebutuhan perempuan menopause. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam memberikan edukasi yang tepat, relevan, dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Peran bidan sebagai peneliti dalam edukasi menopause sangat penting karena setiap perempuan mengalami menopause dengan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian menjadi dasar untuk memahami keragaman pengalaman tersebut, sehingga edukasi yang diberikan lebih tepat sasaran.

a. Mengidentifikasi Masalah Kesehatan pada Masa Menopause

Bidan sebagai peneliti melakukan kajian lapangan untuk mengetahui masalah yang sering dialami perempuan menopause di komunitas. Identifikasi ini penting agar edukasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Implementasi nyatanya yaitu melakukan survei tentang keluhan yang paling sering dialami, seperti hot flushes, insomnia, atau perubahan mood. Meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan perempuan dalam mencari bantuan kesehatan. Mengkaji pengetahuan dasar perempuan tentang menopause sebelum dilakukan intervensi edukasi.

b. Mengembangkan Materi Edukasi yang Berbasis Bukti

Penelitian yang dilakukan bidan dapat menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi yang tepat, menarik, dan sesuai konteks budaya masyarakat. Implementasi nyatanya yaitu meneliti efektivitas media edukasi (leaflet, video, kelas kelompok) dalam meningkatkan pemahaman tentang menopause. Membandingkan metode penyuluhan tatap muka dengan edukasi berbasis digital (WhatsApp group, webinar). Menguji keberhasilan kelas menopause dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan setelah mengikuti program.

c. Mengevaluasi Efektivitas Program Edukasi

Sebagai peneliti, bidan tidak hanya membuat program edukasi, tetapi juga mengevaluasi keberhasilannya. Evaluasi ini menjadi dasar untuk

memperbaiki strategi edukasi berikutnya. Implementasi nyatanya yaitu mengukur tingkat pengetahuan perempuan sebelum dan sesudah mengikuti kelas menopause. Mengevaluasi dampak edukasi terhadap perubahan perilaku, misalnya peningkatan olahraga rutin atau pola makan sehat. Mengkaji apakah edukasi berhasil mengurangi kecemasan dan depresi pada perempuan menopause.

d. Menghasilkan Data untuk Pengambilan Kebijakan

Hasil penelitian yang dilakukan bidan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan, baik di tingkat puskesmas, pemerintah daerah, maupun nasional. Implementasi nyatanya yaitu melaporkan hasil penelitian tentang kebutuhan layanan menopause di wilayah tertentu kepada dinas kesehatan. Memberikan rekomendasi berbasis data tentang pentingnya penyediaan kelas menopause atau posyandu lansia terintegrasi. Membantu pemerintah dalam menyusun program kesehatan reproduksi perempuan usia lanjut.

e. Mengembangkan Inovasi dalam Edukasi Menopause

Penelitian juga memungkinkan bidan menciptakan inovasi baru dalam metode edukasi, sehingga informasi dapat diterima lebih mudah oleh perempuan menopause. Implementasi nyatanya yaitu mengembangkan modul edukasi menopause berbasis budaya lokal. Menciptakan aplikasi sederhana berisi panduan gaya hidup sehat pada masa menopause. Meneliti efektivitas terapi komplementer (senam kegel, yoga, relaksasi) sebagai bagian dari edukasi kesehatan.

f. Berkolaborasi dengan Akademisi dan Profesi Lain

Bidan sebagai peneliti tidak bekerja sendiri, tetapi dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, akademisi, dan lembaga penelitian untuk memperkaya data dan hasil kajian. Implementasi nyatanya yaitu bekerja sama dengan dosen atau peneliti universitas untuk melakukan penelitian terkait menopause. Mengikuti seminar, workshop, dan publikasi ilmiah untuk menyebarkan hasil penelitian. Menjadi penulis artikel ilmiah di jurnal kebidanan mengenai hasil penelitian tentang edukasi menopause.

6. Sebagai Pemimpin (*Manager & Leader*)

Bidan adalah tenaga profesional yang tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga memiliki fungsi manajerial dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan kesehatan perempuan di semua tahap kehidupannya. Pada masa menopause, bidan memegang peran penting untuk memastikan program edukasi berjalan efektif, terorganisir, serta mampu menjangkau perempuan secara luas.

Sebagai pemimpin (leader), bidan berperan mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi perempuan maupun masyarakat agar peduli terhadap kesehatan pada masa menopause. Sementara sebagai manajer (manager), bidan mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program edukasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kedua peran ini saling melengkapi untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan berkesinambungan.

a. Merencanakan Program Edukasi Menopause

Sebagai manajer, bidan bertugas menyusun perencanaan program edukasi yang sistematis sesuai kebutuhan masyarakat. Perencanaan mencakup analisis kebutuhan, tujuan, sasaran, metode, media, hingga evaluasi. Implementasi nyatanya yaitu melakukan survei awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan perempuan tentang menopause. Menyusun jadwal kegiatan kelas menopause di puskesmas atau posyandu lansia.

b. Mengelola Sumber Daya

Peran manajerial bidan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas agar edukasi berjalan optimal. Implementasi nyatanya yaitu mengatur tim kesehatan (dokter, perawat, kader) untuk terlibat dalam kegiatan edukasi menopause. Memanfaatkan fasilitas puskesmas, aula desa, atau media digital sebagai sarana edukasi. Mengalokasikan dana dengan efisien untuk penyusunan materi, leaflet, atau media audio-visual.

c. Memimpin dan Memberdayakan Tim

Sebagai pemimpin, bidan harus mampu memotivasi dan menggerakkan tim agar bekerja sama dalam memberikan edukasi menopause. Implementasi nyatanya yaitu memberikan arahan kepada kader posyandu untuk menyampaikan pesan kesehatan sederhana kepada perempuan usia lanjut. Menjadi role model dalam sikap positif, komunikasi empatik, dan pelayanan ramah perempuan. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan atau kader tentang materi menopause.

d. Menggerakkan Perempuan dan Keluarga

Bidan sebagai pemimpin juga berperan dalam menginspirasi perempuan menopause untuk lebih peduli terhadap kesehatannya serta melibatkan keluarga sebagai pendukung utama. Implementasi nyatanya yaitu mengajak perempuan mengikuti kelas menopause secara rutin. Mendorong keluarga agar terlibat, misalnya suami hadir dalam sesi edukasi tentang dukungan emosional. Memotivasi perempuan agar tetap aktif dalam kegiatan sosial, sehingga meningkatkan rasa percaya diri.

e. Mengembangkan Inovasi dalam Edukasi

Seorang pemimpin dituntut kreatif dalam mencari metode baru yang lebih efektif. Bidan dapat memanfaatkan inovasi dalam menyampaikan edukasi agar lebih menarik dan mudah diterima. Implementasi nyatanya yaitu membuat video edukasi singkat tentang menopause untuk dibagikan melalui media sosial atau grup WhatsApp. Menyusun modul sederhana berisi tips menghadapi menopause dengan bahasa mudah dipahami. Menyelenggarakan senam lansia atau yoga menopause sebagai bentuk edukasi sekaligus praktik kesehatan.

f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Sebagai manajer, bidan memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi keberhasilan program edukasi menopause dan memastikan keberlanjutannya. Implementasi nyatanya yaitu melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan perempuan. Mengevaluasi partisipasi peserta, kendala, dan kepuasan dalam kegiatan. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai dasar perbaikan program berikutnya.

g. Menjadi Agen Perubahan (*Change Agent*)

Kepemimpinan bidan dalam edukasi menopause tidak hanya terbatas pada kelompok kecil, tetapi juga berperan mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang menopause. Implementasi nyatanya yaitu menyuarakan pentingnya layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan usia lanjut di forum masyarakat. Mendorong pemerintah desa untuk memasukkan edukasi menopause dalam program posyandu lansia. Menjadi panutan dalam menerapkan gaya hidup sehat yang dapat dicontoh oleh masyarakat.

Sebagai pemimpin (*leader*) dan manajer (*manager*), bidan berperan dalam merencanakan, mengelola, memimpin, serta mengevaluasi program edukasi menopause. Bidan tidak hanya mengatur jalannya kegiatan, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan perempuan serta keluarganya agar lebih peduli terhadap kesehatan pada masa menopause. Dengan peran ini, bidan memastikan edukasi menopause terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup perempuan.

E. Kesimpulan

Masa menopause merupakan fase alami dalam kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi akibat penurunan fungsi ovarium dan produksi hormon estrogen. Perubahan ini tidak hanya menimbulkan gejala fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial wanita. Oleh karena itu, peran bidan menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan.

Bidan memiliki tanggung jawab sebagai edukator, konselor, advokat, peneliti, serta leader dan manajer dalam membantu wanita menghadapi masa menopause dengan sehat dan bermartabat. Melalui edukasi yang tepat, bidan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan wanita dalam menjaga kesehatan reproduksi, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup.

Dengan landasan hukum dari Kemenkes RI dan standar praktik profesi, bidan diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Implementasi nyata dari peran tersebut adalah memberikan konseling, penyuluhan kesehatan, advokasi hak-hak kesehatan wanita, serta melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Secara keseluruhan, peran bidan dalam edukasi masa menopause bukan hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan wanita agar mampu menghadapi perubahan biologis, psikologis, dan sosial dengan lebih baik, sehingga tercapai derajat kesehatan optimal pada usia lanjut.

F. Referensi

- Agustini, A. M., Hariyani, F., & Pasiriani, N. (2023). Pengaruh kelas edukasi kesehatan menopause pada wanita usia 40–50 tahun terhadap kesiapan dalam menghadapi masa menopause di Klinik POLDA Kaltim. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 2(4), 632–638. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v2i4.221>
- Depkes RI. (2007). Standar Profesi Bidan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Haniyah, S., Triana, N. Y., & Utami, T. (2024). Edukasi kesehatan persiapan menopause pada ibu dasawisma di Perumahan Tegalsari Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan (JUKMAS)*, 4(1), 79–88.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM.
- Khoirunnisa, M., Ramadhan, F. V. A., & Putri, M. T. (2024). Perbandingan efektivitas resistance training dengan pemberian konseling informasi dan edukasi tentang penanggulangan hot flushes terhadap intensitas hot flushes pada ibu perimenopause. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1331–1336. <https://doi.org/10.54082/jupin.420>
- Manuaba, I. B. G. (2013). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.

- North American Menopause Society (NAMS). (2023). The 2023 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 30(1), 1–26. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002095>
- Setiarni, D. A. K., Shofiyah, S., Yosin, E. P., Ruliati, R., & Fatoni, I. (2024). Edukasi kesehatan menopause pada ibu-ibu DWP Perumdan Tirta Kencana Jombang (Sehat dan Bahagia Menjelang Saat Menopause). *Masyarakat Mandiri dan Berdaya*, 3(3), 33–40. <https://doi.org/10.56586/mbm.v3i3.350>
- Shifren, J. L., & Gass, M. L. S. (2023). The role of healthcare providers in menopause management: A clinical update. *Obstetrics & Gynecology Clinics of North America*, 50(2), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2023.01.005>
- Utami, T., & Lestari, R. A. (2024). Peran bidan dalam pemberdayaan wanita usia pertengahan menghadapi menopause melalui konseling kesehatan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 87–95.
- Winarni, S. C., Hanifarizani, R. D., Gustina, M. I., Khuzaiyah, S., Susanti, N. Y., Rizqi, Y., & Kusuma, A. N. I. (2024). *Asuhan Kebidanan pada Masa Remaja dan Perimenopause*. Padang: Get Press Indonesia.
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: World Health Organization.
- Yusuf, S., & Amelia, R. (2023). Kecemasan dan kualitas hidup wanita menopause: Dampak intervensi edukasi berbasis komunitas. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 12(1), 45–54.
- Zhang, X., Chen, Y., & Wang, Y. (2023). Effectiveness of health education interventions in improving quality of life among menopausal women: A systematic review and meta-analysis. *BMC Women's Health*, 23(1), 102. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02130-8>

G. Glosarium

Advokat

Peran bidan dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan wanita, termasuk hak memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan pada masa menopause.

Andropause

Kondisi penurunan hormon testosteron pada pria yang menyerupai menopause pada wanita, meski gejalanya berbeda.

Anemia

Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, yang dapat diperburuk pada wanita menopause akibat gangguan metabolisme.

Cervical Cancer (Kanker Serviks)

Jenis kanker pada leher rahim yang risiko deteksinya perlu terus dilakukan meski wanita sudah menopause.

Depresi Menopause

Gangguan psikologis yang dapat muncul akibat perubahan hormonal pada masa menopause, ditandai perasaan sedih, cemas, dan kehilangan semangat.

Estrogen

Hormon utama wanita yang berperan dalam siklus menstruasi, kesehatan tulang, kulit, dan fungsi reproduksi. Produksinya menurun drastis saat menopause.

Folikel Ovarium

Kantung kecil dalam ovarium tempat sel telur berkembang; jumlahnya menurun seiring usia hingga habis saat menopause.

Hot Flushes

Gejala menopause berupa sensasi panas mendadak pada wajah, leher, dan dada, disertai keringat berlebih.

Hormone Replacement Therapy (HRT)

Terapi penggantian hormon untuk mengurangi gejala menopause, tetapi penggunaannya harus hati-hati karena ada efek samping.

Infertilitas

Ketidakmampuan memiliki keturunan, yang menjadi permanen pada wanita setelah menopause karena berhentinya fungsi ovarium.

Menopause

Fase alami dalam kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut akibat penurunan fungsi ovarium.

Osteoporosis

Kondisi pengeroposan tulang yang sering dialami wanita setelah menopause akibat penurunan hormon estrogen.

Perimenopause

Masa transisi sebelum menopause, biasanya ditandai dengan siklus menstruasi tidak teratur dan gejala awal menopause.

Postmenopause

Periode setelah seorang wanita melewati fase menopause, biasanya ditandai dengan berhentinya menstruasi total dan meningkatnya risiko komplikasi kesehatan.

Preventif

Upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan, salah satu peran bidan dalam edukasi menopause.

Progesteron

Hormon wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi, turut menurun saat menopause.

Promotif

Upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat.

Psikosomatis

Gangguan fisik yang muncul akibat masalah psikologis, misalnya nyeri otot atau sakit kepala yang dialami wanita menopause karena stres.

***Quality of Life* (Kualitas Hidup)**

Aspek kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang dipengaruhi oleh kondisi menopause pada wanita.

Vagina Atrofi

Penipisan dinding vagina akibat penurunan kadar estrogen, yang menyebabkan nyeri saat berhubungan intim pada wanita menopause.

CHAPTER 2

PENGELOLAAN GEJALA KLINIS MENOPAUSE SECARA HOLISTIK

Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Menopause merupakan sebuah periode penting dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Periode ini biasanya dialami oleh perempuan yang berusia antara 45 hingga 55 tahun, namun dapat bervariasi tergantung kondisi kesehatan masing-masing individu. Menopause bukanlah suatu kondisi penyakit, melainkan proses fisiologis yang alamiah. Meski demikian, periode ini sering kali disertai dengan berbagai gejala klinis yang dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup perempuan.

Gejala-gejala yang muncul selama menopause cukup bervariasi dan kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, hingga sosial. Secara fisik, perempuan sering mengalami gejala seperti hot flashes (sensasi panas tiba-tiba yang disertai keringat berlebih), gangguan tidur, nyeri sendi dan otot, sakit kepala, kelelahan, serta perubahan pada kulit dan rambut yang menjadi lebih kering dan tipis. Di sisi lain, secara emosional dan psikologis, menopause juga kerap menimbulkan gejala berupa mood swings (perubahan suasana hati secara drastis), kecemasan berlebih, mudah tersinggung, perasaan depresi, hingga menurunnya kepercayaan diri akibat berbagai perubahan fisik yang terjadi. Sementara secara sosial, gejala-gejala ini dapat menghambat interaksi perempuan dengan lingkungan sekitarnya dan berdampak pada hubungan interpersonal serta produktivitas kerja.

Dalam kenyataannya, pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap menopause cenderung berfokus pada pengobatan simptomatik, yakni hanya mengatasi gejala klinis secara parsial menggunakan metode farmakologis seperti terapi pengganti hormon (Hormone Replacement Therapy/HRT). Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan, seperti risiko efek samping yang tidak ringan serta tidak menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan holistik menjadi alternatif penting yang perlu dikembangkan dan diterapkan dalam manajemen gejala menopause. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memandang menopause tidak hanya sebagai peristiwa biologis semata,

tetapi juga sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan perempuan secara utuh dan integratif.

Pendekatan holistik dalam pengelolaan gejala klinis menopause memiliki signifikansi besar karena mampu mengintegrasikan berbagai intervensi yang mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, spiritual, dan sosial dalam sebuah strategi yang koheren dan harmonis. Dengan pendekatan ini, perempuan diajak untuk mengelola menopause bukan sekadar dari sisi medis atau biologis saja, namun juga memperhatikan dimensi psikologis seperti manajemen stres dan peningkatan kesejahteraan mental, aspek sosial seperti dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, serta aspek spiritual dalam menemukan makna baru dalam kehidupan pasca-menopause. Dengan demikian, pendekatan ini berpotensi menciptakan keseimbangan internal perempuan, meningkatkan kualitas hidup secara signifikan, dan membantu mereka menjalani masa menopause dengan lebih nyaman dan bermakna.

Di samping itu, pendekatan holistik juga relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana perempuan semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Saat ini perempuan cenderung mencari solusi alami yang lebih aman, minim efek samping, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara jangka panjang. Pendekatan holistik menjawab kebutuhan ini dengan mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, seperti pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, meditasi, yoga, mindfulness, dan berbagai intervensi non-farmakologis lainnya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya edukasi, konseling, serta pendampingan secara konsisten dari tenaga kesehatan yang memiliki perspektif holistik dalam mendampingi perempuan melalui periode transisi ini.

B. Gambaran Umum Gejala Klinis Menopause

Menopause merupakan fase alami dalam siklus hidup seorang perempuan yang menandai berakhirnya masa subur akibat berhentinya menstruasi secara permanen. Fase ini terjadi akibat penurunan drastis hormon reproduksi utama, khususnya estrogen dan progesteron. Kondisi ini membawa berbagai perubahan yang tidak hanya terbatas pada aspek biologis saja, namun juga secara signifikan memengaruhi kondisi fisik, emosional, psikologis, dan bahkan sosial perempuan. Gejala-gejala klinis menopause dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan durasi antar individu, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi kesehatan umum, gaya hidup, lingkungan, serta aspek psikologis dan dukungan sosial yang dimiliki oleh perempuan tersebut.

Salah satu gejala klinis menopause yang paling umum adalah hot flashes, yaitu sensasi panas tiba-tiba yang sering kali terasa sangat intens, terutama pada area wajah, leher, dan dada. Gejala ini umumnya disertai oleh kemerahan pada kulit, peningkatan detak jantung, serta keringat berlebihan yang dapat terjadi siang maupun malam hari (sering disebut night sweats). Hot flashes bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga beberapa menit dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini terjadi akibat perubahan pada mekanisme pengaturan suhu tubuh yang dipengaruhi oleh fluktuasi hormon estrogen di dalam tubuh.

Selain hot flashes, perempuan pada masa menopause juga sering mengalami berbagai bentuk gangguan tidur. Gangguan tidur yang dialami biasanya berupa kesulitan untuk memulai tidur (insomnia), sering terbangun di tengah malam, serta kualitas tidur yang buruk secara umum. Kondisi ini tidak jarang diperburuk oleh hot flashes pada malam hari, yang menyebabkan perempuan sering terbangun dan sulit untuk kembali tidur. Akibatnya, perempuan yang mengalami menopause sering kali merasa lelah, lesu, dan kurang produktif selama aktivitas di siang hari, serta memiliki peningkatan risiko gangguan mood yang berkaitan dengan kurangnya istirahat yang cukup.

Lebih jauh lagi, menopause juga membawa dampak signifikan pada kondisi psikologis dan emosional perempuan, terutama dalam bentuk perubahan suasana hati atau mood swings. Kondisi ini ditandai oleh fluktuasi perasaan yang cukup ekstrem, mulai dari rasa mudah tersinggung, marah tanpa alasan yang jelas, perasaan sedih yang tiba-tiba muncul, hingga kecemasan berlebihan. Dalam beberapa kasus yang lebih berat, gejala ini dapat berkembang menjadi kondisi depresi atau gangguan kecemasan yang membutuhkan perhatian khusus dan dukungan psikologis yang intensif. Penyebab mood swings pada menopause diyakini berkaitan erat dengan penurunan hormon estrogen, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi regulasi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mood dan emosi.

Selanjutnya, penurunan kadar hormon estrogen juga sangat berpengaruh terhadap fungsi seksual perempuan, yang menyebabkan berbagai bentuk gangguan seksual selama menopause. Gejala ini meliputi penurunan libido atau gairah seksual secara signifikan, vagina kering akibat berkurangnya produksi cairan lubrikasi alami, nyeri atau rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual (dyspareunia), serta penurunan sensitivitas seksual secara umum. Gangguan seksual ini sering kali berdampak lebih jauh terhadap hubungan intim pasangan, yang jika tidak ditangani

dengan baik dapat mengarah pada konflik rumah tangga maupun penurunan kualitas hubungan interpersonal secara keseluruhan.

Selain gejala utama tersebut, perempuan menopause juga umumnya mengalami berbagai keluhan fisik lainnya yang bervariasi intensitasnya. Keluhan tersebut antara lain berupa nyeri otot dan sendi yang sering kali muncul tanpa pemicu jelas, sakit kepala atau migrain yang semakin sering terjadi, perubahan signifikan pada kondisi kulit yang menjadi lebih kering, keriput, dan tipis, serta rambut yang mengalami penipisan dan kerontokan. Tidak jarang pula perempuan mengalami penambahan berat badan yang sulit dikontrol, terutama penumpukan lemak pada bagian perut dan pinggang. Perubahan ini terjadi akibat perubahan metabolisme tubuh yang cenderung melambat seiring bertambahnya usia dan menurunnya kadar estrogen dalam tubuh.

C. Prinsip Dasar Pendekatan Holistik pada Menopause

Pendekatan holistik dalam penanganan menopause merupakan sebuah paradigma yang melihat kondisi menopause tidak hanya sekadar dari sudut pandang medis atau biologis semata, melainkan juga melibatkan berbagai aspek lain secara komprehensif. Dalam perspektif ini, menopause dianggap sebagai proses alamiah yang kompleks yang memerlukan perhatian lebih luas, bukan hanya terbatas pada perubahan fisiologis, namun mencakup dimensi psikologis, sosial, emosional, hingga spiritual yang seluruhnya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Prinsip dasar pendekatan holistik ini menempatkan perempuan sebagai individu yang utuh dan unik, dengan kebutuhan yang harus dipenuhi secara menyeluruh agar dapat menjalani masa menopause dengan kualitas hidup yang optimal.

Secara fisik, pendekatan holistik mengakui pentingnya aspek kesehatan tubuh perempuan yang mengalami menopause, tetapi tidak hanya terbatas pada pemberian terapi hormon atau pengobatan konvensional semata. Sebaliknya, pendekatan ini juga menekankan pentingnya gaya hidup sehat seperti pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang rutin, serta manajemen berat badan yang ideal. Berbagai metode terapi komplementer, seperti yoga, meditasi, relaksasi, aromaterapi, serta pengobatan herbal juga dapat diintegrasikan secara efektif untuk mengurangi gejala-gejala fisik menopause seperti hot flashes, insomnia, dan nyeri sendi. Dengan demikian, perempuan tidak hanya terbantu dalam mengelola gejala fisiknya, tetapi juga memiliki kendali lebih besar atas kondisi kesehatan tubuhnya secara umum.

Selanjutnya, pendekatan holistik sangat menitikberatkan perhatian pada dimensi psikologis dan emosional perempuan selama masa menopause. Perubahan

hormon yang signifikan dapat memicu fluktuasi suasana hati, kecemasan, bahkan depresi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk kondisi perempuan secara keseluruhan. Pendekatan holistik memandang pentingnya dukungan psikologis melalui metode konseling individu, terapi kelompok, ataupun psikoterapi yang memungkinkan perempuan untuk mengungkapkan perasaan, mengelola stres, serta menemukan cara-cara efektif dalam menghadapi perubahan emosional yang terjadi. Selain itu, intervensi psikologis yang menggunakan pendekatan positif seperti terapi kognitif perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) atau mindfulness terbukti efektif dalam membantu perempuan menopause mengembangkan pola pikir yang lebih adaptif, meningkatkan kesadaran diri, serta membangun ketahanan psikologis dalam menghadapi tantangan emosional selama masa menopause.

Tidak kalah pentingnya dalam pendekatan holistik adalah dimensi sosial, yang mencakup kualitas hubungan interpersonal serta peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Menopause dapat menjadi fase yang menantang secara sosial, karena berbagai perubahan fisik maupun emosional bisa memengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, teman-teman, maupun lingkungan kerja. Pendekatan holistik dalam konteks ini mendorong perempuan untuk memperkuat hubungan sosial mereka melalui keterlibatan dalam berbagai komunitas dukungan yang positif, baik formal maupun informal, di mana perempuan dapat saling berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta membangun rasa solidaritas dan saling pengertian. Komunitas semacam ini sering kali mampu memberikan rasa keterikatan sosial yang kuat, sehingga perempuan tidak merasa sendirian menghadapi proses transisi menopause yang kompleks.

Lebih dalam lagi, pendekatan holistik juga mencakup dimensi spiritual dalam pengelolaan menopause. Dalam dimensi ini, menopause dipandang sebagai fase penting dalam siklus hidup perempuan yang memberikan kesempatan untuk refleksi diri secara mendalam, menemukan kembali makna hidup, serta memperkuat hubungan spiritual dengan diri sendiri maupun keyakinan yang dianut. Praktik-praktik spiritual seperti meditasi, berdoa, refleksi pribadi, atau ritual-ritual spiritual tertentu dapat membantu perempuan mengatasi perasaan kehilangan atau kecemasan yang sering muncul selama menopause. Selain itu, dimensi spiritual ini sering memberikan kekuatan internal bagi perempuan untuk menerima perubahan secara ikhlas, penuh penerimaan, serta memandang menopause sebagai proses yang bermakna dalam perjalanan hidup mereka.

D. Pendekatan Non-Farmakologis dalam Manajemen Gejala

Pendekatan non-farmakologis merupakan pilihan pengelolaan yang penting dan strategis dalam manajemen gejala klinis menopause, terutama bagi perempuan yang tidak ingin atau tidak bisa menggunakan terapi hormonal atau obat-obatan konvensional. Pendekatan ini memberikan alternatif yang aman dan efektif dengan risiko efek samping minimal, serta mampu memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Pengelolaan gejala menopause secara non-farmakologis mencakup berbagai metode dan strategi yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya tubuh secara alami serta peningkatan keseimbangan fisik, emosional, dan psikologis perempuan secara holistik.

Salah satu strategi utama dalam pendekatan non-farmakologis adalah optimalisasi nutrisi. Nutrisi yang tepat dan seimbang dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi berbagai gejala menopause seperti hot flashes, insomnia, kelelahan, serta penurunan kepadatan tulang. Konsumsi makanan yang kaya akan fitoestrogen, seperti kedelai, kacang-kacangan, biji rami, dan produk-produk fermentasi seperti tempe, diketahui dapat membantu mengurangi intensitas gejala-gejala vasomotor seperti hot flashes, karena fitoestrogen memiliki efek serupa hormon estrogen alami meskipun dalam intensitas yang lebih ringan. Di sisi lain, perempuan juga disarankan mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D, seperti produk susu rendah lemak, sayuran hijau, ikan, serta kacang-kacangan, untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis yang sering kali meningkat risikonya pada masa menopause. Selain itu, mengurangi asupan kafein, gula berlebihan, dan makanan pedas dapat membantu menekan intensitas dan frekuensi hot flashes serta gangguan tidur.

Di samping nutrisi, aktivitas fisik dan olahraga teratur memiliki peranan yang sangat penting dalam pendekatan non-farmakologis ini. Berbagai studi menunjukkan bahwa olahraga aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau senam aerobik ringan mampu memperbaiki mood, mengurangi kecemasan dan depresi, serta membantu mengelola berat badan yang cenderung meningkat selama menopause. Latihan beban atau resistensi seperti angkat beban ringan, pilates, atau senam kekuatan juga efektif untuk mempertahankan massa otot, meningkatkan metabolisme tubuh, serta menjaga kesehatan tulang. Aktivitas fisik secara teratur terbukti dapat menurunkan frekuensi hot flashes, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan kesejahteraan emosional perempuan secara umum. Selain manfaat fisik, olahraga rutin juga diketahui mampu meningkatkan produksi hormon endorfin, yang berperan penting dalam meningkatkan mood serta memberikan rasa nyaman dan rileks secara alami.

Yoga dan meditasi juga menjadi bagian penting dari pendekatan non-farmakologis dalam mengelola gejala menopause. Yoga, yang menggabungkan

latihan fisik berupa postur (asana), latihan pernapasan (pranayama), dan meditasi singkat, terbukti efektif membantu perempuan dalam mengurangi stres, menurunkan tingkat kecemasan, serta memperbaiki kualitas tidur. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa yoga secara signifikan dapat mengurangi intensitas hot flashes serta membantu mengatur mood yang sering kali tidak stabil selama menopause. Meditasi, khususnya mindfulness meditation, juga memberikan manfaat penting dalam pengelolaan gejala menopause. Praktik mindfulness yang dilakukan secara rutin mampu melatih perempuan untuk lebih menyadari dan menerima berbagai perubahan tubuh yang terjadi tanpa rasa panik atau cemas berlebihan. Dengan meditasi rutin, perempuan belajar merespons stres dengan lebih tenang, fokus, serta memiliki kapasitas emosional yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan emosional selama menopause.

Teknik relaksasi merupakan pendekatan lain yang sangat relevan dalam pengelolaan menopause. Teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam (deep breathing), visualisasi positif, guided imagery, dan progressive muscle relaxation terbukti efektif untuk mengurangi stres akut maupun kronis, menurunkan tekanan darah, mengurangi intensitas hot flashes, serta memperbaiki kualitas tidur. Dalam praktiknya, teknik relaksasi ini membantu perempuan untuk melatih respon relaksasi tubuh, yang secara fisiologis dapat mengurangi aktivasi sistem saraf simpatik, sehingga mengurangi gejala-gejala vasomotor maupun gangguan tidur. Praktik relaksasi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan emosional, yang secara tidak langsung membantu perempuan merasa lebih tenang, nyaman, dan percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama masa menopause.

Lebih lanjut, akupunktur merupakan metode non-farmakologis tambahan yang telah banyak diteliti dan terbukti efektif dalam pengelolaan gejala menopause. Akupunktur bekerja dengan cara merangsang titik-titik tertentu di tubuh untuk mengatur aliran energi (qi), memperbaiki keseimbangan hormonal, serta mengurangi gejala menopause seperti hot flashes, insomnia, mood swing, dan nyeri sendi. Banyak perempuan melaporkan perbaikan yang signifikan setelah menjalani serangkaian sesi akupunktur, dengan manfaat berupa peningkatan energi, perasaan lebih seimbang secara emosional, serta berkurangnya ketidaknyamanan fisik secara keseluruhan. Dalam pandangan holistik, akupunktur tidak hanya mengatasi gejala-gejala fisik saja, melainkan juga membantu perempuan untuk merasa lebih seimbang secara keseluruhan, baik secara fisik maupun emosional.

E. Intervensi Psikologis dan Dukungan Emosional

Menopause merupakan masa transisi alami yang tidak hanya menimbulkan berbagai perubahan fisik, tetapi juga membawa dampak emosional dan psikologis yang signifikan bagi sebagian besar perempuan. Selama masa ini, banyak perempuan mengalami peningkatan kecemasan, gangguan suasana hati, depresi ringan hingga sedang, serta rasa kehilangan atau penurunan harga diri akibat berbagai perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Oleh karena itu, intervensi psikologis dan dukungan emosional menjadi sangat penting sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam pengelolaan menopause. Intervensi ini bertujuan membantu perempuan dalam menghadapi tantangan emosional yang kompleks dan memperkuat kapasitas mereka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi secara positif dan sehat.

Salah satu intervensi psikologis yang banyak diterapkan dalam pengelolaan gejala menopause adalah konseling psikologis. Konseling memberikan ruang yang aman dan terbuka bagi perempuan untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan berbagai tantangan yang dialami selama masa transisi menopause. Dalam proses konseling, perempuan diajak berdiskusi secara mendalam mengenai gejala-gejala emosional yang mereka rasakan, seperti kecemasan tentang proses penuaan, kekhawatiran terkait hubungan sosial, ataupun masalah penerimaan diri. Konselor bertindak sebagai pendengar yang empatik sekaligus fasilitator yang membantu perempuan mengeksplorasi pikiran dan perasaannya, mengidentifikasi pola pikir negatif yang mungkin memperburuk kondisi emosionalnya, serta menemukan solusi atau strategi koping yang paling sesuai untuk diterapkan. Proses konseling ini dapat secara efektif mengurangi kecemasan, memperbaiki mood, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

Cognitive-behavioral therapy (CBT), atau terapi kognitif perilaku, adalah intervensi psikologis lain yang telah terbukti sangat efektif dalam membantu perempuan mengatasi berbagai masalah emosional yang timbul selama menopause. CBT berfokus pada identifikasi dan modifikasi pola pikir negatif yang sering kali menjadi akar perasaan cemas, depresi, atau rendah diri yang dialami perempuan selama menopause. Dalam terapi ini, perempuan diajak untuk mengenali pola pikir yang kurang realistis atau bahkan merugikan, seperti pemikiran tentang hilangnya daya tarik fisik, ketakutan berlebihan terhadap proses penuaan, atau perasaan bahwa dirinya tidak lagi berarti. Melalui serangkaian sesi CBT, perempuan diajarkan untuk mengganti pola pikir negatif tersebut dengan pola pikir yang lebih positif, realistis, dan konstruktif. CBT juga membantu perempuan mengembangkan strategi perilaku yang lebih sehat dalam menghadapi berbagai situasi emosional yang sulit, sehingga meningkatkan resiliensi emosional mereka secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani CBT

selama masa menopause umumnya melaporkan peningkatan kualitas hidup, berkurangnya kecemasan, serta suasana hati yang jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

Selain CBT, pendekatan psikologis berbasis mindfulness juga telah menjadi intervensi populer dalam pengelolaan menopause. Mindfulness adalah bentuk latihan meditasi yang berfokus pada kesadaran penuh dan penerimaan terhadap berbagai pengalaman, baik fisik maupun emosional, tanpa memberikan penilaian negatif atau berusaha menghindarinya. Dalam konteks menopause, mindfulness mengajarkan perempuan untuk menerima gejala-gejala menopause yang muncul, seperti hot flashes atau perubahan mood, sebagai bagian alami dari pengalaman hidup, sehingga mengurangi respons emosional negatif yang biasanya muncul bersamaan dengan gejala-gejala tersebut. Praktik mindfulness yang rutin membantu perempuan untuk tidak lagi merasa takut atau panik ketika mengalami gejala yang tidak nyaman, tetapi justru mampu menerima perubahan tersebut dengan sikap yang lebih tenang dan rasional. Dengan latihan mindfulness secara teratur, perempuan mengalami penurunan stres secara signifikan, merasa lebih tenang dalam menghadapi tantangan emosional, serta mampu meningkatkan kualitas tidur yang sering kali terganggu selama menopause.

Intervensi psikologis ini akan semakin efektif bila diiringi dengan dukungan emosional yang kuat dari keluarga dan komunitas. Dukungan keluarga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membantu perempuan melewati masa menopause secara positif dan optimis. Keluarga yang memahami kondisi emosional perempuan selama masa transisi ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan, seperti rasa aman, kasih sayang, empati, serta validasi terhadap berbagai perasaan yang dialami. Dukungan keluarga yang kuat juga membantu perempuan merasa lebih dihargai, dimengerti, serta didukung dalam menghadapi perubahan emosional dan fisik yang terjadi, yang secara langsung mengurangi dampak negatif psikologis menopause. Keluarga yang suportif juga membantu perempuan mempertahankan rasa percaya diri, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan emosional yang sehat selama masa transisi ini.

Di samping dukungan keluarga, peran komunitas dan jaringan sosial juga tidak boleh diabaikan. Bergabung dengan kelompok dukungan menopause, baik secara tatap muka maupun melalui platform online, memberikan manfaat besar bagi perempuan dalam mengelola berbagai gejala emosional dan psikologis yang timbul. Kelompok dukungan tersebut menyediakan kesempatan untuk berbagi pengalaman, mendengarkan cerita dan solusi dari perempuan lain yang mengalami tantangan serupa, serta membangun rasa solidaritas dan pemahaman bersama. Interaksi sosial dalam komunitas ini terbukti efektif dalam mengurangi perasaan

isolasi atau kesepian, serta membantu perempuan merasa lebih kuat dan percaya diri dalam menghadapi perubahan selama menopause. Dengan dukungan komunitas yang aktif, perempuan akan lebih mudah menerima dan menjalani masa transisi menopause dengan lebih positif, penuh pengertian, dan memiliki perspektif yang lebih luas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi.

F. Terapi Komplementer dan Alternatif dalam Menopause

Terapi komplementer dan alternatif semakin banyak diminati sebagai pilihan tambahan dalam pengelolaan gejala menopause, terutama oleh perempuan yang ingin menghindari penggunaan terapi hormonal maupun obat-obatan farmakologis. Terapi ini mencakup berbagai metode pengobatan yang berasal dari praktik tradisional maupun pendekatan holistik, yang bertujuan memberikan kenyamanan fisik, meningkatkan keseimbangan emosional, serta memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Di antara terapi yang paling populer dan banyak digunakan dalam konteks menopause adalah aromaterapi, penggunaan herbal atau fitoestrogen, terapi pijat, serta berbagai bentuk pengobatan alternatif lainnya.

Aromaterapi merupakan salah satu metode terapi komplementer yang banyak digunakan untuk meredakan gejala-gejala menopause, khususnya yang berkaitan dengan ketidaknyamanan fisik dan gangguan emosional seperti kecemasan, stres, serta insomnia. Aromaterapi bekerja dengan memanfaatkan minyak esensial dari tumbuhan tertentu yang memiliki efek menenangkan, menstabilkan suasana hati, serta merangsang respons positif secara fisiologis maupun psikologis. Minyak esensial seperti lavender, chamomile, peppermint, rose, dan geranium dikenal luas memiliki khasiat terapeutik yang membantu mengurangi ketegangan emosional, meningkatkan relaksasi, serta memperbaiki pola tidur perempuan menopause. Lavender, misalnya, secara ilmiah terbukti efektif dalam meredakan kecemasan dan insomnia dengan cara meningkatkan aktivitas sistem saraf parasimpatis, yang membantu tubuh untuk merasa lebih rileks. Dalam praktik aromaterapi, minyak esensial tersebut digunakan melalui berbagai metode seperti inhalasi langsung, difusi dengan menggunakan diffuser, atau aplikasi langsung pada kulit dengan campuran minyak pembawa (carrier oil). Penggunaan aromaterapi secara rutin selama masa menopause membantu perempuan merasa lebih tenang, stabil secara emosional, dan mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik, sehingga secara keseluruhan mampu memperbaiki kualitas hidup mereka.

Selain aromaterapi, penggunaan herbal atau fitoestrogen juga menjadi salah satu pilihan terapi komplementer yang banyak dipilih oleh perempuan selama masa menopause. Fitoestrogen adalah senyawa alami yang terdapat dalam tumbuhan yang secara struktural mirip dengan estrogen tubuh manusia, sehingga mampu

berikatan dengan reseptor estrogen dan menghasilkan efek hormonal yang ringan. Beberapa tanaman herbal yang umum digunakan sebagai sumber fitoestrogen antara lain kedelai (soybean), biji rami (flaxseed), semanggi merah (red clover), serta akar black cohosh. Konsumsi fitoestrogen dipercaya membantu mengurangi berbagai gejala menopause seperti hot flashes, keringat malam hari, gangguan mood, serta kekeringan vagina yang terjadi akibat penurunan kadar estrogen secara alami. Secara khusus, konsumsi rutin makanan atau suplemen berbahan dasar kedelai terbukti efektif dalam meredakan frekuensi dan intensitas hot flashes pada banyak perempuan, serta memberikan manfaat tambahan dalam menjaga kepadatan tulang yang biasanya menurun pada masa menopause. Namun, penting bagi perempuan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan produk herbal, terutama jika mereka memiliki riwayat medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan lain, agar penggunaan fitoestrogen dapat dilakukan secara aman dan optimal.

Terapi pijat juga menjadi bagian penting dalam pendekatan komplementer dalam manajemen gejala menopause, terutama dalam mengatasi keluhan fisik seperti nyeri otot, ketegangan tubuh, serta gangguan tidur yang kerap muncul selama periode ini. Terapi pijat bekerja dengan cara merangsang pelepasan hormon endorfin dalam tubuh, yang secara alami membantu mengurangi rasa nyeri serta memberikan efek relaksasi mendalam. Berbagai teknik pijat seperti pijat refleksi, pijat aromaterapi, pijat jaringan dalam (deep tissue massage), serta pijat tradisional dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perempuan menopause. Secara khusus, pijat aromaterapi yang memadukan manfaat minyak esensial dengan teknik pijat lembut telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, memperbaiki sirkulasi darah, serta meningkatkan kualitas tidur pada perempuan menopause. Terapi pijat secara rutin tidak hanya membantu perempuan meredakan gejala fisik, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam memperbaiki kondisi emosional, memberikan rasa nyaman dan rileks, serta membantu mereka menjalani masa transisi menopause dengan lebih nyaman dan positif.

Selain aromaterapi, fitoestrogen, dan terapi pijat, berbagai terapi alternatif lainnya juga digunakan oleh perempuan selama menopause untuk mengelola gejala klinis mereka secara alami dan holistik. Salah satu terapi yang cukup dikenal adalah akupunktur, metode pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum halus yang ditusukkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Akupunktur dipercaya mampu mengembalikan keseimbangan energi (Qi) dalam tubuh, yang secara langsung dapat meredakan berbagai gejala menopause seperti hot flashes, gangguan tidur, kecemasan, serta depresi ringan. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani sesi akupunktur secara rutin merasakan peningkatan

signifikan dalam kesejahteraan fisik dan emosional selama menopause. Akupunktur juga terbukti membantu mengurangi intensitas hot flashes dan meningkatkan kualitas tidur secara efektif.

Selain itu, terapi mind-body seperti meditasi, yoga, dan tai chi juga populer dalam pengelolaan menopause. Praktik meditasi secara teratur membantu perempuan mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesadaran diri, serta memperkuat resiliensi emosional selama masa transisi. Yoga, yang mengombinasikan latihan fisik lembut dengan teknik pernapasan dan meditasi, memberikan manfaat tambahan dalam menjaga fleksibilitas tubuh, meningkatkan keseimbangan emosional, serta memperbaiki kualitas tidur. Tai chi, seni bela diri lembut asal Tiongkok yang berfokus pada gerakan lambat dan terkendali, juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause dengan memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan, serta meredakan stres secara signifikan.

G. Integrasi Pendekatan Farmakologis dalam Pendekatan Holistik

Pengelolaan menopause secara holistik memang lebih menekankan pada pendekatan alami, non-invasif, dan minim efek samping yang mencakup berbagai strategi non-farmakologis, terapi komplementer, serta dukungan psikologis dan sosial. Akan tetapi, dalam beberapa situasi tertentu, pendekatan farmakologis, khususnya terapi pengganti hormon (Hormone Replacement Therapy, HRT), diperlukan sebagai intervensi tambahan yang penting dan relevan untuk mengelola gejala klinis menopause yang berat dan signifikan, yang sulit diatasi dengan metode lainnya.

Terapi pengganti hormon atau HRT adalah penggunaan hormon sintetis atau hormon alami yang menyerupai hormon estrogen dan progesteron tubuh, yang diberikan kepada perempuan dalam masa menopause dengan tujuan untuk menggantikan kadar hormon yang mengalami penurunan secara signifikan. Penurunan kadar hormon ini adalah penyebab utama dari munculnya berbagai gejala klinis seperti hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, kekeringan vagina, hingga gangguan seksual yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari serta kualitas hidup perempuan menopause. Oleh karena itu, ketika gejala tersebut berada pada tingkat yang parah, menimbulkan gangguan signifikan terhadap fungsi sosial, fisik, maupun psikologis, penggunaan HRT menjadi opsi penting yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Secara kritis, pendekatan farmakologis melalui HRT perlu diterapkan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi klinis perempuan tersebut, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga, faktor risiko individu, serta manfaat dan risiko

potensial dari terapi tersebut. HRT umumnya direkomendasikan pada perempuan yang mengalami gejala menopause yang berat, seperti hot flashes parah yang menyebabkan gangguan tidur kronis, kecemasan, depresi signifikan, penurunan kualitas hidup yang nyata, serta risiko osteoporosis yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, manfaat dari HRT seperti pengurangan gejala klinis yang dramatis, peningkatan kualitas tidur, stabilitas emosional, serta perlindungan terhadap kepadatan tulang jelas lebih besar dibandingkan risikonya. Namun, perlu dicatat bahwa HRT juga memiliki beberapa risiko, seperti peningkatan risiko kanker payudara, gangguan kardiovaskular (seperti trombosis vena dalam dan stroke), serta potensi masalah hati pada penggunaan jangka panjang. Oleh sebab itu, penggunaan HRT harus selalu diawali dengan evaluasi menyeluruh oleh tenaga kesehatan profesional yang berpengalaman, meliputi pemeriksaan fisik, skrining kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, riwayat kanker payudara, dan riwayat keluarga terkait gangguan hormonal.

Integrasi pendekatan farmakologis dalam kerangka pendekatan holistik dilakukan dengan menempatkan terapi hormon sebagai salah satu elemen pelengkap, bukan sebagai satu-satunya solusi yang berdiri sendiri. Artinya, ketika perempuan memutuskan untuk menjalani terapi hormon, maka pendekatan tersebut harus disertai dengan berbagai strategi non-farmakologis yang mendukung secara komprehensif aspek fisik, emosional, dan sosial perempuan selama menopause. Misalnya, ketika seseorang perempuan mulai menggunakan HRT, mereka tetap dianjurkan menjalani gaya hidup sehat dengan nutrisi seimbang, olahraga teratur seperti jalan kaki atau yoga untuk menjaga berat badan ideal dan kesehatan jantung, serta praktik mindfulness atau meditasi untuk mendukung keseimbangan emosional. Dengan demikian, efek positif dari terapi hormon akan diperkuat oleh intervensi holistik lainnya, sehingga pendekatan ini mampu memberikan manfaat maksimal dan menyeluruh kepada perempuan menopause.

Di samping itu, integrasi pendekatan farmakologis dalam pendekatan holistik juga berarti bahwa terapi hormon diberikan dengan dosis seminimal mungkin dalam durasi sesingkat yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, tenaga kesehatan akan selalu memantau perkembangan kondisi pasien secara rutin, mengevaluasi respons terhadap terapi secara berkala, serta menyesuaikan dosis atau jenis hormon sesuai kebutuhan. Pada tahap tertentu, saat gejala klinis mulai mereda atau terkontrol dengan baik melalui pendekatan komplementer dan non-farmakologis lainnya, maka terapi hormon dapat secara bertahap dikurangi atau bahkan dihentikan sepenuhnya. Dalam proses ini, perempuan tetap mendapatkan dukungan secara psikologis melalui konseling reguler, edukasi kesehatan, serta pemberian motivasi

agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pengobatan farmakologis, melainkan mampu memanfaatkan metode alami dan holistik secara optimal.

Dalam konteks ini, pendekatan farmakologis yang terintegrasi secara hati-hati ke dalam pendekatan holistik mampu menjawab kebutuhan perempuan menopause dengan sangat baik. Integrasi ini memastikan bahwa perempuan mendapatkan intervensi medis yang dibutuhkan untuk mengatasi gejala berat, sekaligus tetap menjaga kesehatan jangka panjang melalui gaya hidup sehat, terapi komplementer, serta penguatan aspek psikososial. Dengan demikian, perempuan tidak hanya bebas dari gejala klinis menopause yang mengganggu, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi secara keseluruhan, yang mencakup keseimbangan fisik, emosional, sosial, dan spiritual dalam menghadapi periode menopause dengan lebih nyaman, aman, serta positif.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pendampingan Holistik

Dalam pendekatan holistik terhadap menopause, peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting karena mereka bertindak sebagai fasilitator utama dalam memberikan pendampingan yang komprehensif, menyeluruh, dan terpadu. Berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, serta ahli gizi, berkolaborasi secara interprofesional untuk memastikan perempuan menopause menerima dukungan yang optimal dari segala aspek kehidupan—fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada mengatasi gejala klinis, melainkan juga memastikan kualitas hidup perempuan selama periode transisi menopause benar-benar terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Dokter, terutama dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), memainkan peran sentral dalam tim pendampingan menopause. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi klinis secara menyeluruh, meliputi anamnesis mendalam tentang riwayat kesehatan, riwayat keluarga, serta berbagai keluhan fisik dan emosional yang dialami perempuan menopause. Dokter juga memiliki peran penting dalam menentukan jenis terapi yang tepat, termasuk kapan pendekatan farmakologis, seperti terapi pengganti hormon, diperlukan. Selain itu, dokter bertugas untuk mengawasi efek terapi yang diberikan secara ketat, memastikan keamanan penggunaannya, serta mengintegrasikan metode medis dengan strategi non-farmakologis lainnya, sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan risiko minimal. Dokter juga aktif memberikan edukasi kesehatan secara komprehensif tentang berbagai perubahan fisiologis yang terjadi selama menopause, potensi risiko penyakit degeneratif, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin agar kondisi pasien tetap terpantau dengan baik.

Bidan berperan strategis dalam mendampingi perempuan yang menjalani masa menopause, terutama dalam konteks layanan kesehatan komunitas maupun primer. Pendampingan oleh bidan mencakup pemberian edukasi secara luas mengenai perubahan tubuh yang terjadi selama menopause serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Dengan pendekatan empati dan komunikasi yang baik, bidan memberikan edukasi praktis yang mudah dipahami perempuan, seperti pengaturan pola hidup sehat, cara mengatasi gejala menopause secara alami melalui aktivitas fisik ringan, teknik relaksasi, serta perubahan pola makan yang lebih sehat. Bidan juga berperan aktif dalam menghubungkan perempuan menopause dengan sumber daya kesehatan lainnya, termasuk pelayanan psikologis maupun gizi, sehingga pendekatan terpadu dapat terwujud secara optimal. Lebih jauh lagi, bidan memberikan pendampingan emosional, yang membantu perempuan untuk mengelola stres dan kecemasan yang sering kali menyertai menopause, sehingga perempuan merasa didukung secara psikologis selama periode ini.

Perawat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pendampingan holistik pada perempuan menopause, terutama dalam hal perawatan sehari-hari maupun pengawasan rutin yang intensif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi fisik perempuan menopause, seperti pengukuran tekanan darah, berat badan, evaluasi kepadatan tulang, serta identifikasi dini terhadap risiko gangguan kesehatan seperti osteoporosis atau penyakit jantung. Selain itu, perawat juga membantu perempuan dalam mengimplementasikan berbagai intervensi yang telah direkomendasikan oleh dokter maupun bidan, seperti melakukan latihan fisik ringan secara rutin, mempraktikkan teknik relaksasi atau meditasi, serta memberikan edukasi praktis mengenai gejala-gejala klinis yang muncul selama menopause dan cara penanganannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendampingan perawat yang konsisten, perempuan menopause dapat merasa lebih percaya diri dalam mengelola kondisi kesehatan mereka sendiri, sekaligus merasakan kehadiran dukungan yang nyata dari tenaga kesehatan.

Psikolog memiliki peran khusus yang sangat vital dalam membantu perempuan menopause menghadapi perubahan emosional dan psikologis yang seringkali muncul secara signifikan selama periode ini. Psikolog secara aktif memberikan intervensi psikologis berupa konseling individu maupun kelompok, cognitive-behavioral therapy (CBT), mindfulness, serta berbagai teknik psikoterapi lainnya untuk membantu perempuan mengelola emosi negatif seperti kecemasan, depresi, atau perasaan rendah diri yang muncul akibat perubahan fisik yang dialami. Melalui konseling rutin, perempuan menopause dibantu untuk mengembangkan mekanisme koping yang lebih sehat, meningkatkan resiliensi psikologis, serta

mempertahankan keseimbangan emosional dalam menghadapi perubahan hidup yang dinamis. Selain itu, psikolog juga terlibat dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan pasangan perempuan menopause tentang cara memberikan dukungan emosional yang efektif, sehingga terbentuk lingkungan sosial yang suportif dan kondusif untuk kesehatan mental dan emosional perempuan menopause.

Ahli gizi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pendekatan holistik terhadap menopause melalui edukasi dan intervensi nutrisi yang tepat. Ahli gizi melakukan evaluasi terhadap pola makan, status gizi, serta kebutuhan nutrisi spesifik perempuan menopause yang mengalami perubahan metabolisme tubuh secara alami. Melalui pendampingan ahli gizi, perempuan mendapatkan rekomendasi tentang pola makan yang optimal untuk membantu mengurangi berbagai gejala klinis menopause seperti hot flashes, kelelahan, peningkatan berat badan, serta risiko osteoporosis. Edukasi yang diberikan mencakup peningkatan konsumsi kalsium, vitamin D, serat, protein sehat, serta fitoestrogen dari sumber alami seperti kedelai dan biji-bijian tertentu. Ahli gizi juga berperan dalam mendesain program diet sehat jangka panjang yang memperhatikan kebutuhan individu masing-masing perempuan, termasuk rekomendasi asupan cairan yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh serta mencegah risiko penyakit kronis lainnya. Dengan bimbingan ahli gizi, perempuan menopause dapat menjaga kesehatan fisiknya secara optimal sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

I. Simpulan

Pengelolaan gejala klinis menopause secara holistik merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada penanganan medis atau biologis semata, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, emosional, sosial, dan spiritual perempuan. Menopause, sebagai proses fisiologis alamiah dalam kehidupan seorang perempuan, sering kali disertai berbagai gejala yang kompleks seperti hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, penurunan libido, serta keluhan fisik lainnya. Pendekatan holistik memberikan solusi yang lebih lengkap dan menyeluruh, dengan mengintegrasikan berbagai strategi non-farmakologis seperti nutrisi sehat, olahraga, yoga, meditasi, teknik relaksasi, serta terapi komplementer seperti aromaterapi, herbal, pijat, dan akupunktur.

Selain itu, intervensi psikologis dan dukungan emosional juga menjadi elemen kunci dalam pendekatan ini. Konseling psikologis, cognitive-behavioral therapy (CBT), mindfulness, serta dukungan keluarga dan komunitas terbukti efektif dalam membantu perempuan mengatasi dampak emosional dan psikologis menopause, seperti kecemasan, depresi, serta perasaan rendah diri. Integrasi pendekatan

farmakologis melalui terapi pengganti hormon (HRT) tetap relevan dalam situasi tertentu yang membutuhkan intervensi medis tambahan, namun penggunaannya harus dilakukan secara kritis, hati-hati, dan selalu dalam konteks pendekatan holistik yang mengutamakan keseimbangan keseluruhan aspek kehidupan perempuan.

Peran tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, serta ahli gizi menjadi sangat strategis dalam memberikan pendampingan yang menyeluruh kepada perempuan menopause. Kolaborasi interprofesional ini memastikan perempuan mendapatkan dukungan fisik, psikologis, emosional, dan sosial secara optimal. Dengan pendekatan holistik ini, perempuan tidak hanya mampu mengelola gejala menopause secara efektif, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan, menjalani masa transisi ini dengan nyaman, percaya diri, dan penuh makna.

J. Referensi

-
- Avis, N. E., Crawford, S. L., Greendale, G., Bromberger, J. T., Everson-Rose, S. A., Gold, E. B., ... Thurston, R. C. (2015). Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. *JAMA Internal Medicine*, 175(4), 531–539. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.8063>
- Borrelli, F., & Ernst, E. (2010). Alternative and complementary therapies for menopause. *Maturitas*, 66(4), 333–343. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2010.05.010>
- Daley, A., MacArthur, C., Mutrie, N., & Stokes-Lampard, H. (2007). Exercise for vasomotor menopausal symptoms. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007(4), CD006108. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006108.pub2>
- Freeman, E. W., Sammel, M. D., & Sanders, R. J. (2014). Risk of long-term hot flashes after natural menopause: Evidence from the Penn Ovarian Aging Study cohort. *Menopause*, 21(9), 924–932. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000196>
- Hunter, M. S., & Smith, M. (2017). Cognitive behavioural interventions for menopausal symptoms. *Climacteric*, 20(2), 95–100. <https://doi.org/10.1080/13697137.2017.1279145>
- Johnson, A., Roberts, L., & Elkins, G. (2019). Complementary and alternative medicine for menopause. *Journal of Evidence-Based Integrative Medicine*, 24, 1–14. <https://doi.org/10.1177/2515690X19829380>
- Lobo, R. A., Davis, S. R., De Villiers, T. J., Gompel, A., Henderson, V. W., Hodis, H. N., ... Baber, R. J. (2014). Prevention of diseases after menopause. *Climacteric*, 17(5), 540–556. <https://doi.org/10.3109/13697137.2014.933411>

- North American Menopause Society. (2017). Nonhormonal management of menopause-associated vasomotor symptoms: 2015 position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 24(6), 728–753. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000869>
- Pinkerton, J. V., & Stovall, D. W. (2010). Is complementary and alternative medicine effective for menopausal symptoms? *Obstetrics & Gynecology Clinics of North America*, 37(3), 469–489. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2010.05.003>
- Santoro, N., Epperson, C. N., & Mathews, S. B. (2015). Menopausal symptoms and their management. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, 44(3), 497–515. <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2015.05.001>
- Simon, J. A., Kaunitz, A. M., Kroll, R., Graham, S., Bernick, B., & Mirkin, S. (2018). Oral 17 β -estradiol/progesterone (TX-001HR) and quality of life in menopausal women with vasomotor symptoms. *Menopause*, 26(5), 506–512. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001274>
- Stubbs, C., Mattingly, L., Crawford, S. A., Wickersham, E. A., & Brockhaus, J. L. (2017). Do complementary health approaches improve menopause-related symptoms? *Journal of Complementary and Integrative Medicine*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1515/jcim-2016-0107>
- Taylor-Swanson, L., Wong, A. E., & Pincus, D. (2018). Mind-body therapies for menopausal symptoms: A systematic review. *Menopause*, 25(9), 1057–1068. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001125>
- The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. (2017). The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 24(7), 728–753. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000921>
- Woods, N. F., & Mitchell, E. S. (2005). Symptoms during the perimenopause: Prevalence, severity, trajectory, and significance in women's lives. *The American Journal of Medicine*, 118(12B), 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.09.031>
- World Health Organization. (1996). Research on the menopause in the 1990s: Report of a WHO scientific group (WHO Technical Report Series No. 866). World Health Organization.

K. Glosarium

- **Menopause**

Periode dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron.

- **Hot Flashes**

Sensasi panas yang muncul secara tiba-tiba, terutama pada area wajah, leher, dan dada, yang disertai dengan kemerahan kulit dan keringat berlebihan, sering dialami selama masa menopause.

- **Terapi Pengganti Hormon (Hormone Replacement Therapy - HRT)**

Terapi medis yang menggunakan hormon sintetis atau alami untuk menggantikan hormon estrogen dan progesteron yang menurun secara signifikan selama menopause, bertujuan meredakan gejala-gejala berat menopause.

- **Pendekatan Holistik**

Metode penanganan yang melihat individu secara utuh, mencakup dimensi fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual, dalam mengelola kesehatan dan kesejahteraan selama menopause.

- **Fitoestrogen**

Senyawa alami dari tumbuhan yang secara struktural mirip hormon estrogen manusia, banyak terdapat pada kedelai, biji rami, semanggi merah, dan digunakan untuk membantu meredakan gejala menopause.

- **Mindfulness**

Praktik meditasi yang berfokus pada kesadaran penuh akan pengalaman saat ini tanpa memberikan penilaian negatif, yang efektif dalam membantu mengelola stres dan gejala emosional menopause.

- **Akupunktur**

Metode terapi tradisional Tiongkok dengan menusukkan jarum halus pada titik-titik tertentu di tubuh untuk memperbaiki aliran energi dan keseimbangan hormonal, membantu meredakan gejala menopause seperti hot flashes dan insomnia.

- **Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)**

Metode intervensi psikologis yang bertujuan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku maladaptif, membantu perempuan menghadapi tantangan emosional selama menopause.

- **Meditasi**

Latihan konsentrasi dan relaksasi yang bertujuan untuk menenangkan pikiran, meredakan stres, dan memperbaiki keseimbangan emosional, banyak digunakan dalam pendekatan non-farmakologis menopause.

- **Teknik Relaksasi**

Berbagai metode yang membantu tubuh dan pikiran untuk mencapai kondisi rileks, seperti pernapasan dalam, visualisasi positif, guided imagery, dan progressive muscle relaxation, efektif mengurangi stres dan gejala menopause.

CHAPTER 3

SKRINING KESEHATAN PADA MASA PERIMENOPAUSE DAN POSTMENOPAUSE

Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa perimenopause dan postmenopause adalah fase biologis yang ditandai berakhirnya fungsi reproduksi ovarium, tetapi dampaknya jauh melampaui sistem reproduksi. Di perimenopause, yaitu periode transisi yang dapat berlangsung beberapa tahun sebelum haid benar-benar berhenti, jumlah folikel ovarium menurun dan respons ovarium terhadap hormon perangsang FSH menjadi tidak stabil. Hasilnya adalah produksi estrogen dan progesteron yang fluktuatif: siklus dapat memendek lalu memanjang, perdarahan bisa lebih banyak atau jarang, dan gejala vasomotor seperti rasa panas mendadak serta keringat malam muncul karena pusat termoregulasi di hipotalamus menjadi lebih sensitif pada perubahan kecil kadar estrogen. Pada saat yang sama, terjadi perubahan kualitas tidur seperti sulit mulai tidur atau sering terbangun, perubahan suasana hati, mudah cemas, dan gangguan konsentrasi. Ini merupakan kombinasi efek neuroendokrin yang melibatkan serotonin, GABA, dan katekolamin serta faktor psikososial.

Memasuki postmenopause, yang didefinisikan setelah 12 bulan berturut-turut tanpa menstruasi, penurunan estrogen menjadi menetap. Kekurangan estrogen mempercepat pergantian tulang ke arah resorpsi sehingga densitas mineral tulang menurun dan risiko fraktur terutama pada vertebra, panggul, dan pergelangan tangan meningkat. Di jaringan urogenital, epitel vagina menipis, lubrikasi berkurang, elastisitas menurun, dan pH meningkat. Kondisi ini memunculkan gejala yang kini disebut sindrom genitourinaria menopause berupa rasa kering, nyeri saat berhubungan, sering berkemih, urgensi, serta kecenderungan infeksi saluran kemih berulang. Pada sistem kardiometabolik, redistribusi lemak ke pola abdominal atau visceral makin nyata, sensitivitas insulin menurun, profil lipid cenderung lebih aterogenik dengan LDL meningkat dan HDL menurun, trigliserida dapat bertambah, dan tekanan darah lebih mudah meningkat. Perubahan kulit seperti penurunan kolagen dan elastin, penipisan rambut, mata kering, keluhan rongga mulut, serta perubahan pendengaran juga dapat dirasakan sebagian perempuan. Tidak semua gejala dialami dengan derajat yang sama karena variasi genetik, gaya hidup, komorbid, dan faktor sosial menentukan spektrum serta intensitasnya.

Dalam konteks perubahan seluas ini, skrining kesehatan memegang peran sentral bukan hanya untuk mencari penyakit, tetapi untuk memetakan risiko, mencegah progresi, dan menjaga kualitas hidup. Skrining bekerja pada tiga lapis. Lapis pertama adalah deteksi dini penyakit yang sering meningkat setelah menopause ketika intervensi awal memberi dampak terbesar, misalnya hipertensi, dislipidemia, pradiabetes atau diabetes, dan kanker tertentu seperti payudara, kolorektal, serta serviks sesuai riwayat. Lapis kedua adalah penilaian risiko agar pencegahan bersifat personal, meliputi evaluasi faktor risiko kardiovaskular seperti riwayat keluarga, kebiasaan merokok, indeks massa tubuh dan lingkar perut, risiko jatuh dan fraktur melalui riwayat fraktur serta penggunaan obat tertentu dan status penglihatan, juga penilaian gejala genitourinaria, suasana hati, tidur, dan fungsi kognitif berdasarkan keluhan. Lapis ketiga adalah pemantauan tindak lanjut sehingga upaya pencegahan dan terapi benar-benar berujung pada hasil klinis, bukan hanya perbaikan angka laboratorium di atas kertas.

Dari perspektif praktis, kunjungan skrining yang teratur pada fase ini memungkinkan penyusunan rencana kesehatan yang komprehensif. Pemeriksaan tekanan darah, profil lipid, glukosa puasa atau HbA1c, berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang membantu memutuskan kapan konseling gaya hidup saja cukup dan kapan dibutuhkan farmakoterapi seperti statin atau terapi antihipertensi. Penilaian risiko osteoporosis dengan FRAX dan atau DXA mengarahkan intervensi nutrisi berupa kalsium dan vitamin D, latihan berbeban yang bergradasi, pencegahan jatuh, hingga terapi antiresorptif bila perlu. Skrining kanker payudara dengan mammografi sesuai usia dan risiko, skrining kanker serviks dengan Pap atau HPV mengikuti riwayat sebelumnya, serta skrining kanker kolorektal dengan tes darah samar tinja atau kolonoskopi sesuai pedoman menggeser fokus dari terlambat mengobati menjadi lebih awal mencegah. Keluhan tidur, nyeri sendi, perubahan suasana hati, penurunan hasrat seksual, atau keluhan berkemih yang kerap dianggap wajar karena usia seharusnya diangkat dalam percakapan skrining karena respons terapeutiknya nyata, mulai dari edukasi dan modifikasi perilaku, pelumas atau estrogen lokal untuk gejala urogenital, sampai terapi non hormonal atau hormonal yang dipilih hati-hati berdasarkan profil risiko manfaat individu.

Manfaat skrining bagi kualitas hidup terasa pada dua hal, yaitu rasa kontrol dan kejelasan. Rasa kontrol berarti perempuan mengetahui apa yang terjadi di tubuhnya dan tindakan apa yang bisa diambil hari ini seperti mengatur pola makan, memperbaiki tidur, latihan kekuatan dan keseimbangan, berhenti merokok, mengurangi alkohol, latihan dasar panggul, serta vaksinasi yang sesuai sebelum perubahan kecil menjadi masalah besar. Kejelasan berarti mengurangi

ketidakpastian. Nyeri muskuloskeletal atau palpitasi yang menimbulkan cemas dapat dievaluasi secara sistematis, sehingga intervensi tepat sasaran dan beban kecemasan berkurang. Kombinasi keduanya meningkatkan partisipasi sosial, produktivitas, dan kepuasan hidup, bukan semata-mata memperpanjang umur.

B. Tujuan Skrining Kesehatan

Tujuan utama skrining pada masa perimenopause dan postmenopause adalah menjaga kesehatan sebelum masalah muncul dan menemukan kelainan sedini mungkin ketika peluang pemulihan masih tinggi. Dua sasaran ini berjalan beriringan. Skrining yang bersifat preventif memberikan potret risiko personal agar pencegahan dapat ditargetkan, sedangkan skrining untuk deteksi dini bertujuan menangkap penyakit pada fase pra gejala atau stadium awal sehingga terapi menjadi lebih sederhana, lebih efektif, serta menghindari kecacatan dan kematian yang tidak perlu.

Pada ranah preventif, skrining membantu menyusun peta risiko individual yang akurat. Di periode perimenopause dan postmenopause, penurunan estrogen dan perubahan komposisi tubuh meningkatkan kerentanan terhadap penyakit kardiometabolik, osteoporosis, dan gangguan urogenital. Melalui pengukuran sederhana seperti tekanan darah, profil lipid, glukosa puasa atau HbA1c, indeks massa tubuh dan lingkar perut, serta penilaian gaya hidup seperti kebiasaan merokok, aktivitas fisik, pola makan, dan konsumsi alkohol, tenaga kesehatan dapat menghitung risiko kejadian jantung atau stroke dalam 10 tahun mendatang. Informasi ini bukan sekadar angka di lembar hasil, melainkan kompas yang mengarahkan intervensi. Seorang perempuan dengan risiko kardiovaskular tinggi misalnya akan mendapat konseling intensif tentang nutrisi, program latihan yang realistis, serta, bila ambang tertentu terlampaui, terapi farmakologis seperti antihipertensi atau statin. Pada tulang, penilaian risiko fraktur melalui skor klinis atau pemeriksaan densitas tulang memandu langkah nutrisi kalsium dan vitamin D, latihan beban dan keseimbangan, koreksi gangguan penglihatan, penataan obat yang meningkatkan risiko jatuh, hingga terapi antiresorptif bila diindikasikan. Di area urogenital, anamnesis terarah atas gejala kering dan nyeri, disertai pemeriksaan fisik, mengarahkan penggunaan intervensi sederhana seperti pelumas, latihan dasar panggul, atau estrogen lokal yang aman bagi mayoritas perempuan. Seluruh tindakan preventif ini bertujuan memutus jalur lahirnya penyakit berat, bukan menunggu masalah menjadi kompleks.

Deteksi dini bekerja melalui apa yang disebut jendela kesempatan. Banyak penyakit memiliki fase laten yang cukup panjang sebelum menimbulkan keluhan. Kanker kolorektal misalnya umumnya bermula dari polip adenomatosa yang tidak menimbulkan gejala bertahun-tahun. Skrining tinja darah samar atau kolonoskopi

pada kelompok usia dan risiko yang tepat memungkinkan polip diangkat sebelum bertransformasi menjadi kanker, sehingga skrining tidak hanya menurunkan kematian, tetapi juga kejadian penyakit itu sendiri. Pada kanker serviks, deteksi dini perubahan prakanker melalui pemeriksaan sitologi atau tes HPV memungkinkan tindakan ablasi atau eksisi yang minimal dengan angka kesembuhan tinggi dan pelestarian fungsi. Mammografi pada kelompok yang sesuai menangkap lesi yang masih kecil dan belum meluas ke kelenjar getah bening, sehingga pilihan terapi lebih konservatif, lama rawat lebih pendek, dan beban psikologis lebih ringan. Prinsip yang sama berlaku pada hipertensi dan diabetes melitus. Keduanya kerap berjalan tanpa gejala di awal, padahal kerusakan pembuluh darah, ginjal, dan saraf dapat berlangsung diam-diam. Menemukan kondisi ini lebih awal memberi kesempatan memulai terapi dan perubahan gaya hidup sebelum terjadi komplikasi yang sulit dibalikkan.

Hubungan antara skrining dan penurunan angka morbiditas serta mortalitas dapat dijelaskan melalui beberapa jalur biologis dan sistem layanan. Jalur pertama adalah pergeseran stadium penyakit. Ketika kanker ditemukan pada stadium awal, kuratifitas meningkat dan kebutuhan terapi agresif berkurang. Hasilnya adalah lebih sedikit komplikasi, lebih rendah angka kecacatan, dan harapan hidup yang lebih panjang. Jalur kedua adalah pencegahan kejadian pertama. Mengendalikan tekanan darah, lipid, berat badan, dan gula darah pada perempuan postmenopause secara konsisten terbukti menurunkan kejadian infark miokard, stroke, dan gagal jantung. Jalur ketiga adalah pencegahan kejadian berulang. Perempuan yang sudah pernah mengalami fraktur, misalnya, berisiko tinggi mengalami fraktur berikutnya. Identifikasi dan tata laksana osteoporosis pasca fraktur mengurangi kekambuhan dan mencegah spiral penurunan fungsi yang sering berujung kehilangan kemandirian. Jalur keempat adalah penurunan beban gejala serta peningkatan kualitas hidup. Menangani sindrom genitourinaria menopause secara dini mencegah infeksi saluran kemih berulang, nyeri saat berhubungan, dan gangguan tidur yang berkepanjangan. Pada akhirnya, ketika gejala terkendali, partisipasi sosial, produktivitas, dan suasana hati membaik, yang semuanya berkorelasi dengan luaran kesehatan jangka panjang yang lebih baik.

Skrining yang berdampak harus memerhatikan kualitas alat ukur dan cara menafsir hasil. Sensitivitas dan spesifisitas memengaruhi jumlah temuan yang benar dan salah. Nilai duga positif bergantung pada prevalensi penyakit di kelompok yang diperiksa, sehingga skrining berbasis risiko sering lebih efisien daripada pendekatan serentak untuk semua orang. Interval skrining menentukan keseimbangan antara peluang menemukan kelainan dan potensi beban pemeriksaan yang berlebihan. Sangat penting untuk menilai manfaat dan potensi mudarat secara jujur. Hasil positif

palsu menimbulkan kecemasan, memicu pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu, dan kadang prosedur invasif. Overdiagnosis dapat terjadi jika skrining menemukan kelainan yang tidak akan berkembang menjadi penyakit bermakna sepanjang hidup seseorang. Karena itu, percakapan yang adil tentang manfaat, risiko, dan preferensi pasien merupakan bagian integral dari tujuan skrining, sehingga keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan nilai dan prioritas perempuan yang menjalani pemeriksaan.

Dampak skrining terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh seberapa baik sistem menindaklanjuti hasil. Pemeriksaan yang baik tanpa jalur tindak lanjut yang jelas tidak akan menghasilkan perubahan luaran. Setiap program skrining perlu memastikan tiga hal. Pertama, hasil dibahas bersama pasien secara mudah dipahami dengan rencana tindakan yang spesifik. Kedua, rujukan untuk pemeriksaan konfirmasi dan terapi tersedia, dapat dijangkau, dan terlacak penyelesaiannya. Ketiga, ada pemantauan berkala yang memeriksa apakah target klinis tercapai dan apakah ada hambatan baru yang perlu diatasi, misalnya efek samping obat, keterbatasan biaya, atau hambatan transportasi. Ketika tiga hal ini terpenuhi, skrining bergerak dari sekadar pencarian ke arah perbaikan nyata pada kesehatan populasi.

Pada level populasi, manfaat skrining terasa dalam bentuk berkurangnya kejadian penyakit lanjut, penurunan kebutuhan perawatan darurat atau rawat inap, serta penghematan biaya kesehatan jangka panjang. Di tingkat individu, manfaatnya terasa sebagai rasa kontrol yang lebih besar atas kondisi sendiri, berkurangnya ketidakpastian, dan arah tindakan yang jelas. Untuk mencapai dua tingkat manfaat ini secara bersamaan, tujuan skrining perlu dipersonalisasi. Perempuan dengan riwayat keluarga kanker payudara mungkin memerlukan strategi deteksi yang berbeda dibanding mereka yang risikonya rata-rata. Perempuan dengan penyakit kardiovaskular atau autoimun, atau yang menggunakan obat tertentu, memerlukan penekanan khusus pada aspek keselamatan dan interaksi terapi. Personalisasi memastikan skrining tidak menjadi beban, melainkan investasi yang relevan bagi kesehatan masing-masing orang.

C. Landasan Ilmiah Skrining pada Perimenopause dan Postmenopause

Landasan skrining pada perimenopause dan postmenopause berawal dari perubahan hormonal yang bersifat sistemik dan progresif. Penurunan fungsi folikel ovarium menyebabkan produksi estradiol dan progesteron yang mula-mula berfluktuasi lalu menetap pada kadar rendah setelah menstruasi berhenti selama 12 bulan. Penurunan estradiol mengubah regulasi banyak jaringan karena reseptor estrogen terdapat di tulang, endotel vaskular, miokard, otak, otot rangka, mukosa

urogenital, kulit, dan sistem imun. Pada sistem saraf pusat, perubahan modulasi serotonin, dopamin, dan GABA berperan pada gejala vasomotor, gangguan tidur, kecemasan, dan perubahan kognisi. Di jaringan tulang, estrogen normalnya menekan osteoklas melalui jalur RANKL dan meningkatkan produksi osteoprotegerin. Ketika estrogen rendah, aktivitas osteoklas meningkat, laju resorpsi melampaui formasi, sehingga densitas mineral tulang turun dan mikroarsitektur trabekular melemah. Pada sistem kardiovaskular, estrogen mempromosikan produksi nitric oxide endotel dan menekan endotelin serta peradangan. Kekurangannya menurunkan vasodilatasi, meningkatkan kekakuan arteri, dan mempermudah pembentukan plak aterosklerotik, apalagi bila profil lipid bergeser menjadi lebih aterogenik dengan peningkatan LDL dan penurunan HDL. Di metabolisme glukosa dan lemak, redistribusi lemak menuju depot viseral, penurunan sensitivitas insulin, dan perubahan adipokin meningkatkan risiko sindrom metabolik. Pada traktus urogenital, deprivasi estrogen menipiskan epitel vagina dan uretra, menurunkan lubrikasi dan aliran darah lokal, menaikkan pH, serta mengubah mikrobiota, sehingga muncul sindrom genitourinaria menopause berupa kering, dispareunia, urgensi dan frekuensi berkemih, serta kerentanan infeksi saluran kemih. Selain itu, penurunan kolagen dan elastin memperlemah jaringan penunjang sehingga keluhan dasar panggul seperti inkontinensia dan prolaps lebih sering muncul. Rangkaian mekanisme biologis ini menjelaskan mengapa skrining di periode transisi dan pascamenstruasi bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan untuk menangkap konsekuensi awal dari perubahan endokrin yang menyeluruh.

Implikasi perubahan hormonal tersebut terwujud sebagai kumpulan faktor risiko penyakit yang meningkat setelah perimenopause. Risiko kardiovaskular naik karena kombinasi faktor yang saling memperkuat, yaitu dislipidemia, hipertensi baru atau memburuk, inflamasi vaskular yang lebih aktif, obesitas sentral, dan resistensi insulin. Faktor gaya hidup seperti merokok, diet tinggi gula sederhana dan lemak jenuh, kurang aktivitas fisik, serta konsumsi alkohol mempercepat lintasan ini. Riwayat keluarga penyakit jantung koroner, stroke dini, atau hiperlipidemia familial semakin menambah risiko sehingga skrining tekanan darah, profil lipid, glukosa puasa atau HbA1c, indeks massa tubuh, dan lingkar perut perlu diprioritaskan. Pada tulang, risiko osteoporosis dan fraktur meningkat pada perempuan dengan indeks massa tubuh rendah, asupan kalsium dan vitamin D tidak adekuat, paparan sinar matahari minimal, kurang latihan beban, kebiasaan merokok, serta penggunaan obat yang mempercepat kehilangan tulang seperti glukokortikoid, beberapa antikonvulsan, atau inhibitor aromatase. Riwayat fraktur ringan setelah usia 50 tahun, menopause dini, dan kondisi endokrin seperti hipertiroid atau hiperparatiroid

memperkuat indikasi penilaian risiko dengan kalkulator klinis dan pemeriksaan densitas tulang.

Di bidang onkologi, pola risiko kanker berubah seiring usia dan paparan seumur hidup terhadap hormon, kehamilan, dan menyusui. Risiko kanker payudara meningkat pada perempuan dengan riwayat keluarga derajat pertama, mutasi hereditas tertentu, menarke dini, melahirkan pertama pada usia lanjut, nuliparitas, obesitas, dan konsumsi alkohol. Hal ini mendasari pentingnya mammografi berkala dengan interval disesuaikan tingkat risiko, serta pertimbangan penilaian risiko dengan model yang diakui untuk memutuskan perlunya strategi tambahan. Risiko kanker kolorektal meningkat bersama usia dan terpengaruh pola makan rendah serat tinggi lemak, obesitas, serta riwayat keluarga. Skrining tinja darah samar atau kolonoskopi menurunkan angka kejadian dan kematian karena memungkinkan pengangkatan polip tahap awal. Untuk kanker serviks, kebutuhan skrining bergantung pada riwayat pemeriksaan sebelumnya dan status serviks uteri. Bila riwayat skrining adekuat dan hasil konsisten normal, interval dapat diperpanjang sesuai pedoman, tetapi riwayat paparan faktor risiko seperti imunokompromi menuntut penyesuaian. Risiko kanker endometrium meningkat pada kondisi yang menimbulkan hiperestrogenisme relatif tanpa penyeimbang progesteron seperti obesitas, anovulasi kronis, diabetes, dan penggunaan estrogen tanpa progestin pada perempuan dengan uterus utuh. Edukasi kewaspadaan terhadap perdarahan pascamenopause dan evaluasi segera ketika gejala muncul merupakan bagian dari pendekatan skrining berbasis gejala yang penting.

Komponen risiko lain yang layak diperhitungkan dalam perencanaan skrining adalah kesehatan mental dan tidur. Gangguan cemas, depresi, dan insomnia sering muncul atau memburuk saat transisi hormon dan dapat memperburuk kepatuhan hidup sehat serta kontrol penyakit kardiometabolik. Penilaian singkat dengan instrumen valid, ditambah eksplorasi gejala vasomotor dan kualitas tidur, membantu memutuskan intervensi yang tepat baik nonfarmakologis maupun farmakologis. Kualitas otot dan fungsi fisik juga menurun akibat sarcopenia yang didorong penurunan hormon anabolik, inaktivitas, dan asupan protein yang kurang. Identifikasi dini kelemahan, perlambatan kecepatan berjalan, atau keseimbangan yang buruk memberi kesempatan melakukan latihan kekuatan dan pencegahan jatuh sebelum fraktur terjadi. Keluhan urogenital, termasuk inkontinensia dan infeksi berulang, sering dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima padahal respons terhadap terapi lokal dan latihan dasar panggul umumnya sangat baik. Dengan mengenali faktor risiko tersebut sejak awal, skrining dapat diarahkan pada area yang paling relevan bagi setiap individu.

Pendekatan ilmiah skrining akhirnya bermuara pada personalisasi. Perempuan dengan profil kardiometabolik merugikan memerlukan penekanan pada evaluasi jantung dan metabolik dengan interval lebih rapat, sedangkan perempuan bertubuh kurus dengan riwayat fraktur atau penggunaan glukokortikoid memerlukan prioritas pada penilaian tulang. Mereka yang memiliki riwayat keluarga kanker tertentu atau hasil pemeriksaan sebelumnya yang mencurigakan memerlukan jalur deteksi yang lebih intensif. Sementara itu, keluhan fungsi seksual, nyeri saat berhubungan, dan gejala berkemih yang mengganggu kualitas hidup layak ditangani melalui skrining aktif dan terapi yang aman serta efektif. Inilah alasan mengapa skrining pada perimenopause dan postmenopause tidak bisa bersifat generik. Ia harus dibangun di atas pemahaman mekanisme biologis kekurangan estrogen dan akumulasi faktor risiko usia, lalu diterjemahkan menjadi paket pemeriksaan, konseling, dan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan profil setiap perempuan agar risiko dapat ditekan, penyakit dicegah atau ditemukan dini, serta kualitas hidup tetap terjaga.

D. Jenis Skrining Kesehatan yang Direkomendasikan

Skrining pada masa perimenopause dan postmenopause sebaiknya dipahami sebagai rangkaian pemeriksaan yang saling melengkapi. Tujuannya bukan hanya menemukan penyakit pada tahap awal, tetapi juga memetakan risiko, mengarahkan pencegahan yang tepat, dan menjaga kualitas hidup. Uraian berikut menjelaskan setiap bidang skrining yang relevan, alasan ilmiahnya, cara pelaksanaan yang baik, serta bagaimana menindaklanjuti hasilnya agar pemeriksaan benar-benar bermakna bagi pasien.

Pada kesehatan reproduksi dan organ genital, skrining serviks tetap penting sekalipun aktivitas melahirkan telah berakhir. Pemeriksaan sitologi serviks dengan Pap smear atau pemeriksaan deteksi DNA HPV berperan untuk menemukan perubahan prakanker sebelum berkembang menjadi kanker serviks. Di banyak pedoman mutakhir, tes HPV primer yang diulang berkala dianggap sangat sensitif untuk mendeteksi lesi pra invasif. Alternatifnya, Pap smear konvensional atau sitologi berbasis cairan masih digunakan bila akses ke tes HPV terbatas. Pada perempuan postmenopause, lapisan mukosa serviks dapat menipis sehingga pengambilan sampel terasa kurang nyaman dan hasil bisa kurang adekuat. Keluhan ini dapat diatasi dengan teknik sampling yang lembut, penggunaan spekulum yang tepat ukuran, dan bila perlu pemberian estrogen lokal singkat beberapa hari sebelumnya untuk meningkatkan kecukupan sel. Hasil normal dengan riwayat skrining yang baik memungkinkan interval pemeriksaan diperpanjang sesuai pedoman nasional. Hasil meragukan atau positif diikuti kolposkopi dan tatalaksana sesuai tingkat keparahan lesi. Perlu diingat bahwa perempuan yang menjalani

histerektomi total untuk kondisi jinak dan tidak memiliki riwayat lesi prakanker serviks biasanya tidak lagi memerlukan skrining serviks, sedangkan perempuan dengan risiko tinggi seperti immunosupresi memerlukan jadwal khusus.

Masih pada ranah reproduksi, pemeriksaan payudara dengan mammografi berfungsi untuk menangkap lesi pada ukuran kecil ketika terapi kuratif paling efektif. Setelah usia masuk kelompok perimenopause dan seterusnya, jaringan payudara umumnya menjadi kurang padat sehingga mammografi semakin informatif. Meski demikian, sebagian perempuan tetap memiliki payudara padat, sehingga pemeriksaan tambahan seperti ultrasonografi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan deteksi, khususnya bila mammografi menunjukkan temuan yang tidak jelas. Tomosintesis, yakni mammografi tiga dimensi, bila tersedia, membantu mengurangi hasil positif palsu pada payudara padat. Pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga kesehatan dan kesadaran memeriksa perubahan pada payudara sendiri tetap dianjurkan sebagai pelengkap, bukan pengganti mammografi. Hasil mammografi yang normal memberi ketenangan dan menjadi dasar interval pemeriksaan berikutnya, sedangkan temuan yang mencurigakan ditindaklanjuti dengan pencitraan lanjutan atau biopsi inti agar diagnosis pasti ditegakkan tanpa menunda.

Pada kesehatan tulang, skrining osteoporosis menjadi krusial karena percepatan kehilangan massa tulang sangat nyata setelah menopause. Pemeriksaan densitometri tulang dengan DXA di tulang belakang lumbal dan leher femur adalah standar untuk menilai densitas mineral tulang dan klasifikasi normal, osteopenia, atau osteoporosis. Nilai T-score di bawah minus dua koma lima pada salah satu lokasi menunjukkan osteoporosis. Namun keputusan klinis tidak boleh berhenti pada angka. Kalkulator risiko fraktur seperti FRAX membantu memperhitungkan usia, indeks massa tubuh, riwayat fraktur, riwayat keluarga fraktur panggul, merokok, konsumsi alkohol, penggunaan glukokortikoid, dan penyakit penyerta untuk memperkirakan peluang fraktur mayor dalam sepuluh tahun. Perempuan dengan hasil DXA borderline tetapi skor risiko fraktur yang tinggi tetap layak mendapat intervensi intensif termasuk obat antiresorptif. Sebaliknya, perempuan dengan risiko rendah dapat difokuskan pada nutrisi kalsium dan vitamin D yang adekuat, latihan kekuatan dan keseimbangan, tata rumah yang aman untuk mencegah jatuh, serta peninjauan obat yang dapat memperburuk risiko jatuh. Pada mereka yang memiliki nyeri punggung baru, tinggi badan berkurang, atau kifosis progresif, penilaian fraktur vertebra secara radiologis perlu dipertimbangkan karena banyak fraktur tulang belakang yang tidak disadari pasien.

Pada kesehatan kardiovaskular, skrining menyorot faktor yang sering kali tidak bergejala tetapi menentukan luaran hidup jangka panjang. Pemeriksaan tekanan

darah sebaiknya dilakukan dengan teknik yang benar, lengan disangga sejajar jantung, manset sesuai lingkaran lengan, dan pada kunjungan pertama diukur pada kedua lengan untuk mendeteksi perbedaan yang bermakna. Hasil tinggi pada sekali kunjungan perlu dikonfirmasi di kesempatan berikutnya atau dengan pemantauan di rumah agar menghindari diagnosis berlebihan. Profil lipid dapat diperiksa dalam keadaan puasa atau nonpuasa sesuai kebijakan fasilitas, karena kolesterol total dan LDL relatif stabil sementara trigliserida lebih sensitif terhadap makanan. Pemeriksaan glukosa puasa dan atau HbA1c membantu menilai adanya pradiabetes atau diabetes yang sering berjalan diam-diam. Hasil-hasil ini kemudian dipadukan dalam penilaian risiko kardiovaskular sepuluh tahun untuk menentukan kebutuhan intervensi gaya hidup intensif saja atau perlu tambahan obat seperti statin dan antihipertensi. Elektrokardiogram rutin pada individu tanpa gejala biasanya tidak menambah manfaat, namun gejala berdebar, nyeri dada, sesak, atau penurunan toleransi aktivitas memerlukan evaluasi lebih lanjut sesuai indikasi klinis.

Pada kesehatan mental dan kognitif, skrining penting karena gejala psikologis kerap tumpang tindih dengan keluhan vasomotor dan gangguan tidur. Instrumen ringkas tetapi tervalidasi seperti PHQ-9 untuk depresi dan GAD-7 untuk kecemasan dapat diisi dalam beberapa menit dan memberikan gambaran yang cukup akurat untuk memutuskan apakah diperlukan intervensi atau rujukan. Keluhan insomnia yang persisten perlu dieksplorasi pola tidur, kebiasaan malam hari, dan kemungkinan gangguan pernapasan saat tidur. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia memiliki bukti kuat dan dapat dipadukan dengan edukasi higiene tidur. Keluhan penurunan daya ingat atau konsentrasi tidak selalu berarti demensia. Pada kasus dengan kekhawatiran nyata atau faktor risiko tinggi, penapisan kognitif dengan alat singkat seperti Mini-Cog atau Montreal Cognitive Assessment dapat dilakukan, diikuti evaluasi lebih jauh bila terdapat temuan abnormal. Depresi, kecemasan, insomnia, dan nyeri muskuloskeletal saling memperparah bila tidak ditangani, sehingga identifikasi dini membuka peluang untuk perbaikan kualitas hidup yang signifikan.

Pada kesehatan metabolik, pengukuran indeks massa tubuh dan lingkaran perut merupakan langkah sederhana tetapi informatif. Setelah menopause, lemak cenderung terkumpul di perut bagian dalam sehingga ukuran lingkaran perut menjadi indikator yang sangat relevan. Pada populasi Asia, ambang lingkaran perut yang lebih rendah telah dikaitkan dengan risiko metabolik yang tinggi. Pengukuran ini dipadukan dengan tekanan darah, trigliserida, HDL kolesterol, dan glukosa puasa untuk mengevaluasi sindrom metabolik. Diagnosis sindrom metabolik menandakan risiko ganda, yakni penyakit kardiovaskular dan diabetes di masa depan. Kabar baiknya, perubahan pola makan terstruktur, peningkatan aktivitas fisik aerobik dan

latihan kekuatan, serta penurunan berat badan yang realistis memberi dampak perbaikan yang bermakna bahkan sebelum obat-obatan diperlukan. Bila perubahan gaya hidup sudah optimal namun risiko tetap tinggi, intervensi farmakologis dipertimbangkan sesuai pedoman.

Pada kesehatan umum, pemeriksaan laboratorium yang lebih luas tidak dilakukan secara rutin pada semua orang, tetapi diarahkan oleh gejala, temuan fisik, dan faktor risiko. Pemeriksaan fungsi tiroid dengan TSH bermanfaat ketika terdapat keluhan khas seperti mudah lelah yang tidak jelas sebabnya, intoleransi dingin atau panas, gangguan irama haid pada fase perimenopause, perubahan berat badan yang mencolok, adanya pembesaran kelenjar tiroid, atau riwayat penyakit autoimun. Fungsi ginjal dinilai dengan kreatinin dan estimasi laju filtrasi glomerulus terutama pada pasien dengan hipertensi, diabetes, penggunaan obat nefrotoksik, atau usia lanjut, karena gangguan fungsi ginjal memengaruhi pilihan dan dosis obat yang aman. Enzim hati dan parameter lain dievaluasi bila ada faktor risiko penyakit hati berlemak seperti obesitas, diabetes, dislipidemia, atau konsumsi alkohol, maupun bila akan memulai obat yang dapat memengaruhi hati. Pada saat yang sama, kebutuhan imunisasi dewasa seperti influenza tahunan, pneumokokus sesuai usia dan faktor risiko, serta tetanus difteria difteri pertusis diperbarui, karena pencegahan infeksi merupakan bagian integral dari strategi skrining menyeluruh. Jika belum pernah, skrining kanker kolorektal sesuai usia dan riwayat keluarga sebaiknya diintegrasikan dalam paket pemeriksaan, mengingat beban penyakit ini meningkat seiring usia.

E. Panduan Frekuensi dan Metode Skrining

Prinsip utama penjadwalan skrining pada masa perimenopause dan postmenopause adalah mengikuti pedoman yang diakui, lalu menyesuaikannya dengan risiko dan preferensi individu. Organisasi kesehatan dunia dan banyak pedoman nasional memberikan kerangka yang serupa, namun selalu tekankan bahwa keputusan akhir diambil dalam percakapan klinis yang jelas, empatik, dan berbasis bukti. Pada praktiknya, kunjungan skrining tahunan atau dua tahunan menjadi momen untuk meninjau seluruh paket pemeriksaan, menilai ulang faktor risiko, dan memperbarui rencana tindak lanjut. Di bawah ini diuraikan pola frekuensi yang lazim direkomendasikan, diikuti cara menyesuaikannya berdasarkan profil risiko setiap perempuan.

Skrining serviks tetap relevan pada perimenopause dan awal postmenopause. Bila riwayat skrining sebelumnya adekuat dan normal, banyak pedoman menganjurkan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu sitologi serviks saja setiap tiga tahun, atau tes HPV primer setiap lima tahun, atau kotesting sitologi ditambah HPV

setiap lima tahun. Setelah usia lanjut, skrining dapat dihentikan bila syarat berhenti terpenuhi, yaitu riwayat beberapa hasil negatif berturut-turut dan tidak ada riwayat lesi prakanker derajat tinggi. Perempuan yang menjalani histerektomi total karena indikasi jinak dan tanpa riwayat lesi prakanker umumnya tidak lagi memerlukan skrining serviks. Sebaliknya, perempuan dengan imunosupresi, riwayat lesi derajat tinggi, atau hasil abnormal sebelumnya memerlukan jadwal lebih rapat dan rujukan kolposkopi bila hasil menuntut evaluasi lanjutan. Pada fasilitas dengan sumber daya terbatas, inspeksi visual dengan asam asetat dapat menjadi alternatif yang diintegrasikan ke alur rujukan yang jelas.

Skrining payudara dengan mammografi disarankan secara berkala pada kelompok usia pertengahan hingga lanjut. Banyak pedoman nasional menempatkan usia lima puluh hingga tujuh puluh empat tahun sebagai kelompok yang memperoleh manfaat terbesar bila diperiksa setiap dua tahun. Pada usia empat puluh hingga empat puluh sembilan tahun, keputusan sering dilakukan melalui pengambilan keputusan bersama, mempertimbangkan manfaat penurunan kematian dan risiko positif palsu. Perempuan dengan payudara padat atau temuan yang meragukan dapat dibantu dengan ultrasonografi sebagai pemeriksaan tambahan. Mereka yang berisiko sangat tinggi, misalnya membawa mutasi genetik tertentu atau memiliki riwayat paparan radiasi dada pada usia muda, biasanya dianjurkan memulai skrining lebih dini dan lebih sering, serta menambahkan MRI payudara sesuai ketersediaan dan pedoman.

Skrining osteoporosis menjadi tonggak pada postmenopause. Pemeriksaan DXA dianjurkan pada semua perempuan usia lanjut, dan pada perempuan postmenopause yang lebih muda bila risiko frakturnya setara atau lebih tinggi dibanding perempuan lanjut usia. Interval ulangan bergantung pada hasil awal, semakin rendah nilai T, semakin cepat ulangan perlu dilakukan, pada umumnya dua hingga lima tahun. Penghitungan risiko fraktur sepuluh tahun dengan kalkulator klinis, misalnya FRAX, membantu menggabungkan usia, indeks massa tubuh, riwayat fraktur, riwayat keluarga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, penggunaan glukokortikoid, dan komorbid lain ke dalam keputusan klinis. Hasil yang menunjukkan risiko sedang atau tinggi menjadi dasar intervensi yang lebih intensif, mulai dari nutrisi kalsium dan vitamin D, latihan kekuatan dan keseimbangan, pencegahan jatuh, sampai pemberian obat antiresorptif.

Skrining kardiometabolik dilakukan secara berkala karena hipertensi, dislipidemia, dan diabetes sering tidak bergejala pada awalnya. Tekanan darah dinilai pada setiap kunjungan kesehatan atau minimal setahun sekali, dengan teknik pengukuran yang benar dan konfirmasi di kesempatan berikutnya bila hasil pertama tinggi. Profil lipid sebaiknya diperiksa sebagai garis dasar pada perimenopause atau

awal postmenopause, lalu diulang setiap lima tahun bila normal dan tidak ada faktor risiko baru, dengan frekuensi lebih sering pada mereka yang memiliki risiko kardiovaskular tinggi atau yang sedang menjalani terapi. Penapisan diabetes menggunakan glukosa puasa atau HbA1c lazim diulang setiap tiga tahun pada populasi risiko rata-rata, dan setiap tahun pada mereka dengan kelebihan berat badan atau faktor risiko tambahan seperti riwayat keluarga, hipertensi, dislipidemia, atau riwayat diabetes pada kehamilan. Hasil kardiometabolik tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke kalkulator risiko untuk memutuskan kapan konseling gaya hidup saja cukup dan kapan dibutuhkan obat seperti statin atau antihipertensi.

Skrining kanker kolorektal menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Pada populasi risiko rata-rata, pemeriksaan dapat berupa tes darah samar tinja berbasis imunokimia setiap tahun, tes DNA tinja setiap tiga tahun, atau kolonoskopi setiap sepuluh tahun bila hasil normal. Pilihan metode dipengaruhi preferensi pasien, ketersediaan layanan, dan kesiapan untuk menjalani pemeriksaan konfirmasi bila hasil tes tinja positif. Mereka dengan riwayat keluarga derajat pertama atau riwayat polip sebelumnya memerlukan strategi deteksi yang dimulai lebih dini dan interval lebih rapat sesuai pedoman yang berlaku di negara masing-masing.

Kesehatan mental dan kognitif sebaiknya dinilai secara berkala, setidaknya setahun sekali atau lebih sering bila ada keluhan. Instrumen singkat yang tervalidasi seperti PHQ 9 untuk depresi dan GAD 7 untuk kecemasan dapat diisi dalam beberapa menit dan membantu memilah siapa yang membutuhkan intervensi lanjutan atau rujukan. Penapisan kognitif tidak diwajibkan untuk semua orang tanpa keluhan, namun keluhan lupa yang mengganggu fungsi, riwayat keluarga demensia, atau temuan klinis lain menjadi dasar penapisan dengan alat singkat seperti Mini Cog atau MoCA, lalu rujukan bila perlu. Gangguan tidur sering menjadi simpul antara keluhan vasomotor dan masalah mood, sehingga penilaian kebiasaan tidur dan strategi terapi perilaku kognitif untuk insomnia sering dimasukkan ke rencana tindak lanjut.

Skrining metabolik yang sederhana memiliki nilai tinggi. Pengukuran indeks massa tubuh dan lingkar perut dilakukan pada setiap kunjungan berkala. Lingkar perut yang meningkat, terutama pada populasi Asia, sangat berkorelasi dengan risiko sindrom metabolik. Temuan ini dipadukan dengan trigliserida, HDL, tekanan darah, dan glukosa puasa untuk menilai ada tidaknya sindrom metabolik, lalu dijadikan pijakan program gizi, aktivitas fisik aerobik dan latihan kekuatan, serta target penurunan berat badan yang realistis. Pemantauan ulang dilakukan untuk melihat respons, umumnya setiap tiga sampai enam bulan pada fase awal perubahan gaya hidup, lalu diperpanjang bila target tercapai dan mantap.

Pemeriksaan fungsi tiroid, ginjal, dan hati tidak dilakukan seragam pada semua orang, melainkan diarahkan oleh gejala, penggunaan obat, atau temuan klinis. TSH diperiksa bila ada keluhan yang mengarah ke gangguan tiroid seperti mudah lelah berlebihan, intoleransi dingin atau panas, perubahan berat badan yang mencolok, gangguan ritme haid pada perimenopause, atau pembesaran kelenjar. Fungsi ginjal dinilai bila ada hipertensi, diabetes, penggunaan obat nefrotoksik, usia lanjut, atau sebelum memulai terapi yang bergantung pada fungsi ginjal. Enzim hati dievaluasi pada mereka dengan faktor risiko penyakit hati berlemak, konsumsi alkohol, atau sebelum memulai obat yang berpotensi memengaruhi hati. Dalam kunjungan yang sama, status imunisasi dewasa diperbarui, karena pencegahan infeksi berkontribusi pada penurunan kunjungan darurat dan rawat inap pada usia lanjut.

Penyesuaian skrining berdasarkan faktor risiko individu menjadi inti personalisasi. Riwayat keluarga kanker payudara atau ovarium, paparan radiasi dada pada usia muda, atau hasil kalkulator risiko yang tinggi mengarahkan skrining payudara untuk dimulai lebih dini, dilakukan lebih sering, dan diperkaya dengan MRI bila tersedia. Riwayat lesi prakanker serviks, imunosupresi, atau skrining yang tidak teratur menuntut jadwal sitologi atau tes HPV yang lebih rapat dan kesiap-siagaan untuk evaluasi kolposkopi. Menopause dini, indeks massa tubuh sangat rendah, fraktur sebelumnya, penggunaan glukokortikoid, hipertiroid, atau hiperparatiroid memperkuat indikasi DXA yang lebih dini dan interval ulangan yang lebih pendek. Hipertensi, diabetes, dislipidemia, merokok, obesitas sentral, penyakit autoimun, dan penyakit ginjal kronik memperpendek interval evaluasi kardiometabolik dan menurunkan ambang untuk memulai terapi. Gejala sindrom genitourinaria yang berat mengarahkan evaluasi urogenital yang aktif dan intervensi lokal sehingga kualitas hidup tidak dikorbankan.

Konteks layanan juga mempengaruhi metode dan frekuensi. Di fasilitas dengan keterbatasan, pilihan metode yang hemat biaya dan mudah diakses menjadi unggulan, misalnya tes tinja tahunan untuk skrining kolorektal dibanding kolonoskopi massal, inspeksi visual serviks pada program berbasis komunitas, atau penggunaan alat penilaian risiko klinis untuk osteoporosis sebelum DXA tersedia. Prinsipnya, setiap metode yang dipilih harus diikuti jalur rujukan yang jelas bila hasil positif dan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa langkah berikutnya terlaksana. Tidak ada gunanya skrining tanpa tindak lanjut, sama halnya hasil normal harus dikonversi menjadi komitmen mempertahankan perilaku sehat dan menetapkan kapan kembali diperiksa.

F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Skrining

Keberhasilan skrining pada masa perimenopause dan postmenopause tidak hanya ditentukan oleh daftar pemeriksaan yang dikerjakan, tetapi terutama oleh cara tenaga kesehatan mendampingi pasien sejak edukasi awal, selama proses pengambilan keputusan, hingga pemantauan dan penutupan siklus tindak lanjut. Tiga kompetensi inti diperlukan agar skrining menghasilkan manfaat nyata, yaitu kemampuan memberikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan, kemampuan melakukan konseling berbasis risiko yang menghormati nilai pasien, serta kemampuan membangun sistem pemantauan yang memastikan setiap hasil diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat waktu.

Edukasi pasien adalah titik mula yang menentukan nada seluruh proses. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan informasi medis, melainkan menyalakan rasa memiliki terhadap rencana kesehatan pribadi. Tenaga kesehatan perlu memulai dengan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tubuh di fase perimenopause dan postmenopause dalam bahasa sederhana yang tidak menakutkan. Penjelasan mengenai fluktuasi hingga penurunan estrogen, perubahan pola haid, keluhan vasomotor, perubahan tidur, perubahan metabolisme, risiko pada tulang dan kardiovaskular, serta kemungkinan keluhan genitourinaria membantu pasien mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan mekanisme biologis yang masuk akal. Saat menerangkan manfaat skrining, fokuskan pada dua hal yang paling bermakna bagi pasien, yaitu peluang mencegah penyakit sebelum muncul dan peluang menemukan kelainan sedini mungkin sehingga terapi lebih ringan dan hasil lebih baik. Teknik ajar balik sangat membantu memastikan pemahaman, misalnya dengan meminta pasien mengulang inti rencana dengan kata-kata sendiri. Media visual sederhana seperti bagan siklus pemeriksaan, kartu pengingat, dan ilustrasi cara mempersiapkan pemeriksaan tertentu menambah kejelasan. Di ruang edukasi, privasi dan penghormatan menjadi pondasi. Banyak perempuan membawa kekhawatiran terkait seksualitas, citra tubuh, stigma penyakit, atau pengalaman buruk sebelumnya. Tenaga kesehatan perlu membangun suasana yang aman untuk bertanya dan mengakui kebingungan tanpa takut dihakimi. Bila ada hambatan bahasa atau keterbatasan literasi, sediakan materi dalam bahasa yang dipahami, gunakan kalimat pendek, dan tawarkan pendamping tepercaya bila pasien menginginkan.

Konseling berbasis risiko adalah jantung pengambilan keputusan dalam skrining. Prinsipnya, rekomendasi yang sama tidak cocok untuk semua orang. Tenaga kesehatan menilai profil individu dengan mengumpulkan faktor yang relevan, seperti usia, riwayat keluarga penyakit jantung, stroke, kanker payudara atau kolorektal, riwayat fraktur, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, indeks massa tubuh dan lingkar perut, tekanan darah, profil lipid, gula darah, obat

yang sedang dikonsumsi, serta keluhan yang memengaruhi kualitas hidup misalnya nyeri saat berhubungan, nyeri muskuloskeletal, gangguan tidur, atau gejala suasana hati. Informasi ini kemudian dipadukan dengan alat penilaian yang sesuai konteks setempat. Penilaian risiko fraktur membantu memutuskan kapan densitometri tulang perlu diprioritaskan dan kapan intervensi non farmakologis cukup. Penilaian risiko kardiovaskular sepuluh tahun mengarahkan intensitas perubahan gaya hidup dan kebutuhan terapi pencegahan. Riwayat keluarga dan temuan sebelumnya mengarahkan strategi deteksi kanker payudara, serviks, dan kolorektal. Yang sama penting, konseling harus meletakkan data sejajar dengan nilai pasien. Ada pasien yang sangat menghargai ketenangan pikiran meski harus menjalani pemeriksaan lebih sering. Ada yang ingin meminimalkan risiko tindakan lanjutan akibat positif palsu. Tugas tenaga kesehatan adalah memaparkan manfaat dan potensi mudarat secara jujur, menghindari janji yang berlebihan, lalu menuntun pada keputusan yang dirasa masuk akal oleh pasien. Pendekatan wawancara motivasional bermanfaat ketika pasien ambivalen terhadap perubahan gaya hidup atau ragu mengikuti pemeriksaan. Alih alih membantah, tenaga kesehatan mengeksplorasi alasan pribadi pasien untuk berubah, menguatkan harapan, dan menyepakati satu atau dua langkah kecil yang dapat dilakukan segera.

Pemantauan dan tindak lanjut adalah jembatan antara hasil di kertas dan hasil di kehidupan nyata. Sistem yang baik dimulai dari dokumentasi yang ringkas namun lengkap, mencatat pemeriksaan yang sudah dikerjakan, hasilnya, makna klinisnya, keputusan bersama, serta kapan langkah berikutnya akan dilakukan. Hasil normal tidak berakhir pada kalimat aman semata, melainkan diikuti penguatan perilaku sehat dan penetapan tanggal ulang pemeriksaan yang realistis. Hasil menyimpang memerlukan rencana yang spesifik. Temuan mamografi yang mencurigakan, misalnya, langsung dijadwalkan pencitraan lanjutan atau biopsi dengan tanggal dan tempat yang disepakati. Hasil gula darah pada rentang pradiabetes perlu dikonversi menjadi program gizi dan aktivitas fisik yang terukur, ditambah tanggal kontrol untuk menilai respons. Hasil densitometri tulang yang menunjukkan osteoporosis perlu diikuti keputusan mengenai suplemen, latihan kekuatan dan keseimbangan, penataan obat yang meningkatkan risiko jatuh, serta diskusi manfaat dan risiko obat antiresorptif. Setiap rencana disampaikan tertulis dalam bahasa yang mudah, sehingga pasien pulang membawa peta aksi, bukan sekadar diagnosis.

Menutup siklus tindak lanjut membutuhkan mekanisme pengingat dan pelacakan. Di fasilitas dengan sistem informasi elektronik, pengingat otomatis dan daftar tugas membantu mencegah hasil abnormal terlambat dihubungi. Di tempat dengan sumber daya terbatas, kartu janji temu, panggilan telepon singkat, atau pesan singkat terjadwal menjadi penopang yang efektif selama dikelola disiplin.

Penanggung jawab harus jelas agar tidak terjadi kebingungan siapa yang menghubungi pasien dan siapa yang mengoordinasikan rujukan. Pada populasi yang rentan, misalnya perempuan yang tinggal sendiri, yang mengalami hambatan transportasi, atau yang memiliki beban pengasuhan tinggi, tenaga kesehatan berperan sebagai navigator. Tugas ini meliputi membantu memilih jadwal yang tidak berbenturan dengan pekerjaan, mengarahkan ke fasilitas yang lebih dekat, menghubungkan dengan program bantuan biaya transportasi bila tersedia, dan mengidentifikasi hambatan yang membuat pasien gagal hadir. Pendekatan ini mencegah kesenjangan skrining melebar hanya karena alasan logistik.

Mutu pemantauan juga diukur dari cara tenaga kesehatan menangani situasi yang tidak pasti. Hasil yang meragukan sering memunculkan kecemasan. Komunikasi yang tenang dan jelas tentang apa arti hasil tersebut, apa pemeriksaan konfirmasi yang dibutuhkan, dan apa yang realistis diharapkan dari langkah berikutnya menurunkan beban psikologis. Begitu pula ketika terjadi hasil positif palsu atau overdiagnosis. Kejujuran profesional, empati, dan kesiapan mengoreksi arah adalah bagian dari pelayanan yang etis. Tidak semua gejala menuntut tindakan invasif. Edukasi mengenai keamanan menunggu dengan pengawasan yang baik pada kondisi yang sesuai menghindarkan pasien dari intervensi yang tidak perlu.

Edukasi, konseling berbasis risiko, dan pemantauan tidak berdiri terpisah. Ketiganya membentuk satu siklus pembelajaran. Setiap kunjungan menjadi waktu untuk menilai apa yang sudah berhasil, apa yang masih mengganjal, dan apa yang perlu disesuaikan. Indikator sederhana membantu memantau mutu, seperti proporsi hasil abnormal yang telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang disepakati, proporsi pasien yang kembali tepat waktu untuk pemeriksaan ulangan, dan persepsi rasa aman serta kejelasan rencana oleh pasien. Temuan dari indikator ini kemudian dibawa ke rapat tim untuk memutuskan perbaikan kecil yang langsung dicoba, misalnya menyederhanakan lembar rencana pasien, memperbaiki alur rujukan, atau menambah jam layanan pada waktu yang lebih mudah diakses. Perhatian juga perlu diberikan pada kesejahteraan tenaga kesehatan sendiri. Layanan skrining yang efektif menuntut konsistensi, dan konsistensi tidak mungkin terjaga bila tenaga kesehatan kelelahan. Jadwal kerja yang realistis, akses supervisi dan diskusi kasus, serta budaya saling mendukung adalah unsur yang membuat sistem pemantauan bertahan dalam jangka panjang.

G. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Skrining

Pedoman skrining untuk perempuan pada masa perimenopause dan postmenopause sudah tersedia dan relatif konsisten di berbagai organisasi. Namun, penerapan di lapangan sering tertahan oleh hambatan yang tidak semata klinis.

Hambatan ini berakar pada budaya dan struktur sosial, kondisi ekonomi rumah tangga, keterbatasan akses dan fasilitas pelayanan, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pasien terhadap jadwal yang disarankan. Memahami lapisan hambatan tersebut penting agar program skrining tidak berhenti pada daftar anjuran, melainkan benar benar menyentuh kebutuhan perempuan yang menjalani fase hidup ini.

Hambatan budaya, sosial, dan ekonomi sering hadir bersamaan dan saling memperkuat. Di banyak komunitas, pembicaraan tentang payudara, organ reproduksi, hubungan seksual, atau kebocoran urine masih dianggap tabu. Perempuan enggan memeriksakan keluhan karena takut dinilai, khawatir dianggap telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, atau sekadar karena tidak nyaman membicarakan tubuhnya di hadapan orang lain. Norma gender yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama membuat kesehatan diri berada di urutan terakhir setelah kebutuhan pasangan, anak, atau orang tua. Ada pula keyakinan bahwa gejala seperti rasa panas mendadak, kering vagina, atau nyeri sendi adalah bagian wajar dari penuaan sehingga tidak perlu dicari penyebabnya. Di sisi ekonomi, biaya langsung untuk pemeriksaan tertentu seperti mammografi, DXA, atau kolonoskopi dapat menjadi penghalang, terlebih bila asuransi tidak menanggung penuh. Biaya tidak langsung seperti ongkos transportasi, kehilangan pendapatan harian, serta biaya penitipan cucu juga sering kali lebih berat dirasakan dibanding biaya medis itu sendiri. Pengalaman buruk di layanan kesehatan, misalnya merasa dipermalukan saat pemeriksaan panggul atau menerima penjelasan yang rumit tanpa empati, dapat menambah resistensi. Pada akhirnya, kombinasi stigma, prioritas keluarga, dan beban biaya menyusutkan kemauan untuk hadir ke layanan, terutama ketika keluhan belum terasa berat.

Keterbatasan akses dan fasilitas memperlebar jurang antara pedoman dan kenyataan. Perempuan di wilayah pedesaan atau daerah terpencil menghadapi jarak yang jauh ke fasilitas rujukan, waktu tempuh panjang, dan pilihan transportasi yang terbatas. Di tingkat fasilitas, ketersediaan alat skrining tidak merata. Mammografi dan DXA sering hanya ada di kota besar, sementara di layanan primer kemampuan sitologi serviks, tes HPV, atau tes darah samar tinja mungkin belum berjalan dengan mutu yang konsisten. Ruang pemeriksaan yang tidak memadai, kurangnya privasi saat pemeriksaan panggul, dan keterbatasan tenaga kesehatan perempuan dapat membuat pasien enggan melanjutkan proses. Di laboratorium, mutu pemeriksaan sangat bergantung pada rantai logistik, pemeliharaan alat, kontrol kualitas, dan kompetensi analis. Hasil yang tertunda atau tidak jelas mengacaukan jadwal tindak lanjut. Fragmentasi rujukan juga menjadi masalah. Pasien menerima hasil dari satu fasilitas tetapi harus mencari sendiri tempat pemeriksaan konfirmasi atau terapi,

sementara rekam medis tidak terintegrasi sehingga informasi penting hilang di tengah jalan. Ketika sistem informasi tidak mampu mengingatkan secara otomatis, banyak hasil abnormal yang tidak sempat ditindaklanjuti tepat waktu. Semua hambatan ini membuat perjalanan dari skrining menuju diagnosis pasti dan terapi kerap berhenti di tengah.

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pasien merupakan hambatan yang tampak sederhana tetapi kompleks di lapangan. Banyak perempuan memahami skrining sebagai kegiatan mencari penyakit saat sakit, bukan sebagai upaya menemukan masalah sebelum bergejala. Ketika merasa sehat, mereka menunda atau membatalkan janji tanpa rasa bersalah. Informasi yang diberikan pada kunjungan sebelumnya sering terlupa karena disampaikan terlalu cepat atau menggunakan istilah teknis yang sulit. Keputusan yang harus diambil setelah mendapatkan hasil juga tidak selalu mudah. Temuan yang tampak meresahkan, seperti hasil mammografi yang perlu pencitraan lanjutan atau hasil sitologi yang tidak pasti, dapat memicu kecemasan yang berujung pada penolakan atau menghilang dari tindak lanjut. Perempuan dengan banyak obat untuk penyakit kronis bisa mengalami kelelahan pengobatan. Mereka enggan menambah kunjungan lagi untuk skrining yang terasa tidak mendesak. Tanggung jawab domestik dan sosial membuat jadwal klinik yang kaku sulit diikuti. Di sisi lain, materi edukasi yang tidak menyesuaikan tingkat literasi dan budaya setempat mengurangi daya tangkap pesan. Bahkan pengingat melalui pesan singkat sekalipun tidak selalu efektif bila isi pesan tidak jelas apa langkah berikutnya atau bila nomor telepon sering berganti.

Semua hambatan di atas memiliki konsekuensi nyata terhadap luaran kesehatan. Kanker payudara ditemukan pada stadium yang lebih lanjut karena mammografi tertunda. Lesi prakanker serviks luput karena skrining tidak pernah dimulai atau putus di tengah. Fraktur panggul terjadi setelah bertahun-tahun kehilangan tulang yang tidak pernah dinilai atau ditangani. Hipertensi, dislipidemia, dan pradiabetes berjalan diam-diam, lalu muncul sebagai stroke atau sindrom koroner akut yang mengubah hidup. Di ranah kualitas hidup, sindrom genitourinaria menopause yang tidak pernah dibicarakan berujung pada nyeri saat berhubungan, infeksi saluran kemih berulang, gangguan tidur, dan renggangnya relasi. Gambaran ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi bukan isu administratif, melainkan faktor penentu apakah skrining benar-benar menurunkan angka kesakitan dan kematian.

Mengurai hambatan juga berarti melihat bagaimana kebijakan dan desain layanan dapat membantu atau justru memperberat. Jadwal layanan yang hanya tersedia pada jam kerja menyingkirkan perempuan pekerja informal yang tidak bisa

meninggalkan kios atau ladangnya. Sistem rujukan yang mensyaratkan banyak persetujuan tertulis tanpa penjelasan yang memadai menunda intervensi sederhana yang bisa dikerjakan saat itu juga. Program yang menilai keberhasilan hanya dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan mendorong pendekatan satu ukuran untuk semua, alih alih pendekatan berbasis risiko dan preferensi. Di wilayah dengan literasi digital rendah, memindahkan seluruh komunikasi ke aplikasi ponsel tanpa menyediakan alternatif tatap muka atau telepon suara justru memperlebar kesenjangan. Dengan kata lain, hambatan implementasi sering terletak pada cara sistem mengatur ritme dan cara layanan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari perempuan, bukan pada niat pasien untuk sehat.

Menghadapi kenyataan ini, pelaksanaan skrining memerlukan cara pandang yang lebih luwes dan empatik. Pendekatan yang berhasil biasanya memadukan tiga hal. Pertama, dialog yang menghormati nilai dan keterbatasan pasien sehingga edukasi terasa relevan dan rencana dapat dijalankan. Kedua, penyederhanaan alur yang mengurangi jumlah kunjungan, menurunkan biaya tersembunyi, dan memperjelas siapa melakukan apa pada setiap langkah. Ketiga, penataan ulang dukungan sosial agar keluarga, komunitas, dan pemberi kerja memahami bahwa menjaga kesehatan perempuan paruh baya bukan pengorbanan waktu, melainkan investasi kesejahteraan rumah tangga. Ketika hambatan budaya, sosial, ekonomi, akses, dan kepatuhan dipetakan secara jujur dan ditangani dengan desain layanan yang masuk akal, skrining pada perimenopause dan postmenopause tidak lagi menjadi proyek yang mudah di atas kertas tetapi sulit di lapangan. Ia berubah menjadi praktik yang dekat dengan kehidupan perempuan, tepat waktu, dan berdaya guna.

H. Strategi Peningkatan Partisipasi dalam Skrining

Partisipasi dalam skrining pada masa perimenopause dan postmenopause tidak akan meningkat hanya dengan menempel poster atau menambah jadwal pemeriksaan. Diperlukan strategi yang menyentuh kehidupan sehari-hari perempuan, mengurangi hambatan nyata seperti rasa malu, biaya tersembunyi, dan waktu tempuh, serta menata ulang alur layanan agar sederhana dan ramah. Tiga poros yang saling menguatkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja, yaitu pendekatan komunitas yang membangun kepercayaan, edukasi berbasis media dan teknologi digital yang mengantar pesan ke telapak tangan, serta program skrining terpadu di layanan primer yang memudahkan semua pemeriksaan dilakukan dalam sedikit langkah.

Pendekatan komunitas dimulai dari pemetaan jejaring sosial yang benar-benar hidup di wilayah sasaran. Kelompok pengajian, arisan, PKK, koperasi pasar, serikat

pekerja pabrik, komunitas senam pagi, posyandu lansia, dan organisasi keagamaan sering menjadi ruang paling aman bagi perempuan untuk bertanya tanpa takut dinilai. Menghadirkan sesi edukasi singkat di forum ini dengan bahasa yang sopan dan contoh yang dekat dengan keseharian membuat topik yang semula tabu terasa wajar dibicarakan. Relawan kesehatan, kader, atau tokoh perempuan setempat dilatih sebagai duta yang mampu menjelaskan manfaat skrining, mengatasi mitos, dan membantu membuat janji di fasilitas terdekat. Kegiatan pop up seperti hari pemeriksaan payudara klinis, pengambilan sampel tes serviks, atau penilaian risiko osteoporosis dapat digelar di balai warga atau aula rumah ibadah dengan penataan privasi yang baik dan petugas kesehatan perempuan. Strategi ini bukan hanya menghemat biaya transportasi, tetapi juga mengubah nuansa skrining dari urusan pribadi yang menakutkan menjadi kegiatan bersama yang menyehatkan. Melibatkan pasangan dan anggota keluarga pada momen yang tepat memberi efek ganda. Banyak perempuan menunda skrining karena mengutamakan kebutuhan keluarga. Jika suami atau anak mengerti bahwa skrining mencegah penyakit berat dan menjaga peran ibu tetap berjalan, dukungan logistik seperti mengantar, menjaga cucu, atau menyesuaikan jadwal rumah tangga akan muncul lebih alami. Pada komunitas pekerja informal atau pedagang pasar, kemitraan dengan pengurus pasar untuk menyediakan sudut skrining pada hari tertentu, lengkap dengan jam layanan yang lebih pagi atau lebih sore, sering kali jauh lebih efektif ketimbang menunggu pasien datang ke puskesmas di jam kerja.

Edukasi berbasis media dan teknologi digital memperluas jangkauan sekaligus menjaga konsistensi pesan. Konten yang efektif bersifat pendek, jelas, dan visual. Video satu menit tentang perbedaan Pap smear dan tes HPV, infografik cara mempersiapkan mammografi, atau cerita singkat seorang ibu yang pulih karena polipnya ditemukan lebih awal akan lebih diingat daripada paragraf panjang tentang patofisiologi. Saluran distribusi menyesuaikan kebiasaan lokal. Di banyak tempat, WhatsApp menjadi kanal utama. Pesan berurutan yang dirancang sebagai modul mikro belajar bisa dikirim mingguan, dilengkapi kuis singkat untuk menguatkan ingatan dan tombol singkat untuk membuat janji. Bagi yang tidak selalu memiliki kuota, SMS pengingat dengan bahasa yang ringkas tetap efektif, terutama bila mencantumkan langkah berikut yang jelas seperti tanggal, lokasi, dan nomor kontak konfirmasi. Fitur navigasi pasien berbasis percakapan, baik melalui nomor WhatsApp bisnis atau pesan singkat otomatis, dapat membantu menjawab pertanyaan umum seperti apakah perlu puasa, apakah pemeriksaan ditanggung asuransi, atau apakah ada petugas perempuan. Keamanan dan privasi wajib dijaga. Hindari menyebutkan diagnosis dalam pesan, gunakan inisial atau nomor antrian, dan selalu minta persetujuan pasien sebelum mendaftarkan nomor ke daftar pengingat. Desain

konten perlu memperhatikan inklusivitas. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana atau padankan dengan bahasa daerah ketika perlu, sertakan teks untuk konten video agar dapat diakses penyandang gangguan pendengaran, dan pastikan gambar mencerminkan keragaman usia, bentuk tubuh, dan latar budaya sehingga tidak ada yang merasa di luar target. Bagi daerah dengan internet yang tidak stabil, konten dapat dibawa ke ruang offline melalui radio komunitas, pengeras suara masjid pada jam khusus, atau pemutaran video di ruang tunggu dan kelas komunitas.

Program skrining terpadu di fasilitas pelayanan primer adalah kunci yang menyatukan semua upaya menjadi pengalaman yang mudah dijalani. Prinsipnya sederhana, yaitu satu kunjungan yang bermakna. Ketika perempuan datang, ia tidak perlu berpindah ruang berulang kali untuk pemeriksaan yang berbeda. Pendaftaran mencatat usia, riwayat keluarga, obat, dan beberapa faktor risiko kunci. Petugas melakukan pengukuran cepat seperti tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, dan tes glukosa atau HbA1c bila terindikasi. Anamnesis terarah menilai gejala genitourinaria, keluhan tidur, suasana hati, serta faktor jatuh. Berdasarkan profil risiko, tenaga kesehatan memberikan surat pengantar mammografi, mengambil sampel tes serviks dengan alat dan teknik yang nyaman, atau melakukan uji tinja darah samar sesuai usia dan preferensi. Untuk osteoporosis, jika DXA belum tersedia, penilaian risiko fraktur dilakukan lebih dahulu agar rujukan lebih tepat sasaran. Sesi singkat konseling berakhir dengan rencana tertulis yang berisi apa yang sudah dikerjakan, apa hasil sementara yang penting, apa yang harus dilakukan di rumah, ke mana harus pergi untuk pemeriksaan lanjutan, dan kapan harus kembali. Sistem tugas berbasis peran membuat beban kerja lebih ringan. Perawat dan bidan memimpin alur skrining dengan protokol jelas, sementara dokter fokus pada kasus kompleks, interpretasi hasil yang ambigu, dan pengambilan keputusan yang membutuhkan diskusi lebih mendalam. Navigator pasien, yang bisa berasal dari petugas administrasi terlatih, memegang peran sebagai penghubung antara pasien dan layanan lanjutan. Ia memastikan janji terbikin, formulir rujukan lengkap, hasil tidak hilang di jalan, dan pasien mendapatkan kabar ketika hasil telah siap.

Kemudahan dan keterjangkauan menjadi penentu partisipasi. Jam layanan diperpanjang pada hari tertentu agar tidak berbenturan dengan jam kerja dan tanggung jawab rumah tangga. Informasi biaya dibuat transparan sejak awal, lengkap dengan pilihan pembiayaan yang tersedia dari asuransi atau program bantuan. Transportasi sering menjadi hambatan terbesar di daerah pinggiran. Kerja sama dengan komunitas untuk menyediakan armada jemput pada hari skrining massal atau pemberian kupon transportasi sederhana dapat membuat perbedaan. Privasi di ruang pemeriksaan ditata sungguh sungguh. Tirai penutup, jalur masuk

terpisah, dan pilihan petugas perempuan pada pemeriksaan yang sensitif meningkatkan rasa aman dan mengurangi kecemasan. Semua hal kecil ini memberi pesan bahwa layanan menghormati martabat pasien, sehingga mereka lebih mungkin kembali dan mengajak teman.

Keberhasilan strategi harus diukur agar perbaikan terus terjadi. Fasilitas dapat memantau sejumlah indikator sederhana. Berapa persen undangan skrining yang berujung kunjungan. Berapa persen hasil abnormal yang telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang disepakati. Berapa banyak pasien yang kembali sesuai jadwal ulangan. Berapa lama rata rata waktu dari hasil tes positif ke pemeriksaan konfirmasi. Semua indikator dipecah menurut kelompok desa dan kota, tingkat pendidikan, status ekonomi, serta usia untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Umpan balik kualitatif melalui wawancara singkat atau kotak saran membantu menangkap hal hal yang tidak terlihat oleh angka, misalnya rasa tidak nyaman pada teknik pengambilan sampel atau kebingungan terhadap instruksi puasa. Temuan ini dibawa ke pertemuan tim secara berkala, dipilah mana yang dapat diperbaiki cepat seperti menyederhanakan formulir dan menata ulang alur ruangan, dan mana yang butuh advokasi kebijakan seperti penambahan mesin mammografi atau integrasi rekam medis.

Kolaborasi lintas sektor memberikan daya ungkit. Dinas kesehatan, perangkat desa, organisasi profesi, dan mitra swasta dapat berbagi peran. Pemerintah daerah membantu logistik dan regulasi, fasilitas layanan menyediakan tenaga dan mutu klinis, komunitas menyediakan ruang dan dukungan sosial, serta mitra swasta berkontribusi pada teknologi pengingat atau kampanye komunikasi. Kemitraan ini bekerja baik bila tujuan bersama jelas, yakni deteksi dini yang adil bagi semua perempuan, bukan sekadar mengejar angka pemeriksaan. Ketika pendekatan komunitas membangun kepercayaan, ketika edukasi digital menempatkan pengetahuan di genggaman, dan ketika layanan primer mengubah skrining menjadi kunjungan satu atap yang mudah dan ramah, partisipasi tidak lagi harus dipaksa. Ia tumbuh karena dirasakan manfaatnya, dihormati prosesnya, dan dimudahkan jalannya.

I. Simpulan

Skrining kesehatan pada masa perimenopause dan postmenopause adalah investasi jangka panjang untuk mencegah penyakit, menemukan kelainan pada tahap paling dini, dan mempertahankan mutu hidup perempuan saat tubuhnya memasuki fase biologis yang baru. Pergeseran hormonal yang meluas memengaruhi tulang, kardiometabolik, urogenital, kulit, saraf, bahkan suasana hati dan tidur. Karena itu skrining tidak cukup dipahami sebagai serangkaian tes yang berdiri

sendiri, melainkan sebagai proses klinis yang terarah, berlapis, dan berkelanjutan. Lapisan pertama memetakan risiko personal sehingga pencegahan menjadi tepat sasaran. Lapisan kedua mendeteksi dini kondisi yang sering berjalan tanpa gejala. Lapisan ketiga memastikan setiap hasil diikuti dengan rencana tindakan yang jelas sehingga perubahan nyata terjadi pada kehidupan pasien, bukan sekadar pada angka laboratorium.

Bab ini menunjukkan bahwa landasan ilmiah skrining bersumber pada mekanisme kekurangan estrogen yang mengubah banyak sistem tubuh sekaligus. Konsekuensinya adalah meningkatnya faktor risiko penyakit kardiovaskular, osteoporosis dan fraktur, gangguan urogenital, serta sejumlah kanker yang prevalensinya naik seiring usia. Pemahaman biologis ini memberi justifikasi kuat mengapa skrining perlu diprioritaskan dan mengapa rekomendasi harus dipersonalisasi. Perempuan dengan riwayat fraktur, menopause dini, atau penggunaan obat yang mempercepat kehilangan tulang membutuhkan jalur tulang yang lebih agresif. Perempuan dengan riwayat keluarga kanker atau profil kardiometabolik yang merugikan memerlukan fokus deteksi dan pencegahan yang berbeda dibanding mereka yang risikonya rata-rata. Personalisasi menjadikan skrining relevan, hemat sumber daya, dan lebih mudah diterima pasien.

Jenis skrining yang direkomendasikan membentuk paket yang saling melengkapi. Di ranah reproduksi, pemeriksaan serviks dengan Pap atau tes HPV serta mammografi untuk payudara menangkap perubahan prakanker dan kanker pada ukuran yang masih kecil ketika terapi sederhana sudah cukup. Pada tulang, DXA dan penilaian risiko fraktur memandu nutrisi, latihan, pencegahan jatuh, dan terapi antiresorptif bila diindikasikan. Pada kardiovaskular dan metabolik, pengukuran tekanan darah, profil lipid, glukosa, indeks massa tubuh dan lingkar perut, serta penilaian sindrom metabolik memberi pijakan kuat untuk perubahan gaya hidup dan pemberian obat pencegahan. Penapisan depresi, kecemasan, dan gangguan tidur menutup celah yang sering melumpuhkan kepatuhan dan kualitas hidup. Pemeriksaan fungsi tiroid, ginjal, dan hati dilakukan sesuai indikasi klinis agar aman saat memulai atau menyesuaikan terapi. Prinsip frekuensi mengikuti pedoman dunia dan nasional, lalu disesuaikan menurut risiko, ketersediaan layanan, dan preferensi pasien sehingga manfaat deteksi dini tetap seimbang dengan beban pemeriksaan.

Keberhasilan skrining ditentukan oleh peran tenaga kesehatan dalam tiga hal yang saling terkait. Edukasi yang jernih membuat pasien memahami apa yang terjadi pada tubuhnya dan mengapa langkah skrining bermanfaat baginya hari ini, bukan nanti. Konseling berbasis risiko menempatkan data dan nilai pasien pada posisi sejajar sehingga keputusan lahir dari pemahaman, bukan paksaan. Pemantauan dan

tindak lanjut menutup lingkaran, memastikan hasil normal dikonversi menjadi komitmen perilaku sehat dan hasil abnormal segera ditindaklanjuti dengan rujukan atau terapi yang tepat. Ketiganya membangun pengalaman skrining yang menghormati martabat pasien dan meningkatkan peluang keberlanjutan.

Pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari hambatan budaya, sosial, ekonomi, dan akses. Tabu membicarakan organ reproduksi, prioritas keluarga yang menomorduakan kesehatan diri, biaya langsung maupun tidak langsung, keterbatasan alat dan tenaga, fragmentasi rujukan, serta rendahnya literasi kesehatan dapat membuat program berhenti di atas kertas. Bab ini menggarisbawahi bahwa hambatan tersebut adalah faktor klinis dalam arti yang luas karena menentukan apakah kanker ditemukan pada stadium awal atau terlambat, apakah fraktur dapat dicegah atau baru tertangani setelah terjadi, dan apakah hipertensi serta diabetes ditangani sebelum memicu komplikasi. Menata layanan agar selaras dengan kehidupan sehari-hari perempuan merupakan kunci mengubah anjuran menjadi praktik.

Strategi peningkatan partisipasi berjalan efektif ketika bekerja dari tiga arah sekaligus. Pendekatan komunitas membangun kepercayaan melalui forum yang akrab, kader terlatih, dan kegiatan skrining dekat rumah dengan privasi terjaga. Edukasi berbasis media dan teknologi digital menyalurkan pesan singkat yang jelas, memberi pengingat, dan mempermudah pembuatan janji tanpa mengorbankan privasi. Program skrining terpadu di layanan primer menyatukan berbagai pemeriksaan dalam satu kunjungan yang bermakna, dibantu pembagian peran tim dan navigator pasien yang memastikan rujukan dan hasil tidak hilang di tengah jalan. Ketika tiga poros ini bergerak serempak, partisipasi tumbuh karena manfaatnya dirasakan, prosesnya dihormati, dan jalannya dimudahkan.

Arah ke depan menuntut disiplin evaluasi yang sederhana namun konsisten. Fasilitas perlu memantau berapa banyak undangan yang berujung kunjungan, berapa banyak hasil abnormal yang ditindaklanjuti tepat waktu, dan seberapa jelas rencana yang dipahami pasien. Indikator dipecah menurut kelompok agar kesenjangan tampak lalu diperbaiki. Pada saat yang sama, kesejahteraan tenaga kesehatan dijaga melalui jadwal yang realistis, supervisi, dan budaya saling mendukung, karena skrining yang efektif memerlukan konsistensi jangka panjang.

J. Referensi

ACC/AHA. Arnett, D. K., Blumenthal, R. S., Albert, M. A., Buroker, A. B., Goldberger, Z. D., Hahn, E. J., ... Ziaeian, B. (2019). 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease. *Circulation*, 140(11), e596–e646. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000678>

- Alberti, K. G. M. M., Eckel, R. H., Grundy, S. M., Zimmet, P. Z., Cleeman, J. I., Donato, K. A., Fruchart, J.-C., James, W. P. T., Loria, C. M., & Smith, S. C., Jr. (2009). Harmonizing the metabolic syndrome: A joint interim statement of the IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS, and IASO. *Circulation*, 120(16), 1640–1645. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644>
- American Academy of Sleep Medicine. Sateia, M. J., Buysse, D. J., Krystal, A. D., Neubauer, D. N., & Heald, J. L. (2017). Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 13(2), 307–349. <https://doi.org/10.5664/jcsm.6470>
- American College of Radiology. Friedewald, S. M., Rafferty, E. A., Rose, S. L., Durand, M. A., Plecha, D. M., Greenberg, J. S., ... Conant, E. F. (2014). Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. *JAMA*, 311(24), 2499–2507. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.6095>
- ASCCP. Perkins, R. B., Guido, R. S., Castle, P. E., Chelmow, D., Einstein, M. H., Garcia, F., ... Wentzensen, N. (2020). 2019 ASCCP risk-based management consensus guidelines for abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors. *Journal of Lower Genital Tract Disease*, 24(2), 102–131. <https://doi.org/10.1097/LGT.0000000000000525>
- Borson, S., Scanlan, J. M., Chen, P., & Ganguli, M. (2000). The Mini-Cog as a screen for dementia: Validation in a population-based sample. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 15(11), 1021–1027.
- Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., ... Yeboah, J. (2019). 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol. *Journal of the American College of Cardiology*, 73(24), e285–e350. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.11.003>
- Harlow, S. D., Gass, M., Hall, J. E., Lobo, R., Maki, P., Rebar, R. W., ... STRAW+10 Collaborative Group. (2012). Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. *Menopause*, 19(4), 387–395. <https://doi.org/10.1097/gme.0b013e31824d8f40>
- International Diabetes Federation. (2006). The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. IDF.
- ISCD—International Society for Clinical Densitometry. (2019). 2019 ISCD Official

Positions – Adult. <https://iscd.org/learn/official-positions/>

- Kanis, J. A., Johnell, O., Oden, A., Johansson, H., & McCloskey, E. (2008). FRAX and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. *Osteoporosis International*, 19(4), 385–397. <https://doi.org/10.1007/s00198-007-0543-5>
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613. <https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x>
- NAMS—North American Menopause Society. (2020). The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 27(9), 976–992. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001609>
- NAMS—North American Menopause Society. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 29(7), 767–794. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002028>
- Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A brief screening tool for mild cognitive impairment. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4), 695–699. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x>
- NOF—National Osteoporosis Foundation. Cosman, F., de Beur, S. J., LeBoff, M. S., Lewiecki, E. M., Tanner, B., Randall, S., & Lindsay, R. (2014). Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. *Osteoporosis International*, 25(10), 2359–2381. <https://doi.org/10.1007/s00198-014-2794-2>
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>
- U.S. Preventive Services Task Force. Curry, S. J., Krist, A. H., Owens, D. K., Barry, M. J., Caughey, A. B., ... Wong, J. B. (2018). Screening for osteoporosis to prevent fractures: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 319(24), 2521–2531. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.7498>
- U.S. Preventive Services Task Force. Davidson, K. W., Barry, M. J., Mangione, C. M., Cabana, M., Caughey, A. B., ... Wong, J. B. (2021). Screening for colorectal cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 325(19), 1965–1977. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.6238>

- U.S. Preventive Services Task Force. Krist, A. H., Davidson, K. W., Mangione, C. M., Barry, M. J., Cabana, M., ... Wong, J. B. (2021). Screening for prediabetes and type 2 diabetes. *JAMA*, 326(8), 736–743. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.12531>
- U.S. Preventive Services Task Force. Siu, A. L., & USPSTF. (2016). Screening for breast cancer: Recommendations and rationale. *Annals of Internal Medicine*, 164(4), 279–296. <https://doi.org/10.7326/M15-2885>
- U.S. Preventive Services Task Force. Siu, A. L., & USPSTF. (2016). Screening for cervical cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 320(7), 674–686. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.10897>
- U.S. Preventive Services Task Force. Siu, A. L., & USPSTF. (2021). Screening for hypertension in adults: US Preventive Services Task Force reaffirmation recommendation statement. *JAMA*, 325(16), 1650–1666. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.1864>
- WHO—World Health Organization Expert Consultation. (2004). Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. *The Lancet*, 363(9403), 157–163. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)15268-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15268-3)
- WHO—World Health Organization. (2021). WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention (2nd ed.). World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824>

K. Glosarium

Ablasi serviks: Tindakan menghancurkan atau mengangkat jaringan prakanker pada leher rahim dengan energi panas atau dingin agar tidak berkembang menjadi kanker.

Ajar balik: Teknik edukasi untuk memastikan pemahaman, yaitu pasien diminta mengulang inti informasi dan rencana dengan kata-katanya sendiri.

Anamnesis terarah: Wawancara klinis yang fokus pada keluhan dan faktor risiko utama agar penilaian skrining efisien dan tepat sasaran.

Biopsi inti payudara: Pengambilan sampel jaringan payudara dengan jarum berdiameter lebih besar untuk menegaskan diagnosis saat gambaran radiologi mencurigakan.

Cervical cytology Pap smear: Pemeriksaan sitologi dengan mengambil sel di leher rahim untuk mendeteksi perubahan prakanker atau kanker.

Colposcopy kolposkopi: Pemeriksaan leher rahim dengan mikroskop pembesaran untuk menilai lebih rinci lesi yang dicurigai setelah hasil skrining tidak normal.

Decision making bersama shared decision making: Proses memilih pemeriksaan atau terapi melalui dialog mengenai manfaat, risiko, dan preferensi pasien.

Densitometri tulang DXA: Pemeriksaan standar untuk menilai densitas mineral tulang pada tulang belakang lumbal dan leher femur, digunakan menegakkan osteopenia atau osteoporosis.

Depresi perimenopause: Gangguan suasana hati yang dapat muncul atau memburuk pada masa transisi hormonal, dinilai dengan instrumen singkat seperti PHQ 9.

Dislipidemia: Kelainan profil lemak darah seperti LDL tinggi, HDL rendah, dan atau trigliserida tinggi yang meningkatkan risiko kardiovaskular.

Endometrium: Lapisan bagian dalam rahim. Perdarahan pascamenopause adalah tanda peringatan dan perlu evaluasi untuk menyingkirkan kanker endometrium.

Estrogen lokal vagina: Sediaan hormon topikal dosis rendah untuk meredakan sindrom genitourinaria menopause seperti kering dan nyeri saat berhubungan.

FRAX: Kalkulator klinis yang memperkirakan risiko fraktur mayor dalam sepuluh tahun dengan menggabungkan usia, indeks massa tubuh, riwayat fraktur, merokok, alkohol, glukokortikoid, dan faktor lain.

FSH follicle stimulating hormone: Hormon perangsang folikel. Kadarnya cenderung meningkat pada perimenopause karena respons ovarium menurun.

GAD 7: Kuesioner singkat terstandar untuk menilai gejala kecemasan pada orang dewasa.

CHAPTER 4

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DALAM TRANSISI MENOPAUSE

Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Pendampingan psikologis dalam transisi menopause merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan holistik perempuan yang sedang memasuki masa perimenopause hingga postmenopause. Masa transisi ini bukan sekadar peristiwa biologis yang menandai akhir dari fungsi reproduksi, tetapi juga merupakan fase hidup yang membawa perubahan signifikan pada tubuh, pikiran, dan kehidupan sosial seorang perempuan.

1. Gambaran Umum tentang Transisi Menopause

Transisi menopause dimulai dengan fase perimenopause, yaitu periode ketika siklus menstruasi mulai tidak teratur akibat fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Fase ini dapat berlangsung beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti sepenuhnya, yang kemudian diikuti masa postmenopause. Perubahan hormonal yang terjadi bukan hanya memengaruhi organ reproduksi, tetapi juga berdampak pada sistem saraf, metabolisme, kesehatan tulang, fungsi kardiovaskular, serta kondisi kulit dan rambut. Selain perubahan fisik, banyak perempuan mengalami gejala seperti rasa panas mendadak (*hot flashes*), keringat malam, gangguan tidur, nyeri sendi, dan perubahan bentuk tubuh. Semua ini sering kali mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Perubahan Fisik, Hormonal, dan Psikologis

Secara fisik, penurunan kadar estrogen berperan besar terhadap penurunan kepadatan tulang, perubahan distribusi lemak tubuh, dan penurunan elastisitas kulit. Dari sisi hormonal, fluktuasi yang tidak stabil memicu gejala vasomotor dan gangguan siklus menstruasi. Perubahan hormonal ini juga berdampak pada neurotransmitter di otak, yang kemudian memengaruhi kondisi emosional dan kognitif.

Dampak psikologisnya tidak kalah besar. Sebagian perempuan mengalami perubahan suasana hati yang cepat, mudah cemas, perasaan sedih atau depresi, bahkan penurunan kepercayaan diri. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan, perubahan peran di keluarga, atau kekhawatiran terhadap penuaan

turut memperkuat beban emosional. Pada beberapa kasus, gangguan tidur yang disebabkan oleh gejala fisik dapat memperburuk kondisi mental, menciptakan lingkaran masalah yang saling memengaruhi.

3. Urgensi Pendampingan Psikologis untuk Kualitas Hidup Perempuan

Pendampingan psikologis menjadi sangat penting karena dapat membantu perempuan memahami dan menerima perubahan yang terjadi, sekaligus membekali mereka dengan strategi koping yang efektif. Dengan pendampingan yang tepat, perempuan dapat mengelola gejala psikologis, mempertahankan harga diri, dan menjaga hubungan sosial yang sehat.

Konseling dan dukungan emosional yang terstruktur dapat mengurangi rasa cemas, depresi, dan stres yang sering muncul pada masa transisi menopause. Pendampingan ini juga membantu perempuan menemukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, misalnya teknik relaksasi untuk gangguan tidur, edukasi tentang nutrisi untuk kesehatan tulang, atau latihan fisik yang sesuai untuk mempertahankan kebugaran. Selain itu, pendampingan psikologis yang dilakukan secara berkesinambungan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam perawatan kesehatannya sendiri, sehingga mereka lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan menerapkan gaya hidup sehat.

B. Landasan Teoritis Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis bagi perempuan pada masa transisi menopause perlu dibangun di atas dasar teori yang kuat, agar intervensi yang diberikan memiliki landasan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Ada tiga pilar utama yang menjadi rujukan, yaitu teori perkembangan psikologis perempuan usia pertengahan, teori stres dan koping, serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respons emosional.

1. Teori Perkembangan Psikologis Perempuan Usia Pertengahan

Dalam kerangka teori perkembangan psikologis, masa usia pertengahan (sekitar 40–60 tahun) merupakan fase penting di mana perempuan mengalami pergeseran peran, prioritas, dan identitas diri. Menurut Erik Erikson, tahap perkembangan ini berhubungan dengan krisis “generativitas versus stagnasi,” yaitu dorongan untuk memberikan kontribusi bermakna kepada generasi berikutnya dan masyarakat, sekaligus menghadapi risiko merasa terhenti atau tidak produktif. Pada perempuan, transisi menopause menjadi salah satu titik balik yang memicu refleksi mendalam mengenai pencapaian hidup, hubungan sosial, dan makna diri. Perubahan biologis seperti berhentinya menstruasi sering kali dihubungkan dengan berakhirnya masa reproduksi, yang dapat menimbulkan perasaan kehilangan, terutama jika identitas diri selama ini sangat

terkait dengan peran reproduktif. Sebaliknya, bagi sebagian perempuan, fase ini menjadi peluang untuk membebaskan diri dari kewajiban biologis dan memulai fase baru yang lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian pribadi.

2. Teori Stres dan Koping dalam Menghadapi Perubahan Menopause

Perubahan fisik dan hormonal pada masa menopause dapat menjadi sumber stres, baik karena gejala yang mengganggu seperti hot flashes, gangguan tidur, dan penurunan libido, maupun karena implikasinya terhadap citra tubuh dan peran sosial. Lazarus dan Folkman dalam teori stres dan coping menjelaskan bahwa respons terhadap stres ditentukan oleh penilaian kognitif individu terhadap situasi (apakah dianggap sebagai ancaman atau tantangan) dan strategi coping yang digunakan. Koping dapat bersifat berfokus pada masalah (problem-focused coping), seperti mencari informasi medis, menjalani gaya hidup sehat, atau mengikuti terapi, maupun berfokus pada emosi (emotion-focused coping), seperti melakukan relaksasi, meditasi, atau mencari dukungan sosial. Pendampingan psikologis pada masa menopause perlu memfasilitasi kedua bentuk coping ini, sehingga perempuan mampu mengelola gejala sekaligus menjaga kesejahteraan emosionalnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respons Emosional

Respons emosional perempuan terhadap menopause sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Faktor biologis mencakup keparahan gejala fisik, kesehatan umum, dan riwayat medis. Faktor psikologis meliputi kepribadian, harga diri, dan persepsi terhadap penuaan. Perempuan yang memiliki pandangan positif terhadap proses penuaan cenderung mengalami transisi menopause dengan lebih tenang dibanding mereka yang memandangnya sebagai kemunduran. Faktor sosial dan budaya juga berperan penting. Dalam budaya yang menghargai usia dan kebijaksanaan, menopause dapat diterima sebagai tahap kehidupan yang bermartabat, sedangkan di budaya yang menekankan nilai pada penampilan muda dan kesuburan, menopause berpotensi menurunkan rasa percaya diri. Dukungan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk beradaptasi. Akses terhadap informasi yang akurat dan layanan kesehatan yang ramah juga menentukan sejauh mana perempuan dapat memahami dan mengelola perubahan yang terjadi.

C. Dampak Psikologis Transisi Menopause

Transisi menopause membawa dampak yang kompleks pada aspek psikologis perempuan. Perubahan hormonal yang terjadi, terutama penurunan estrogen dan progesteron, memengaruhi sistem saraf pusat dan regulasi neurotransmiter seperti

serotonin, dopamin, dan GABA. Perubahan ini dapat memicu gejala emosional yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, dan perubahan mood yang drastis.

Banyak perempuan melaporkan rasa gelisah tanpa alasan yang jelas, kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan atau masa depan, dan perasaan gugup yang menetap. Pada sebagian individu, hal ini dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Depresi pada masa transisi menopause juga kerap muncul, baik sebagai episode baru maupun sebagai kekambuhan dari riwayat depresi sebelumnya. Penurunan hormon memengaruhi pusat pengaturan emosi di otak, sehingga suasana hati menjadi lebih mudah terganggu. Perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa menyenangkan, serta penurunan motivasi adalah gejala yang sering ditemukan. Perubahan mood yang mendadak—dari bahagia menjadi mudah tersinggung atau marah—juga dapat terjadi tanpa pemicu yang jelas, menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial maupun keluarga.

Gangguan tidur adalah masalah yang sangat umum pada masa ini. Gejala seperti rasa panas mendadak (*hot flashes*) dan keringat malam dapat membangunkan perempuan berulang kali, mengganggu kualitas tidur secara signifikan. Kurangnya tidur yang nyenyak memicu kelelahan di siang hari, penurunan konsentrasi, dan kesulitan mengambil keputusan. Kelelahan kronis ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memperburuk gejala emosional, menciptakan lingkaran masalah antara fisik dan psikologis.

Dampak psikologis transisi menopause juga merembet ke hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Dalam konteks hubungan sosial, perubahan mood dan penurunan energi dapat membuat perempuan menarik diri dari pergaulan atau merasa kurang percaya diri. Di lingkungan kerja, gangguan konsentrasi, lupa, dan kelelahan dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas. Beberapa perempuan mungkin merasa tidak lagi mampu memenuhi tuntutan pekerjaan seperti sebelumnya, yang pada akhirnya menimbulkan stres tambahan. Dalam keluarga, perubahan emosional dapat menimbulkan ketegangan, terutama jika anggota keluarga tidak memahami bahwa perubahan perilaku tersebut terkait dengan proses biologis yang alami. Pasangan atau anak-anak dapat merasa bingung atau tersisih, sementara perempuan merasa tidak dimengerti.

D. Tujuan dan Sasaran Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis pada masa perimenopause dan postmenopause berangkat dari satu tujuan payung yang sederhana namun luas jangkauannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional perempuan di fase transisi biologis yang sarat perubahan ini. Kesejahteraan emosional dimaknai sebagai kondisi ketika emosi

terasa lebih stabil, pikiran lebih jernih, rasa percaya diri tetap terjaga, dan relasi interpersonal berjalan hangat meski gejala fisik atau tantangan sosial tetap ada. Dalam praktik klinis, tujuan umum ini diterjemahkan ke pengalaman yang dapat dirasakan sehari-hari, misalnya tidur lebih nyenyak, lebih mudah menenangkan diri saat cemas, tetap dapat menikmati aktivitas bermakna, serta mampu berkomunikasi dengan pasangan maupun keluarga tanpa mudah tersulut. Karena itu desain pendampingan tidak berhenti pada edukasi atau memberi semangat, tetapi membangun kapasitas psikologis yang konkret sehingga perempuan memiliki kendali atas responsnya, bukan sekadar menunggu gejala mereda dengan sendirinya.

Agar tujuan umum tersebut tidak abstrak, program dirinci menjadi tujuan khusus yang dapat diukur dan ditinjau kemajuannya. Sasaran pertama adalah menurunkan gejala psikologis yang paling sering mengganggu, terutama kecemasan, murung, mudah tersinggung, dan keluhan kognitif ringan seperti sulit fokus. Sejak awal sesi, fasilitator menetapkan garis dasar menggunakan instrumen singkat yang tervalidasi, misalnya PHQ 9 untuk depresi, GAD 7 untuk kecemasan, dan skala insomnia untuk kualitas tidur, lalu menyepakati rencana intervensi dan target realistis, contohnya penurunan skor dua sampai lima poin dalam empat sampai delapan minggu. Intervensi dipilih sesuai profil pribadi, seperti teknik perilaku kognitif untuk mengganti pola pikir otomatis yang memperburuk suasana hati, latihan relaksasi napas dan relaksasi otot progresif untuk menenangkan sistem saraf, terapi perilaku kognitif untuk insomnia bila gangguan tidur dominan, serta strategi manajemen nyeri dan energi bila keluhan muskuloskeletal menonjol. Pada kasus tertentu, pendampingan psikologis disinergikan dengan penatalaksanaan medis, misalnya terapi lokal estrogen untuk sindrom genitourinaria, tata laksana hot flashes non hormonal atau hormonal sesuai indikasi, sebab nyeri dan ketidaknyamanan fisik yang tidak tertangani akan terus memicu gejala emosional.

Sasaran kedua adalah meningkatkan keterampilan coping sehingga perempuan memiliki perangkat kerja yang tetap berguna setelah sesi pendampingan selesai. Keterampilan ini mencakup dua sisi, berfokus pada masalah dan berfokus pada emosi. Komponen berfokus pada masalah meliputi perencanaan hari yang ramah gejala, menata beban kerja pada jam ketika suhu tubuh cenderung naik, menyiapkan pakaian berlapis, mengelola hidrasi, menyusun rutinitas tidur yang konsisten, pengetahuan gizi untuk kestabilan energi dan mood, serta pemetaan pemicu gejala dan cara mengubahnya. Komponen berfokus pada emosi berisi latihan perhatian penuh untuk mengenali sensasi tubuh tanpa panik, teknik grounding saat rasa panas tiba-tiba memicu kecemasan, keterampilan komunikasi

asertif agar kebutuhan dapat disampaikan tanpa pertengkaran, serta pemaknaan ulang terhadap penuaan supaya identitas diri tidak semata ditambahkan pada fungsi reproduksi. Setiap sesi ditutup dengan rencana rumah yang spesifik, misalnya latihan napas 5 sampai 10 menit dua kali sehari, jurnal tidur selama satu minggu, atau percakapan terstruktur dengan pasangan, dan kemajuan ditinjau pada pertemuan berikutnya. Dengan cara ini, tujuan meningkatkan coping tidak tinggal sebagai jargon, tetapi menjadi kebiasaan harian yang bisa dievaluasi dan disempurnakan.

Sasaran ketiga berkaitan dengan menjaga dan memperkuat jejaring dukungan, sebab kesejahteraan emosional tidak tumbuh di ruang hampa. Pendamping menilai peta dukungan yang tersedia, pasangan, keluarga, teman sebaya, komunitas, lalu membantu membuka jalur komunikasi yang sering macet akibat salah paham. Pada mereka yang bekerja, pendampingan menyentuh aspek praktis seperti mengatur jeda singkat saat gejala muncul, menyesuaikan pakaian kerja, dan bernegosiasi realistis terkait beban tugas pada periode gejala berat. Bagi yang merasa kesepian atau tersisih, kelompok dukungan sebaya memberi ruang aman untuk berbagi strategi dan mengurangi rasa hanya saya yang begini. Di sisi klinik, keterhubungan dengan layanan lain, bidan, perawat, dokter, psikolog, disusun rapi agar rujukan untuk keluhan urogenital, tulang, atau kardiometabolik tidak tersendat, sebab keberhasilan psikologis sulit dicapai bila masalah medis tidak ditangani.

Kelompok sasaran pendampingan mencakup perempuan di masa perimenopause hingga postmenopause dengan rentang kebutuhan yang beragam. Perimenopause awal umumnya membutuhkan edukasi dan deteksi dini, mengenali pola gejala, mematahkan mitos, serta menyiapkan rencana tidur dan aktivitas. Perimenopause akhir, ketika fluktuasi hormon kerap lebih drastis, biasanya membutuhkan fokus pada regulasi emosi, manajemen hot flashes, dan negosiasi peran di rumah maupun kantor yang mulai terasa berat. Postmenopause membawa kebutuhan yang berbeda, antara lain konsistensi kebiasaan gaya hidup, perawatan relasi dan seksualitas yang sehat dengan pilihan terapi yang aman, pencegahan kelelahan kronis, serta dukungan makna diri pada fase anak mulai mandiri atau perubahan peran kerja. Pendampingan juga memperhatikan subkelompok yang rentan, misalnya perempuan dengan riwayat depresi atau trauma, penyakit kronis kardiometabolik, menopause dini atau akibat pembedahan, disabilitas, serta mereka yang aksesnya terbatas oleh faktor ekonomi dan geografis. Untuk kelompok terakhir, bentuk layanan disesuaikan, seperti sesi tatap muka berkala yang digabungkan dengan konseling singkat via telepon, materi cetak ramah literasi, dan rujukan ke sumber bantuan biaya transportasi bila tersedia, agar keadilan tidak berhenti pada niat.

Seluruh sasaran di atas akan kuat bila dikawal oleh cara kerja yang akuntabel. Pendampingan menetapkan indikator hasil yang bermakna bagi pasien, tidur lebih pulas, frekuensi ledakan emosi berkurang, kualitas hubungan membaik, bukan hanya skor kuesioner. Progres dipantau pada interval yang disepakati, hambatan dipetakan dengan jujur, misalnya pekerjaan mengganggu jadwal latihan atau efek samping obat menurunkan motivasi, lalu rencana disesuaikan tanpa menyalahkan. Keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan dijaga sejak awal melalui persetujuan yang diinformasikan dan dialog yang setara, sehingga program bukan sesuatu yang dikenakan pada pasien, melainkan sesuatu yang ia miliki dan jalankan.

Dengan menempatkan peningkatan kesejahteraan emosional sebagai tujuan umum, menurunkan gejala dan memperkuat keterampilan coping sebagai tujuan khusus, serta menyasar seluruh spektrum perempuan perimenopause hingga postmenopause dengan perhatian pada kelompok rentan, pendampingan psikologis menjadi intervensi yang nyata manfaatnya. Pendampingan memberi perempuan bahasa untuk memahami tubuhnya, alat untuk mengelola gejala, dan jembatan untuk tetap terhubung dengan orang-orang penting di sekitarnya. Hasil akhirnya bukan sekadar gejala yang lebih ringan, melainkan hidup yang terasa kembali utuh dan bermakna pada fase perubahan yang tidak terelakkan.

E. Prinsip dan Etika Pendampingan

Pendampingan psikologis pada transisi menopause berdiri di atas tiga pilar etis yang saling menopang, yaitu empati dan sikap non judgmental, penjagaan privasi dan kerahasiaan, serta persetujuan yang diinformasikan. Ketiganya bukan sekadar aturan di atas kertas. Ia hadir dalam cara kita membuka percakapan, menyusun rencana, mencatat keputusan, dan menutup sesi. Bila pilar ini dijalankan konsisten, ruang pendampingan menjadi tempat yang aman, berdaya, dan benar-benar menyembuhkan.

Empati dan sikap non judgmental adalah pintu masuk semua percakapan yang bermakna. Empati berarti berusaha merasakan dunia dari sudut pandang klien, tanpa menyamakan atau mengecilkan pengalaman mereka. Pada perempuan yang gelisah karena hot flashes berulang, misalnya, pendamping mengakui beratnya gejala dan efeknya pada tidur serta kepercayaan diri, bukan langsung menasihati. Sikap non judgmental mencegah bahasa yang menyalahkan atau meremehkan. Alih-alih berkata seharusnya ibu bisa lebih kuat, pendamping memilih kalimat yang memvalidasi, seperti perubahan ini nyata dan sulit bagi banyak orang, mari kita lihat mana yang paling mengganggu dan langkah kecil apa yang paling mungkin. Dua keterampilan praktis memperkuat empati. Pertama, refleksi perasaan dan isi, yaitu mengulang makna utama dengan bahasa klien agar mereka merasa dipahami.

Kedua, toleransi jeda, yaitu memberi ruang hening ketika topik sensitif muncul agar emosi dapat turun dengan aman. Empati juga berarti peka budaya. Kata yang pantas di satu lingkungan bisa menyinggung di lingkungan lain. Pendamping menanyakan istilah yang nyaman digunakan klien untuk menyebut tubuh, relasi, atau keyakinan, lalu menyesuaikan bahasa tanpa mengaburkan sains. Dalam konteks trauma, empati berwujud kehati-hatian. Pendamping menghindari pertanyaan yang mengejar detail yang tidak dibutuhkan dan selalu menawarkan pilihan, misalnya apakah Anda ingin membahas bagian ini sekarang atau menundanya sampai merasa siap. Sikap ini memberi rasa kendali yang sangat dibutuhkan ketika tubuh dan emosi terasa berubah cepat.

Menjaga privasi dan kerahasiaan adalah fondasi kepercayaan. Privasi menyangkut ruang fisik, proses, dan jejak data. Ruang pertemuan tertutup rapat, suara tidak mudah terdengar, dan panggilan nama dilakukan tanpa menyinggung isi konsultasi. Dokumen dan layar komputer tidak menampilkan data orang lain. Bila pendamping menggunakan telekonseling, lokasi yang senyap disiapkan dan perangkat klien dipastikan cukup privat sebelum topik sensitif dimulai. Kerahasiaan menyangkut pengelolaan informasi. Klien berhak tahu apa yang dicatat, untuk tujuan apa, siapa yang boleh mengakses, berapa lama disimpan, dan bagaimana cara meminta salinan. Akses dibatasi sesuai peran, misalnya psikolog dan dokter yang terlibat langsung boleh membaca catatan klinis, sedangkan bagian administrasi hanya melihat data yang dibutuhkan untuk penjadwalan. Berbagi informasi ke pihak ketiga membutuhkan izin tertulis yang spesifik. Ini membedakan persetujuan untuk menerima layanan dari persetujuan untuk membagikan data. Ada batas kerahasiaan yang diwajibkan hukum dan etika, seperti adanya ancaman nyata untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, kecurigaan kekerasan, atau kondisi darurat medis. Batas ini dijelaskan sejak awal dengan bahasa yang jelas agar tidak terasa sebagai jebakan. Contohnya, sebagian besar hal yang kita bicarakan bersifat rahasia. Jika ada risiko serius terhadap keselamatan Anda atau orang lain, saya wajib mencari bantuan, dan saya akan mengusahakan agar Anda dilibatkan dalam langkah selanjutnya. Di luar kewajiban tersebut, privasi pasien adalah aturan baku. Ketika pasangan atau anggota keluarga ingin bergabung, keputusan tetap pada klien dan pendamping menjelaskan bahwa keterlibatan pihak lain hanya terjadi bila klien menganggapnya bermanfaat dan aman.

Persetujuan yang diinformasikan atau informed consent memastikan setiap langkah pendampingan adalah pilihan sadar, bukan dorongan halus maupun tekanan. Proses ini terdiri dari empat unsur. Pertama, pemberian informasi yang cukup tentang tujuan pendampingan, manfaat yang diharapkan, alternatif pendekatan, serta risiko atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul. Informasi

disampaikan dengan bahasa yang sederhana, contoh yang relevan, dan waktu yang cukup untuk bertanya. Kedua, pemahaman yang memadai. Pendamping tidak berasumsi klien sudah mengerti, tetapi memeriksa dengan teknik ajar balik, misalnya bolehkah Anda menceritakan kembali rencana kita dengan kata-kata Anda, agar saya yakin tidak ada yang terlewat. Ketiga, kesukarelaan. Keputusan diambil tanpa paksaan, manipulasi, atau janji yang berlebihan. Bila pasangan, keluarga, atau atasan terlibat, pendamping menjaga agar suara klien tetap utama. Keempat, kapasitas untuk mengambil keputusan. Pada umumnya perempuan di fase ini memiliki kapasitas penuh. Bila keraguan muncul karena depresi berat atau kebingungan sementara, pendamping menunda keputusan penting, memperjelas informasi, atau melibatkan dukungan klinis yang sesuai hingga kapasitas kembali memadai. Persetujuan bersifat dinamis, bukan sekali tanda tangan untuk selamanya. Ketika rencana berubah, misalnya dari konseling individual ke sesi keluarga atau dari pertemuan tatap muka ke daring, persetujuan diperbarui kembali. Hal yang sama berlaku pada intervensi baru, penggunaan kuesioner, atau rujukan yang memerlukan pertukaran data.

Ketiga pilar ini bertemu dalam praktik sehari-hari. Sesi dimulai dengan kontrak kerja yang singkat. Pendamping menjelaskan cara kerja layanan, batas kerahasiaan, durasi dan frekuensi pertemuan, biaya bila ada, serta bagaimana menghubungi layanan darurat. Setelah kebutuhan utama dipetakan, pendamping dan klien menyusun tujuan yang bermakna dan terukur, misalnya mengurangi ledakan emosi menjadi kurang dari dua kali per minggu, tidur pulas empat malam per minggu, atau berdialog dengan pasangan tanpa pertengkaran selama dua pekan berturut-turut. Setiap rencana disertai alasan mengapa strategi dipilih, apa alternatifnya, dan bagaimana mengevaluasi hasil. Catatan dibuat ringkas, faktual, dan fokus pada keputusan klinis. Catatan tidak menilai pribadi, tidak menyisipkan opini moral, dan menyimpan kutipan hanya jika penting untuk pemahaman tim. Pada akhir sesi, pendamping merangkum poin kunci, memastikan ada rencana rumah yang realistis, dan menyepakati waktu tindak lanjut. Jika hasil skrining atau rujukan dari layanan lain tiba, pendamping meninjau bersama klien, memaknai implikasinya, lalu memperbarui rencana. Bila klien memilih menunda atau menolak suatu pemeriksaan, keputusan dihormati setelah risiko dan alternatif dijelaskan. Menghormati otonomi bukan berarti melepas begitu saja. Pendamping tetap menawarkan cara memantau kondisi dan membuka pintu untuk evaluasi ulang di kemudian hari.

Menjaga etika juga berarti menjaga diri sebagai profesional. Pendamping memperhatikan risiko hubungan ganda dan konflik kepentingan. Ia menghindari situasi di mana hubungan di luar klinik dapat memengaruhi objektivitas, misalnya

menjadi atasan atau rekan bisnis klien. Supervisi rutin dan diskusi kasus dilakukan ketika muncul kebuntuan klinis atau dilema etis, sebagai bagian dari akuntabilitas dan pembelajaran berkelanjutan. Di era layanan digital, keamanan informasi mendapat perhatian khusus. Perangkat dilindungi sandi yang kuat, dokumen dienkripsi, dan file sensitif tidak dikirim melalui kanal yang tidak aman. Bila menggunakan pesan singkat untuk pengingat, konten diatur netral dan tidak menyebutkan diagnosis. Semua ini disampaikan terbuka kepada klien agar mereka tahu bagaimana data mereka dilindungi.

F. Teknik dan Pendekatan Pendampingan

Pendampingan psikologis dalam transisi menopause bekerja paling baik ketika ia dirancang seperti sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Di satu sisi ada ruang aman untuk berbicara dari hati ke hati, di sisi lain ada seperangkat keterampilan yang dilatih berulang sampai menjadi kebiasaan baru. Pendamping memilih kombinasi metode, memulai dari kebutuhan yang paling mendesak, lalu memperluas jangkauan agar perubahan yang dicapai bertahan dalam keseharian. Empat jalur yang paling sering digunakan adalah konseling individual dan terapi kelompok, terapi kognitif perilaku, latihan mindfulness dan teknik relaksasi, serta pendekatan yang melibatkan keluarga dan komunitas. Masing masing mempunyai cara kerja dan tujuan yang saling melengkapi.

Konseling individual memberi tempat yang privat untuk memetakan persoalan dan menyusun peta jalan personal. Sesi pembuka biasanya diisi dengan penjelasan singkat tentang cara kerja layanan, batas kerahasiaan, dan apa yang hendak dicapai bersama. Pendamping menanyakan pengalaman gejala fisik seperti rasa panas mendadak, keringat malam, gangguan tidur, nyeri sendi, serta dampaknya pada suasana hati, konsentrasi, dan relasi. Dari sana dibangun formulasi sederhana yang menjelaskan hubungan antara perubahan tubuh, tekanan peran di rumah dan pekerjaan, serta makna pribadi yang dilekatkan pada fase menopause. Tujuan dibuat jelas dan dapat dicapai, contohnya tidur pulas minimal empat malam per pekan, kemarahan meledak tidak lebih dari dua kali per pekan, atau kemampuan menyampaikan kebutuhan kepada pasangan tanpa pertengkaran. Setiap sesi menutup dengan rencana praktik di rumah, misalnya jurnal tidur selama tujuh hari atau latihan napas dua kali sehari, agar perubahan tidak berhenti di ruang konseling. Di samping jalur individual, kelompok pendampingan menghadirkan kekuatan yang tidak tergantikan, yaitu pengalaman saling menguatkan. Banyak perempuan merasa lega ketika menyadari bahwa yang mereka alami bukan kelemahan pribadi melainkan pola yang umum pada masa transisi. Kelompok biasanya berisi delapan sampai dua belas peserta, berlangsung selama enam sampai delapan pertemuan,

dan dipandu oleh fasilitator terlatih. Di dalamnya peserta mempelajari keterampilan yang sama seperti di sesi individual, tetapi dengan kesempatan berbagi strategi yang berhasil di dunia nyata. Kontrak kerahasiaan, aturan berbicara yang saling menghormati, dan penanganan topik sensitif diatur sejak awal agar kelompok tetap aman dan produktif.

Terapi kognitif perilaku menjadi kerangka kerja yang teruji untuk mengurai simpul antara pikiran, emosi, tubuh, dan tindakan. Pada gangguan tidur, misalnya, pendamping menstrukturkan kembali kebiasaan tidur yang tidak membantu, mengurangi waktu berbaring tanpa tidur, menata rutinitas malam yang konsisten, dan mengubah keyakinan yang memicu cemas seperti rasa takut tidak dapat berfungsi keesokan hari. Pada kecemasan, teknik identifikasi pikiran otomatis membantu menangkap corak umum seperti menyamaratakan atau membaca pikiran pasangan, kemudian diperiksa bukti pendukung dan penyanggahnya, lalu diganti dengan pikiran alternatif yang lebih seimbang. Bila suasana hati menurun dan motivasi merosot, aktivasi perilaku digunakan untuk mengembalikan ritme kegiatan menyenangkan dan bermakna dengan langkah kecil yang realistis. Pada keluhan vasomotor yang memicu panik, pendamping mengajarkan keterampilan menghadapi gejala saat muncul, misalnya menandai sensasi tubuh tanpa dihakimi, memperlambat pernapasan, dan mengalihkan perhatian ke tugas sederhana yang dapat segera diselesaikan. Terapi kognitif perilaku selalu dipadukan dengan tujuan yang terukur, sehingga kemajuan tidak hanya terasa oleh pasien tetapi juga terlihat pada skor alat ukur singkat yang diisi berkala. Pendekatan ini fleksibel, dapat diterapkan tatap muka maupun jarak jauh, dan dapat disederhanakan menjadi modul mikro untuk perempuan dengan waktu yang terbatas.

Latihan mindfulness dan teknik relaksasi memberi jalan untuk menenangkan sistem saraf yang mudah terpicu pada fase ini. Mindfulness melatih kehadiran penuh pada momen ini dan sekarang, misalnya dengan memperhatikan naik turun pernapasan atau sensasi telapak kaki yang menapak lantai. Ketika rasa panas mendadak datang, keterampilan ini membantu perempuan mengenali sensasi sebagai gelombang yang memuncak lalu mereda, bukan tanda bahaya yang memerlukan panik. Teknik pernapasan diafragma, pernapasan teratur dengan hitungan tertentu, atau pernapasan berbasis variabilitas denyut jantung dipakai untuk menurunkan aktivitas simpatis dengan cepat. Pada saat yang lain, relaksasi otot progresif membantu melepaskan ketegangan di bahu, leher, dan punggung yang sering memburuk oleh kurang tidur. Latihan grounding sederhana seperti menyebut lima hal yang dilihat dan empat hal yang dirasakan memberi jangkar ketika kecemasan meningkat. Bagi yang menyukai pendekatan gerak, yoga lembut, tai chi, atau jalan sadar menghadirkan integrasi pikiran tubuh yang menenangkan

sekaligus aman bagi sendi. Kunci keberhasilan bukan durasi panjang, melainkan keteraturan. Lima sampai sepuluh menit latihan dua kali sehari yang dilakukan konsisten lebih berdampak daripada sesi sporadis yang panjang. Pendamping menilai preferensi dan budaya pasien. Ada yang nyaman dengan meditasi dalam sunyi, ada yang lebih menyukai doa atau zikir sebagai bentuk kehadiran penuh yang sepadan. Bahasa dan bentuk latihan disesuaikan tanpa menghilangkan inti ilmiahnya.

Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas memperluas efek perubahan dari diri ke lingkungan. Banyak ketegangan rumah tangga pada fase ini bukan berasal dari niat buruk, melainkan dari salah paham. Pasangan bingung menghadapi perubahan mood dan menilai perempuan tidak lagi seperti dulu. Anak dewasa menganggap ibu terlalu sensitif. Di ruang pendampingan, percakapan keluarga difokuskan pada tiga hal. Pertama, memberikan kerangka bersama tentang apa itu transisi menopause sehingga perilaku yang terlihat memiliki konteks. Kedua, melatih komunikasi yang lebih empatik. Pendamping membantu menyusun kalimat saya sehingga kebutuhan dapat disampaikan tanpa menyalahkan, sekaligus melatih pihak lain untuk merespons dengan refleksi dan pertanyaan ingin tahu, bukan pembelaan diri. Ketiga, menegosiasikan ulang peran dan ekspektasi. Tugas rumah tangga, jadwal tidur, keintiman, dan aktivitas sosial ditata ulang agar selaras dengan kapasitas yang berubah sementara waktu. Di ruang komunitas, strategi diarahkan pada normalisasi dan akses. Kelas singkat yang dipandu tenaga kesehatan di pusat aktivitas warga, tempat ibadah, atau lingkungan kerja membantu membongkar mitos, memberi strategi praktis, dan menautkan perempuan dengan layanan yang ramah. Kelompok sebaya yang dikelola kader mampu menjadi ruang aman untuk berbagi solusi lokal, seperti cara mengatur seragam kerja yang lebih sejuk, membuat sudut tenang di kios saat rasa panas datang, atau menyusun menu keluarga yang membantu tidur. Di tempat kerja, pendamping dapat membantu manajemen menyusun kebijakan kecil yang berdampak besar, misalnya fleksibilitas jam, akses air minum yang mudah, dan ruang rehat yang nyaman. Semua intervensi komunitas tetap menjaga privasi dan martabat. Tidak ada yang dipaksa mengungkapkan hal pribadi, dan keikutsertaan keluarga atau rekan kerja selalu atas persetujuan perempuan.

G. Materi Pendampingan Psikologis

Materi pendampingan psikologis pada transisi menopause dirancang untuk memberi pemahaman yang benar, keterampilan yang dapat dipraktikkan, dan rencana hidup yang selaras dengan kebutuhan nyata perempuan. Muatannya tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh, tetapi juga bagaimana mengelola

stres, memperbaiki tidur, menjaga harga diri, menata pola hidup, dan membangun strategi adaptasi yang tahan lama. Ketika hal-hal ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dan dikaitkan dengan situasi sehari-hari, perempuan memperoleh kendali kembali atas kesehatannya, bukan sekadar menunggu gejala berlalu.

Bagian pertama adalah edukasi tentang perubahan fisiologis menopause. Tujuannya memberi peta agar keluhan yang muncul terasa masuk akal dan tidak menakutkan. Penjelasan dimulai dari perimenopause ketika produksi estrogen dan progesteron berfluktuasi sehingga siklus haid tidak teratur, muncul rasa panas mendadak, keringat malam, dan perubahan kualitas tidur. Setelah 12 bulan tanpa haid, masuk fase postmenopause ketika estrogen menetap pada kadar rendah. Kekurangan estrogen memengaruhi berbagai sistem. Pada tulang terjadi percepatan resorpsi yang menurunkan kepadatan, sehingga pencegahan fraktur menjadi agenda penting. Pada metabolisme tampak kecenderungan penumpukan lemak di perut, kenaikan LDL, penurunan HDL, dan sensitivitas insulin yang menurun. Pada saluran kemih dan genital dapat muncul kekeringan, nyeri saat berhubungan, sering berkemih, dan infeksi berulang, kini dikenal sebagai sindrom genitourinaria menopause. Di kulit dan jaringan ikat, kolagen berkurang sehingga elastisitas menurun. Di otak, perubahan modulasi neurotransmitter dapat memicu labilnya suasana hati, kecemasan, dan gangguan konsentrasi. Edukasi yang baik menggabungkan sains dan solusi praktis. Misalnya, hot flashes dijelaskan sebagai perubahan setel ulang pusat termoregulasi yang dapat dipicu kafein, alkohol, makanan pedas, ruang panas, atau stres, lalu ditutup dengan kiat menghindari pemicu, pakaian berlapis, kipas portabel, dan teknik pernapasan lambat saat gejala datang. Untuk GSM dijelaskan peran pelembap dan pelumas vagina, latihan dasar panggul, serta pilihan terapi lokal yang aman sesuai indikasi. Edukasi juga menautkan perubahan tubuh dengan skrining yang relevan, seperti penilaian risiko tulang dan kardiometabolik, agar perempuan mengerti mengapa pemeriksaan anjuran itu penting bagi dirinya.

Bagian kedua menyentuh manajemen stres dan pengaturan pola tidur karena dua hal inilah yang paling sering membuat hari terasa berat. Stres diulas melalui kacamata penilaian dan respons. Perempuan diajak mengenali pola pikir yang memperparah tekanan, misalnya menyamaratakan kegagalan kecil sebagai gambaran diri yang buruk, atau menganggap semua orang menilai penurunan performa sebagai kelemahan. Dari sini keterampilan koping diperkenalkan. Untuk stresor yang bisa diubah digunakan langkah pemecahan masalah yang jelas: mendefinisikan masalah spesifik, mengurai pilihan, memilih langkah terkecil yang realistis, menentukan kapan menilai kemajuan, dan menyiapkan rencana cadangan. Untuk stresor yang tidak bisa diubah digunakan keterampilan berbasis emosi seperti

pernapasan diafragma, relaksasi otot progresif, grounding lima indera, atau doa dan zikir yang menenangkan sesuai keyakinan. Keduanya dilatih singkat tetapi teratur, lebih baik lima sampai sepuluh menit dua kali sehari dibanding sesi panjang yang jarang.

Pengaturan pola tidur mengikuti prinsip terapi perilaku kognitif untuk insomnia. Intinya mengembalikan asosiasi tempat tidur hanya untuk tidur dan hubungan intim, menghindari berbaring lama ketika mata tidak mengantuk, dan menata waktu bangun yang konsisten setiap hari. Sore hari diarahkan untuk mengekspos cahaya alami dan aktivitas fisik, malam hari ditata dengan rutinitas yang menenangkan, lampu diredupkan, layar gawai dimatikan satu sampai dua jam sebelum tidur, dan kamar dijaga sejuk serta gelap. Untuk keringat malam dan rasa panas, materi memasukkan kiat menyiapkan segelas air di samping tempat tidur, baju tidur berbahan serap, serta kipas kecil yang mudah dijangkau. Pikiran cemas saat terbangun dilatih dengan teknik menulis cepat kekhawatiran lalu menutup buku, atau prosedur bangun sejenak ke ruangan lain sampai kantuk kembali. Bila setelah beberapa minggu jadwal tidur belum membaik, materi memandu kapan saatnya berkonsultasi untuk intervensi lebih lanjut agar kelelahan tidak menjadi kronis.

Bagian ketiga berfokus pada penguatan harga diri dan perencanaan gaya hidup sehat. Harga diri sering goyah mengikuti perubahan tubuh, peran sosial, atau stereotip tentang penuaan. Materi mengajak perempuan menata ulang narasi dirinya dari identitas yang semata berpusat pada reproduksi ke identitas yang lebih luas: kompetensi yang dibangun, nilai yang dihidupi, hubungan yang dipelihara, dan kontribusi yang diberikan. Latihan self compassion digunakan untuk menantang suara batin yang keras pada diri sendiri. Kalimat yang realistis seperti tubuh saya berubah dan saya tetap berhak nyaman dan dicintai lebih membantu daripada menuntut diri seperti usia dua puluh tahun. Dalam relasi intim, materi memasukkan cara berkomunikasi yang empatik tentang kebutuhan, ketidaknyamanan, dan harapan, disertai pilihan praktis seperti penggunaan pelumas, pelembap, foreplay yang lebih panjang, dan, bila sesuai, konsultasi tentang terapi lokal untuk mengurangi nyeri.

Perencanaan gaya hidup sehat dibuat konkrit dan bertahap. Aktivitas fisik disusun dengan target mingguan yang dapat dicapai, misalnya berjalan cepat tiga puluh menit lima hari per minggu ditambah latihan kekuatan dua kali per minggu dan latihan keseimbangan untuk pencegahan jatuh. Bagi yang baru memulai, tujuan dipecah menjadi sesi pendek sepuluh menit yang akumulatif. Pola makan diarahkan ke pola mediterania yang kaya sayur, buah, biji utuh, kacang, ikan, minyak zaitun, dan protein cukup. Kebutuhan protein harian ditingkatkan agar massa dan fungsi

otot terjaga, sementara kalsium dan vitamin D diperhatikan untuk tulang. Gula tambahan, makanan ultra-proses, garam berlebih, dan alkohol dikurangi, bukan sekadar dilarang, melainkan diganti dengan alternatif yang realistis. Manajemen berat badan menggunakan prinsip defisit kalori yang wajar, pencatatan sederhana asupan, serta pengukuran lingkaran perut sebagai indikator perubahan lemak visceral. Kebiasaan merokok dibahas jujur dan strategi berhenti disertai dukungan farmakologis bila diperlukan. Semua rencana ditulis dalam bentuk tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu dengan satu atau dua indikator kemajuan yang akan ditinjau pada pertemuan berikutnya.

Bagian keempat menyatukan semuanya dalam strategi adaptasi positif. Adaptasi positif adalah kemampuan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan nilai diri dan relasi penting. Materi mengajarkan kerangka pemaknaan: membedakan mana yang hilang dan mana yang lahir baru pada fase ini, lalu menempatkan energi pada hal yang masih dapat dipengaruhi. Reframing digunakan untuk mengubah cara memandang gejala dari musibah mutlak menjadi sinyal tubuh yang bisa dikelola. Latihan syukur singkat setiap hari membantu otak tidak terpaku pada yang sulit. Narasi pribadi dapat dibangun melalui jurnal, menuliskan momen saat berhasil mengatasi serangan panas, atau saat berhasil berdialog dengan pasangan tanpa pertengkaran. Strategi sosial dimasukkan dengan membangun lingkaran dukungan, baik kelompok belajar, sahabat tempat bertukar kabar, maupun komunitas daring yang terpercaya. Di tempat kerja, materi memberi contoh cara bernegosiasi sederhana, seperti meminta fleksibilitas jam, mengambil jeda singkat saat gejala datang, atau memilih pakaian kerja yang lebih sejuk. Di rumah, pembagian tugas ditinjau ulang sehingga beban tidak menumpuk pada satu orang. Untuk mereka yang hidup di wilayah dengan sumber daya terbatas, adaptasi mengambil bentuk yang bumi, misalnya mengganti satu menu gorengan dengan tumisan sederhana, berjalan di gang permukiman, menggunakan kipas angin meja, dan mengatur jam tidur sesuai ritme listrik atau aktivitas keluarga.

Seluruh materi tidak berhenti pada dinding kelas. Setiap sesi menutup dengan rencana rumah yang jelas, kapan dicek ulang, dan bagaimana mengukur hasilnya. Umpan balik digunakan untuk memperbaiki materi, misalnya bila latihan napas dirasa terlalu rumit, diganti pola yang lebih sederhana. Jika ritual tidur terhambat oleh kebiasaan keluarga, materi menyertakan percakapan singkat yang dapat dipakai untuk mengajak keluarga bekerja sama. Bila gejala fisik yang berat menghalangi perubahan psikologis, rujukan ke layanan medis tidak ditunda. Pendampingan yang baik menjaga etika, privasi, dan persetujuan yang sadar di seluruh proses, sehingga perempuan merasa dihormati dan aman.

Dengan muatan edukasi yang jernih, keterampilan mengelola stres dan tidur yang dapat dipraktikkan, penguatan harga diri dan rencana hidup sehat yang realistis, serta strategi adaptasi yang menumbuhkan makna, materi pendampingan psikologis menjelma menjadi alat yang nyata manfaatnya. Perempuan belajar memahami tubuhnya, menata ulang harinya, dan memelihara relasi yang penting, sehingga transisi menopause dapat dijalani dengan tenang, berdaya, dan tetap bermakna.

H. Peran Tenaga Kesehatan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan pendampingan psikologis dalam transisi menopause tidak lahir dari satu profesi atau satu ruang praktik saja. Ia muncul ketika bidan, perawat, psikolog, dan dokter bekerja sebagai satu tim yang saling mengisi, lalu membuka diri bermitra dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan media. Pendekatan menyilang seperti ini membuat perempuan menemukan jawaban klinis di fasilitas kesehatan, menemukan dukungan emosi di rumah dan lingkungan kerja, serta menemukan informasi yang jelas dan tidak menghakimi di ruang publik.

Di garda terdepan, bidan sering menjadi pintu masuk pertama. Pertemuan rutin untuk isu kesehatan reproduksi memberi kesempatan yang aman untuk menanyakan gejala yang acap kali disimpan, seperti rasa panas mendadak, kering pada vagina, nyeri saat berhubungan, sering berkemih, perubahan mood, atau sulit tidur. Bidan menghubungkan gejala dengan perubahan fisiologis secara sederhana, lalu menawarkan langkah nyata yang bisa dilakukan hari itu juga. Contohnya, latihan dasar panggul untuk mengurangi kebocoran urine, pemilihan pelumas dan pelembap vagina, rujukan terarah untuk terapi estrogen lokal bila sesuai indikasi, dan cara menghadapi serangan panas menggunakan pernapasan lambat. Pada saat yang sama, bidan menilai kebutuhan skrining kardiometabolik dan tulang, menjelaskan manfaat pemeriksaan, serta menegaskan bahwa semua percakapan berada dalam lingkup kerahasiaan. Pendekatan peka trauma menjadi sikap kerja sehari-hari. Pertanyaan disusun agar tidak memicu ulang pengalaman yang menyakitkan, pilihan diberikan di setiap langkah, dan keterlibatan pasangan atau keluarga dilakukan hanya bila pasien merasa aman dan terbantu.

Perawat memperkuat kontinuitas. Mereka menata alur kunjungan agar satu waktu singkat dapat mencakup pengukuran tekanan darah, berat dan lingkar perut, pengisian kuesioner singkat untuk gejala psikologis, dan konseling gaya hidup dengan sasaran yang realistis. Perawat menjadi koordinator perawatan yang menghubungkan hasil laboratorium, jadwal mammografi atau DXA, dan rencana tindak lanjut. Di banyak fasilitas, perawat memimpin kelas kelompok kecil tentang manajemen stres, higiene tidur, dan latihan napas, sekaligus memantau kepatuhan

rencana rumah melalui panggilan singkat atau pesan yang menjaga privasi. Bila ada hasil tidak normal, perawat melakukan panggilan yang menenangkan, menjelaskan arti temuan, dan mengatur rujukan tanpa membuat pasien merasa tersalahkan atau dilepas sendirian.

Psikolog memegang peran pada asesmen dan intervensi psikologis yang lebih mendalam. Ia menilai derajat kecemasan, depresi, insomnia, serta pola pikir otomatis yang memperkeruh suasana hati. Terapi perilaku kognitif digunakan untuk mengembalikan ritme kegiatan yang bermakna, mengganti distorsi kognitif dengan cara pandang yang lebih seimbang, dan menata ulang kebiasaan tidur yang keliru. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia, latihan perhatian penuh, teknik grounding, dan pelatihan komunikasi asertif membantu perempuan menghadapi gejala yang datang tiba tiba dan tetap bisa menjalankan peran harian. Pada isu relasi dan seksualitas, psikolog memfasilitasi percakapan pasangan agar kebutuhan bisa disampaikan tanpa menyalahkan, serta membantu membangun kembali keintiman yang nyaman. Di tingkat layanan, psikolog ikut merancang modul kelompok sebaya, melatih tenaga kesehatan lain dalam keterampilan konseling singkat, dan mengembangkan indikator sederhana yang memantau perubahan yang benar benar dirasakan pasien, misalnya frekuensi terbangun di malam hari atau jumlah percakapan sulit yang dapat dilalui tanpa pertengkaran.

Dokter berperan memastikan keamanan klinis, menegaskan diagnosis banding, dan mengintegrasikan penatalaksanaan medis dengan pendampingan psikologis. Ia menilai apakah keluhan yang tampak sebagai gejala menopause bukan tanda penyakit lain, seperti hipertiroid, diabetes yang belum terdeteksi, atau gangguan irama jantung. Dokter membahas pilihan terapi vasomotor, baik non hormonal maupun hormonal, dengan telaah manfaat dan risiko yang jujur serta menghormati preferensi pasien. Ia mengelola komorbid seperti hipertensi, dislipidemia, dan pradiabetes, serta memulai atau menyesuaikan obat osteoporosis ketika risiko fraktur tinggi. Pada keluhan urogenital yang persisten, dokter menilai kebutuhan rujukan ke uroginekologi atau urologi. Semua keputusan dicatat ringkas dan dapat dipahami, lengkap dengan alasan klinis, alternatif yang tersedia, dan rencana pemantauan efek samping.

Agar kerja tim berjalan mulus, diperlukan mekanisme penghubung yang sederhana tetapi disiplin. Setiap kunjungan berakhir dengan rencana tertulis yang memadukan sudut pandang semua profesi. Bidan menuliskan latihan dasar panggul dan rencana keintiman yang nyaman, perawat menuliskan target aktivitas fisik dan jadwal ulang pemeriksaan, psikolog menuliskan latihan napas dan tugas kognitif singkat, sedangkan dokter menuliskan penyesuaian obat atau rujukan. Navigator pasien, yang bisa berasal dari staf administrasi terlatih, memastikan rujukan, jadwal,

dan hasil bergerak tanpa terputus. Sistem informasi tidak perlu rumit untuk berguna. Daftar tindak lanjut mingguan yang memuat siapa, apa hasil, apa langkah berikut, serta tenggat waktu sudah cukup untuk menekan kasus tercecer. Privasi tetap menjadi pagar. Hanya informasi yang relevan yang dibagikan antar profesi, dan pasien diberi tahu siapa saja yang akan mengakses catatan serta untuk tujuan apa.

Di luar fasilitas, kolaborasi lintas sektor memperluas jangkauan dan menurunkan hambatan. Kerja sama dengan komunitas dimulai dengan menghormati struktur yang sudah hidup. Posyandu lansia, kelompok pengajian, arisan RT, komunitas senam, koperasi pasar, dan serikat pekerja menjadi ruang belajar yang akrab. Tenaga kesehatan hadir bukan sebagai pengkhotbah, melainkan sebagai mitra yang mendengar dan menjawab kebutuhan nyata. Kelas singkat tentang mitos dan fakta menopause, cara menata tidur, dan strategi menghadapi rasa panas bisa digelar di balai warga dengan pengaturan privasi yang baik. Hari layanan bergerak untuk pengambilan sampel skrining serviks atau penilaian risiko tulang dapat menekan biaya transportasi. Tokoh perempuan setempat dilatih sebagai duta untuk membantu membuat janji, mendampingi prosedur yang membuat cemas, dan memastikan informasi yang sampai tidak melukai martabat. Pada komunitas pekerja, puskesmas dan klinik praktik bersama manajemen pabrik atau kantor untuk menyediakan pemeriksaan dasar di tempat kerja, jam layanan yang lebih pagi atau lebih sore, serta sudut rehat yang sejuk agar gejala vasomotor tidak mengganggu produktivitas.

Lembaga pendidikan memberi dua manfaat sekaligus, yaitu menyiapkan tenaga dan menyebarkan pengetahuan yang benar. Kurikulum kebidanan, keperawatan, kedokteran, dan psikologi memasukkan modul menopause yang menekankan komunikasi empatik, pendekatan peka trauma, dan kolaborasi multiprofesi. Mahasiswa terlibat dalam proyek berbasis komunitas, melakukan edukasi di posyandu lansia atau klub senam, sekaligus belajar mendengar cerita hidup dan bahasa lokal yang sering tidak tertangkap buku teks. Kampus dan sekolah menengah juga dapat menjadi kanal edukasi keluarga. Materi untuk orang tua murid misalnya membahas bagaimana anak dewasa memahami perubahan pada ibunya, cara membantu tanpa meremehkan, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Kemitraan riset antara akademisi dan fasilitas layanan membantu mengevaluasi program secara nyata, bukan hanya berdasarkan jumlah brosur yang dibagikan, tetapi pada perubahan tidur, gejala cemas, dan pengalaman layanan yang dirasakan.

Media melipatgandakan dampak bila digunakan dengan etika. Radio lokal, koran komunitas, kanal WhatsApp, dan akun media sosial resmi fasilitas dapat menyampaikan pesan yang singkat, jelas, dan berbasis bukti. Cerita nyata yang

menonjolkan pemulihan dan strategi sederhana lebih mudah diingat daripada istilah rumit. Konten video satu menit tentang perbedaan Pap smear dan tes HPV, infografik cara menyiapkan mammografi, atau panduan napas lambat untuk menghadapi serangan panas akan lebih bermanfaat daripada narasi sensasional yang menakut-nakuti. Semua materi menjaga privasi. Tidak ada identitas pasien yang diungkap tanpa izin tertulis yang sangat jelas. Bahasa disesuaikan dengan variasi literasi dan budaya, termasuk padanan dalam bahasa daerah bila diperlukan. Media juga dipakai sebagai kanal navigasi. Pesan pengingat yang sopan dan netral mengenai jadwal kontrol, tautan untuk membuat janji, dan nomor kontak yang merespons cepat memudahkan pasien tanpa menambah kecemasan. Fasilitas menetapkan standar moderasi agar percakapan publik tidak berubah menjadi ruang stigma.

Kolaborasi lintas sektor perlu diikat oleh tujuan bersama yang operasional. Tim lintas profesi dan lintas institusi menyepakati indikator yang bermakna, seperti proporsi pasien yang menyelesaikan tindak lanjut hasil abnormal dalam jangka waktu tertentu, perbaikan skor tidur dan kecemasan pada empat sampai delapan minggu, serta kepuasan pasien terhadap kejelasan rencana. Data dipecah menurut wilayah, tingkat pendidikan, dan kondisi rentan untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Umpan balik pasien dikumpulkan singkat dan digunakan untuk memperbaiki layanan. Misalnya, bila banyak perempuan mengeluh ruang pemeriksaan panas, maka prioritas bukan menambah brosur, tetapi memperbaiki ventilasi dan menyediakan kipas. Bila banyak yang gagal hadir karena bentrok jam kerja, maka solusi berupa jam layanan sore atau akhir pekan dibahas bersama pengelola layanan dan komunitas.

I. Evaluasi Keberhasilan Pendampingan

Evaluasi keberhasilan pendampingan psikologis pada transisi menopause perlu dirancang seperti jembatan yang menghubungkan pengalaman klien di ruang konseling dengan perubahan yang benar benar terasa di rumah, di tempat kerja, dan dalam relasi. Tujuannya bukan hanya menunjukkan bahwa sebuah program berjalan, melainkan memastikan bahwa gejala psikologis berkurang, kualitas hidup meningkat, dan klien merasa diperlakukan dengan hormat serta mendapatkan manfaat yang bermakna. Agar hal itu tercapai, evaluasi menggabungkan indikator hasil yang jelas, metode pengukuran yang kokoh, serta rencana tindak lanjut yang menjaga perubahan tetap bertahan.

Indikator keberhasilan pertama menyasar gejala psikologis yang paling sering mengganggu pada fase ini, yaitu kecemasan, suasana hati murung, mudah tersinggung, dan gangguan tidur. Sejak awal, program menetapkan garis dasar

dengan alat ukur singkat yang sudah tervalidasi, misalnya kuesioner depresi dan kecemasan, skala insomnia, atau buku catatan tidur satu minggu. Hasil awal ini dipakai untuk menyusun target yang realistis sesuai konteks klien, misalnya penurunan skor kecemasan beberapa poin dalam empat sampai delapan minggu atau bertambahnya malam dengan tidur nyenyak menjadi minimal empat malam per pekan. Di luar angka, konselor menangkap penanda klinis yang sering lebih bermakna bagi klien, seperti berkurangnya ledakan emosi, munculnya kembali minat pada kegiatan yang dahulu disukai, atau kemampuan mengelola serangan panas tanpa panik. Indikator proses seperti kehadiran sesi, keterlibatan dalam latihan rumah, dan kesesuaian pelaksanaan teknik juga dicatat agar hasil tidak dibaca terpisah dari upaya yang dilakukan.

Indikator keberhasilan kedua menilai kualitas hidup yang luas, karena gejala yang membaik tidak selalu otomatis membuat hari hari terasa lebih baik bila fungsi tetap terhambat. Kualitas hidup dievaluasi pada beberapa ranah: vitalitas dan energi, partisipasi sosial, kemampuan bekerja dan mengelola rumah tangga, rasa nyaman dalam relasi intim, serta persepsi kendali atas kesehatan. Beberapa program memilih kuesioner kualitas hidup umum yang ringkas, yang mudah diisi berulang tanpa membebani klien. Selain itu, klien diajak menetapkan satu atau dua tujuan yang sangat personal melalui pendekatan pencapaian tujuan, misalnya sanggup mengikuti rapat tanpa meninggalkan ruangan saat rasa panas datang atau sanggup berdialog dengan pasangan tentang keintiman tanpa pertengkaran. Ketika tujuan personal tercapai, dampaknya sering lebih besar daripada penurunan angka gejala semata.

Indikator keberhasilan ketiga adalah pengalaman dan kepuasan klien. Kepuasan tidak dinilai hanya dengan satu pertanyaan sangat puas atau tidak, tetapi melalui dua lapis pertanyaan yang menangkap substansi dan rasa. Lapisan substansi menilai kejelasan informasi, kegunaan materi latihan, kemudahan akses, dan ketepatan waktu tindak lanjut. Lapisan rasa menilai apakah klien merasa dihormati, apakah konselor mendengar tanpa menghakimi, dan apakah rencana dibuat bersama, bukan dipaksakan. Umpan balik singkat pada akhir sesi atau setelah program selesai, dilengkapi ruang komentar terbuka, memberikan petunjuk konkret tentang apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki. Kepuasan juga dibaca lewat perilaku, misalnya apakah klien merekomendasikan layanan kepada sahabat atau kembali untuk sesi penguatan beberapa bulan kemudian.

Agar tiga jenis indikator di atas dapat dipercaya, program menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif memberikan gambaran perubahan yang terukur, seperti skor gejala, jumlah malam tidur nyenyak, atau frekuensi ledakan emosi mingguan. Pengukuran dilakukan sebelum intervensi,

saat pertengahan, dan pada penutupan, kemudian diulang pada masa tindak lanjut. Perubahan tidak hanya dilihat secara statistik, tetapi juga dilihat apakah melampaui ambang perubahan yang dirasakan bermakna bagi klien. Metode kualitatif melengkapi angka dengan cerita, yaitu wawancara singkat, catatan refleksi, atau pertemuan kelompok kecil yang menggali momen perubahan paling berarti menurut klien. Dari sini tim belajar mengapa strategi tertentu efektif pada sebagian orang tetapi tidak pada yang lain, hambatan apa yang muncul di rumah atau tempat kerja, dan penyesuaian apa yang membuat latihan lebih mudah dijalankan. Kombinasi angka dan cerita ini mencegah evaluasi terjebak pada salah satu sisi saja.

Evaluasi yang baik juga memperhatikan keadilan dan konteks. Hasil dipecah menurut kelompok usia, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, serta kondisi khusus seperti menopause dini atau pascabedah. Tujuannya agar tidak ada kelompok yang tampak ikut membaik pada rata-rata, padahal tertinggal ketika dilihat lebih dekat. Waktu pengukuran dipilih agar ramah bagi klien. Kuesioner yang terlalu sering justru menambah beban dan menurunkan akurasi jawaban. Karena itu banyak program memilih ritme sederhana: awal, pertengahan, akhir, dan tindak lanjut beberapa bulan kemudian. Di sisi lain, perlindungan data dan etika dijalankan tanpa kompromi. Klien diberi penjelasan tentang apa yang diukur, untuk apa data dipakai, siapa yang boleh melihat, serta bagaimana meminta salinan atau menarik persetujuan. Pengukuran tidak boleh memicu ulang pengalaman yang menyakitkan, sehingga pertanyaan sensitif dipilih hati-hati dan konselor siap menurunkan intensitas jika klien tampak tidak nyaman.

Hasil evaluasi baru berguna bila kembali menjadi perbaikan yang nyata. Setelah gelombang program selesai, tim mengadakan pertemuan untuk meninjau capaian terhadap target, menelaah catatan hambatan, dan menyusun perubahan kecil yang segera dicoba pada gelombang berikutnya. Jika skor insomnia turun tetapi kepuasan klien rendah karena jadwal sesi berbenturan dengan jam kerja, solusinya bukan menambah materi tidur, tetapi membuka slot di sore atau akhir pekan. Bila kecemasan turun namun hubungan pasangan tetap tegang, tim menambahkan modul komunikasi pasangan singkat atau memperkuat rujukan ke konseling pasangan. Bila kelompok tertentu tertinggal, misalnya perempuan di daerah yang sulit akses transportasi, program menambah sesi jarak jauh atau kolaborasi di komunitas setempat. Dengan cara ini, evaluasi menjadi siklus belajar, bukan sekadar laporan yang disimpan.

Bagian terakhir yang menentukan adalah tindak lanjut pasca program. Banyak perubahan psikologis bersifat mudah surut bila tidak dirawat. Karena itu setiap klien pulang dengan rencana pencegahan kekambuhan yang jelas. Rencana ini merangkum pemicu pribadi, strategi yang paling membantu, tanda dini gejala

kembali menguat, serta langkah yang akan diambil bila itu terjadi. Jadwal penguatan disepakati sejak awal, misalnya panggilan atau sesi singkat pada satu, tiga, dan enam bulan. Pada kontak ini konselor meninjau latihan yang masih dikerjakan, menyesuaikan tujuan, dan mengatasi hambatan baru yang muncul. Untuk mereka yang nyaman dengan teknologi, pengingat latihan napas, jurnal tidur digital, atau pesan motivasi singkat menjaga ritme tanpa terasa menggurui. Untuk mereka yang lebih cocok tatap muka, pertemuan penguatan berkala atau kelompok sebaya menjadi jangkar. Jika pada masa tindak lanjut muncul gejala yang menandakan perlunya eskalasi, seperti depresi berat, pikiran menyakiti diri, atau nyeri urogenital yang menetap, jalur rujukan klinis diaktifkan tanpa menunda sambil memastikan klien tidak merasa ditinggalkan.

Evaluasi juga menyentuh dimensi keberlanjutan layanan. Tim memantau apakah intervensi yang terbukti membantu dapat dijalankan dengan sumber daya yang ada, siapa yang perlu dilatih agar kapasitas tidak bergantung pada individu tertentu, dan bagaimana menjaga semangat tim agar tidak kelelahan. Indikator sederhana seperti proporsi hasil abnormal yang ditindaklanjuti tepat waktu, jumlah klien yang kembali pada tindak lanjut, dan persepsi jelasnya rencana oleh klien menjadi kompas mutu harian.

J. Tantangan dan Strategi Mengatasi Hambatan

Pendampingan psikologis dalam transisi menopause sering kali menghadapi rintangan yang tidak kecil. Hambatan itu muncul dari cara masyarakat memandang isu kesehatan mental, dari keterbatasan sumber daya layanan, dan dari desain pendampingan yang kadang belum selaras dengan realitas hidup perempuan. Agar program tidak berhenti pada niat, hambatan perlu diurai secara jujur lalu ditangani dengan strategi yang terukur, empatik, dan peka konteks.

Stigma dan rendahnya literasi kesehatan mental adalah batu sandungan pertama. Di banyak lingkungan, membicarakan kecemasan, mood yang berubah cepat, atau menurunnya gairah hidup masih dianggap kelemahan pribadi yang seharusnya ditutupi. Menyebut keluhan intim seperti nyeri saat berhubungan atau kebocoran urine kerap memicu rasa malu. Minimnya pemahaman tentang transisi menopause membuat perempuan menganggap semua keluhan sebagai nasib usia, sehingga mereka tidak mencari bantuan atau baru datang ketika masalah sudah menahun. Cara mengatasinya bukan dengan menggurui, melainkan dengan memperbaiki bahasa dan ruang dialog. Konselor membuka sesi dengan kerangka ilmiah yang sederhana, misalnya menjelaskan bahwa hot flashes berasal dari pusat termoregulasi yang lebih sensitif, atau bahwa perubahan tidur terkait dengan fluktuasi hormon yang mempengaruhi sistem saraf. Penjelasan semacam ini

menggeser narasi dari salah saya menjadi yang terjadi pada tubuh saya. Materi edukasi disesuaikan dengan literasi setempat, menggunakan contoh sehari-hari, gambar yang sopan, dan istilah yang akrab. Di komunitas, cerita nyata jauh lebih efektif daripada slogan. Ketika seorang perempuan menceritakan bagaimana latihan napas membantunya melewati rapat tanpa panik, pesan terasa masuk akal dan tidak menghakimi. Untuk mengikis stigma, proses layanan juga harus bebas dari sikap menyalahkan. Setiap komentar yang menyepelkan keluhan, tanya jawab yang terlalu mengorek tanpa alasan klinis, atau candaan yang menyentuh tubuh klien akan memperkuat keyakinan bahwa lebih aman diam daripada meminta tolong. Pelatihan komunikasi empatik dan peka trauma bagi seluruh staf menjadi investasi awal yang menentukan.

Keterbatasan sumber daya dan akses layanan adalah hambatan kedua. Di banyak tempat, waktu tenaga kesehatan habis untuk administrasi, sementara slot konseling terlalu sedikit. Fasilitas yang nyaman dan privat tidak selalu tersedia. Pemeriksaan penunjang seperti mammografi atau DXA mungkin jauh dari jangkauan. Akses digital belum merata, kuota data mahal, dan perangkat bersama dengan anggota keluarga lain. Karena itu strategi harus hemat langkah, hemat biaya, dan bersahabat dengan logistik. Prinsip satu kunjungan yang bermakna membantu mengurangi bolak-balik. Dalam satu kali datang, klien menerima penilaian gejala, konseling singkat yang fokus, rencana rumah yang jelas, dan bila perlu surat rujukan yang sudah disiapkan lengkap agar tidak perlu kembali hanya untuk administrasi. Tugas dibagi menurut kewenangan. Bidan atau perawat memimpin skrining dan edukasi inti, psikolog menangani kasus dengan kebutuhan terapi khusus, dokter memastikan aspek klinis tetap aman. Materi diberikan dalam dua bentuk, cetak ringkas dan digital ringan, sehingga klien tetap bisa belajar meski sinyal atau kuota terbatas. Jika penggunaan gawai tidak memungkinkan, pengingat tindak lanjut dapat dilakukan melalui panggilan singkat yang terjadwal. Di daerah dengan hambatan transportasi, kerja sama dengan komunitas untuk membuat titik temu terdekat atau jadwal layanan bergerak memperkecil jarak dan biaya tersembunyi seperti kehilangan pendapatan harian atau biaya menjaga cucu. Semua ini berangkat dari pertanyaan yang sederhana namun penting, yaitu apa yang membuat klien paling sering batal hadir, kemudian sistem diperbaiki pada titik itu.

Strategi peningkatan efektivitas pendampingan berpusat pada penyelarasan program dengan kehidupan klien. Pertama, buat tujuan yang bermakna dan terukur bagi klien, bukan hanya bagi penyedia layanan. Bukan sekadar skor kuesioner menurun, tetapi tidur pulas minimal empat malam per pekan, mampu melewati serangan panas tanpa meninggalkan rapat, atau dapat berdialog dengan pasangan tanpa pertengkaran. Tujuan semacam ini memudahkan evaluasi dan menumbuhkan

rasa berhasil. Kedua, pertahankan porsi latihan yang singkat tetapi konsisten. Lima sampai sepuluh menit latihan napas, catatan tidur satu halaman, atau dua latihan komunikasi per minggu lebih mudah dilakukan daripada tugas panjang yang ambisius namun membuat putus asa. Ketiga, jaga ekosistem dukungan. Kelompok kecil sebaya memberi tempat aman untuk bertukar strategi yang bekerja di dunia nyata, sekaligus menangkal rasa saya sendirian. Keterlibatan pasangan atau keluarga dilakukan dengan restu klien dan fokus pada komunikasi empatik serta negosiasi peran, bukan penghakiman. Keempat, pastikan ada jembatan ke layanan klinis lain. Nyeri urogenital yang dibiarkan akan terus memicu kecemasan, gangguan tidur yang tidak tertangani akan merusak mood, dan hipertensi yang lupa diobati akan membuat pusing di hari hari penting. Pendampingan psikologis dan pengelolaan medis harus berjalan berdampingan.

Efektivitas juga bergantung pada cara tim belajar dari gelombang ke gelombang. Buat indikator sederhana yang dipantau rutin, misalnya proporsi klien yang menyelesaikan tindak lanjut hasil abnormal tepat waktu, persentase yang hadir pada sesi penguatan satu bulan, dan persepsi klien tentang kejelasan rencana. Pecah data menurut kelompok usia, pendidikan, dan lokasi untuk melihat apakah ada yang tertinggal. Setelah itu, lakukan perbaikan kecil yang cepat dicoba. Jika banyak yang absen karena jadwal bertabrakan dengan jam pasar, buka slot layanan lebih pagi. Jika instruksi tidur terasa rumit, sederhanakan menjadi tiga langkah inti dan berikan kartu panduan yang bisa ditempel di kamar. Jika hasil menunjukkan penurunan kecemasan tetapi konflik dengan pasangan tetap tinggi, tambahkan modul komunikasi pasangan singkat yang dapat dijalankan sendiri di rumah. Gunakan evaluasi kualitatif untuk menangkap hal hal yang tidak terlihat oleh angka, seperti rasa tidak nyaman pada tata ruang atau kebingungan pada istilah tertentu, lalu perbaiki pada siklus berikut.

K. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa pendampingan psikologis dalam transisi menopause bukan sekadar tambahan layanan, melainkan komponen inti dari kesehatan perempuan yang menyatukan sains, empati, dan tata kelola praktik. Menopause menghadirkan perubahan hormonal yang merambat ke tubuh, pikiran, dan relasi sosial. Fluktuasi dan penurunan estrogen tak hanya memicu gejala vasomotor dan gangguan tidur, tetapi juga memengaruhi modulasi emosi, fungsi kognitif, citra diri, serta dinamika keluarga dan pekerjaan. Maka, pendampingan yang efektif harus memandang perempuan secara utuh, menghubungkan keluhan harian dengan mekanisme biologis yang masuk akal, lalu menerjemahkannya menjadi langkah praktis yang bisa dilakukan dari hari ke hari.

Landasan teoritis memberi peta yang kokoh: perempuan usia pertengahan berada pada fase perkembangan psikologis yang sarat peninjauan peran dan makna diri; respons terhadap stres ditentukan oleh cara menilai situasi dan keterampilan koping yang dimiliki; dan variasi respons emosional dipengaruhi jaringan faktor biologis, psikologis, sosial, serta budaya. Kerangka ini membuat intervensi tidak seragam untuk semua orang, melainkan personal dan relevan dengan konteks hidup masing-masing.

Tujuan besar pendampingan adalah meningkatkan kesejahteraan emosional. Tujuan itu dijabarkan menjadi sasaran yang terukur: meredakan gejala psikologis utama, memperkuat keterampilan koping yang dapat dipraktikkan, serta menegakkan jejaring dukungan di rumah dan komunitas. Prinsip etika menjadi pagar mutu harian. Empati dan sikap non menilai menciptakan ruang aman untuk jujur. Privasi dan kerahasiaan melindungi martabat. Persetujuan yang diinformasikan memastikan setiap langkah diambil secara sadar, sejalan dengan nilai dan preferensi klien.

Teknik dan pendekatan yang disarankan saling mengikat. Konseling individual memetakan persoalan dan merancang peta jalan personal, sedangkan terapi kelompok menyalakan daya pemulihan dari pengalaman sebaya. Terapi kognitif perilaku memberi alat untuk mengubah pola pikir yang kontraproduktif, mengaktifkan kembali perilaku bermakna, dan memulihkan kebiasaan tidur. Latihan mindfulness dan relaksasi menenangkan sistem saraf yang mudah terpicu, sementara pendekatan berbasis keluarga dan komunitas memperluas efek perubahan dari diri ke lingkungan, mengurangi salah paham, dan menata ulang peran secara realistis. Materi pendampingan disusun pragmatis: edukasi fisiologi yang membumi, manajemen stres dan tidur yang bisa diulang singkat setiap hari, penguatan harga diri dan relasi intim yang hangat, rencana gaya hidup yang bertahap dan terukur, serta strategi adaptasi positif yang memberi makna pada perubahan.

Keberhasilan program bertumpu pada kerja tim dan kemitraan lintas sektor. Bidan, perawat, psikolog, dan dokter menyatu dalam alur yang ringkas namun jelas perannya, dengan navigator pasien yang memastikan rujukan, hasil, dan jadwal tidak terputus. Di luar fasilitas, komunitas menyediakan ruang percaya, lembaga pendidikan menyiapkan tenaga yang peka dan kompeten, sementara media menyebarkan informasi yang benar sekaligus memudahkan navigasi layanan tanpa mengorbankan privasi. Kolaborasi ini diikat oleh sasaran operasional yang dapat dipantau, sehingga perbaikan berjalan berbasis data dan umpan balik klien.

Evaluasi dirancang sebagai siklus belajar. Indikator hasil tidak berhenti pada angka, tetapi menilai apakah kecemasan mereda, tidur membaik, partisipasi sosial

pulih, dan apakah klien merasa didengar serta dihormati. Metode kuantitatif memberi bukti perubahan yang terukur, metode kualitatif menangkap cerita dan alasan di balik perubahan. Tindak lanjut pasca program menjaga perubahan tetap hidup melalui rencana pencegahan kekambuhan, sesi penguatan, dan jalur eskalasi yang cepat bila gejala kembali menguat.

Hambatan yang sering mengemuka—stigma, literasi kesehatan mental yang rendah, keterbatasan sumber daya, akses layanan yang belum merata—bisa dijinakkan ketika bahasa layanan diperbaiki, alur disederhanakan, biaya tersembunyi diperkecil, dan dukungan sosial digerakkan. Kuncinya adalah menyelaraskan program dengan realitas hidup perempuan, menjaga intervensi tetap singkat namun konsisten, dan memastikan masalah medis yang menyertai ditangani berdampingan.

L. Referensi

-
- American College of Physicians. Qaseem, A., Kansagara, D., Forcica, M. A., Cooke, M., & Denberg, T. D. (2016). Management of chronic insomnia disorder in adults: A clinical practice guideline from the American College of Physicians. *Annals of Internal Medicine*, 165(2), 125–133. <https://doi.org/10.7326/M15-2175>
- Bastien, C. H., Vallières, A., & Morin, C. M. (2001). Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. *Sleep Medicine*, 2(4), 297–307. [https://doi.org/10.1016/S1389-9457\(00\)00065-4](https://doi.org/10.1016/S1389-9457(00)00065-4)
- Buyse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193–213. [https://doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4)
- Erikson, E. H. (1982). *The life cycle completed*. W. W. Norton.
- Greene, J. G. (1998). Constructing a standard climacteric scale. *Maturitas*, 29(1), 25–31. [https://doi.org/10.1016/S0378-5122\(98\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00025-5)
- Heinemann, L. A. J., Potthoff, P., & Schneider, H. P. G. (2003). International versions of the Menopause Rating Scale (MRS). *Health and Quality of Life Outcomes*, 1, 28. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-1-28>
- Hunter, M. S., & Smith, M. (2014). *Managing hot flushes and night sweats: A cognitive behavioural self-help guide to menopause*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315747219>

- International Menopause Society. de Villiers, T. J., Hall, J. E., Pinkerton, J. V., Pérez, S. C., Rees, M., Yang, C., & Pierroz, D. D. (2016). Revised global consensus statement on menopausal hormone therapy. *Climacteric*, 19(4), 313–315. <https://doi.org/10.1080/13697137.2016.1196047>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- NAMS—North American Menopause Society. (2020). The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 27(9), 976–992. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001609>
- NAMS—North American Menopause Society. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 29(7), 767–794. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002028>
- NAMS—North American Menopause Society. Faubion, S. S., et al. (2023). *Nonhormone therapy position statement for vasomotor symptoms*. *Menopause*. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002236>
- NICE—National Institute for Health and Care Excellence. (2015, updated 2019). *Menopause: Diagnosis and management (NG23)*. NICE. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng23>
- North American Menopause Society. (2015). Nonhormonal management of menopause-associated vasomotor symptoms: 2015 position statement. *Menopause*, 22(11), 1155–1172. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000546>
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>
- The WHOQOL Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. *Psychological Medicine*, 28(3), 551–558. <https://doi.org/10.1017/S0033291798006667>
- U.S. Preventive Services Task Force. Siu, A. L., & USPSTF. (2016). Screening for depression in adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 315(4), 380–387. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.18392>
- van Driel, M. L., et al. (2018). Interventions for menopausal vasomotor symptoms: An evidence map. *Maturitas*, 120, 88–98. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.11.003>

- Vogel, D. L., Heimerdinger-Edwards, S. R., Hammer, J. H., & Hubbard, A. (2011). "Boys don't cry": Examination of the links between endorsement of masculine norms, self-stigma, and help-seeking attitudes for men from diverse backgrounds. *Journal of Counseling Psychology*, 58(3), 368–382. <https://doi.org/10.1037/a0023688>
- Wathen, C. N., & MacMillan, H. L. (2003). Interventions for violence against women: Scientific review. *JAMA*, 289(5), 589–600. <https://doi.org/10.1001/jama.289.5.589>
- WHO—World Health Organization. (2010). *Measuring health and disability: Manual for WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0*. WHO Press.

M. Glosarium

Aktivasi perilaku

Pendekatan terapi untuk depresi yang berfokus mengembalikan rutinitas aktivitas bermakna dan menyenangkan secara bertahap agar suasana hati pulih dan motivasi meningkat.

Ajar balik

Teknik edukasi untuk memeriksa pemahaman klien dengan meminta ia mengulang inti informasi dan rencana menggunakan kata-katanya sendiri.

Assertive communication komunikasi asertif

Gaya komunikasi yang jelas, jujur, dan menghormati diri sendiri serta lawan bicara saat menyampaikan kebutuhan, batas, dan harapan.

Catastrophizing

Distorsi kognitif ketika seseorang membayangkan hasil terburuk secara berlebihan sehingga kecemasan meningkat.

CBT terapi kognitif perilaku

Terapi berbasis bukti yang menautkan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mengurangi gejala seperti kecemasan, depresi, dan insomnia melalui restrukturisasi kognitif dan latihan perilaku.

Citra diri body image

Penilaian subjektif terhadap tubuh yang dapat berubah selama transisi menopause dan memengaruhi harga diri serta relasi intim.

Daya lenting resiliensi

Kemampuan bangkit kembali dan beradaptasi setelah menghadapi stres atau perubahan yang menantang.

Defisit tidur kronis

Kondisi kekurangan tidur berkepanjangan yang menurunkan konsentrasi, daya ingat, regulasi emosi, dan toleransi stres.

Emotion focused coping koping berfokus emosi

Strategi menghadapi stres dengan mengelola reaksi emosional, seperti relaksasi, mindfulness, doa, atau dukungan sosial.

Empati

Kemampuan memahami dan merasakan pengalaman klien dari sudut pandangnya tanpa menghakimi.

Evaluasi berbasis tujuan goal attainment

Penilaian kemajuan pendampingan menggunakan tujuan yang dipilih klien, misalnya tidur nyenyak empat malam per pekan atau mampu melalui rapat meski terjadi rasa panas mendadak.

Generativitas vs stagnasi

Tahap perkembangan Erikson pada usia pertengahan yang menekankan kontribusi bagi generasi berikut dan risiko merasa terhenti bila makna dan peran tidak diperbarui.

Goreng singkat grounding

Teknik menenangkan diri dengan mengarahkan perhatian ke sensasi saat ini seperti menyebut objek yang dilihat, didengar, atau dirasakan.

GSM sindrom genitourinaria menopause

Kumpulan keluhan akibat defisiensi estrogen pada jaringan urogenital seperti kering dan nyeri vagina, sering berkemih, urgensi, serta rentan infeksi.

Hot flashes rasa panas mendadak

Gejala vasomotor berupa sensasi panas menyebar yang dapat diikuti keringat malam dan berhubungan dengan sensitivitas pusat termoregulasi.

HPA axis poros hipotalamus pituitari adrenal

Sistem stres biologis yang dapat menjadi lebih reaktif pada sebagian perempuan sehingga memengaruhi tidur dan regulasi emosi.

Higiene tidur sleep hygiene

Kebiasaan yang mendukung tidur berkualitas seperti jadwal tidur teratur, redupkan cahaya malam, batasi kafein sore hari, dan hindari layar sebelum tidur.

Informed consent persetujuan yang diinformasikan

Proses memastikan klien mendapat informasi yang memadai, memahami manfaat, risiko, dan alternatif, lalu memutuskan secara sukarela.

Insomnia Severity Index ISI

Instrumen singkat untuk menilai tingkat keparahan insomnia dan memantau respons terapi.

Jurnal tidur sleep diary

Catatan harian waktu tidur, terbangun malam, dan kualitas tidur untuk membantu diagnosis dan terapi insomnia.

Kerahasiaan confidentiality

Prinsip etis bahwa informasi klien disimpan aman, hanya diakses oleh pihak berwenang, dan dibagikan atas izin atau alasan keselamatan.

Kognisi otomatis pikiran otomatis

Pikiran cepat yang sering tidak disadari dan memicu emosi kuat, sasaran utama restrukturisasi kognitif pada CBT.

Koping adaptif

Strategi menghadapi stres yang efektif dan sehat, misalnya pemecahan masalah, dukungan sosial, relaksasi, dan penetapan batas.

Koping maladaptive

Respon yang tampak mengurangi stres sesaat tetapi memperburuk keadaan seperti menarik diri total, menyalahkan diri berlebihan, atau konsumsi alkohol berlebihan.

CHAPTER 5

NUTRISI OPTIMAL DAN GAYA HIDUP SEHAT SELAMA MENOPAUSE

Drg. Arnetty, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Menopause bukan sekadar berhentinya menstruasi, melainkan sebuah transisi biologis yang memengaruhi hampir semua sistem tubuh dan, pada saat yang sama, mengubah ritme keseharian. Penurunan hormon ovarium menggeser cara tubuh mengolah energi, mengatur suhu, menjaga kualitas tidur, memelihara kepadatan tulang, dan menyeimbangkan suasana hati. Pergeseran ini sering muncul sebagai gejala yang terasa sehari-hari, seperti rasa panas mendadak dan keringat malam, mudah lelah, perubahan pola tidur, naiknya berat badan di area perut, keluhan sendi, hingga perubahan kenyamanan urogenital. Karena pengaruhnya menyeluruh, masa transisi ini memerlukan strategi gizi dan gaya hidup yang dirancang khusus. Makanan yang dipilih, cara mengatur porsi dan waktu makan, jenis latihan yang dilakukan, kebiasaan tidur, serta kemampuan mengelola stres dapat memperingan gejala, menekan faktor risiko kardiometabolik, mencegah penurunan massa tulang dan otot, serta menjaga keberanian untuk tetap aktif di keluarga dan komunitas.

Bab ini ditujukan pertama-tama bagi perempuan yang sedang berada pada rentang perimenopause sampai pascamenopause. Perimenopause merujuk pada masa ketika siklus mulai tidak teratur dan gejala muncul lebih nyata, menopause diartikan sebagai henti haid selama dua belas bulan berturut-turut, sementara pascamenopause adalah fase setelahnya ketika penurunan hormon bersifat menetap. Selain pembaca utama tersebut, bab ini juga dirancang untuk para pendidik dan tenaga kesehatan yang mendampingi perempuan di fase ini, termasuk bidan, perawat, dokter layanan primer, ahli gizi, dan kader komunitas. Dengan cakupan pembaca yang beragam, penjelasan disusun agar mudah diterapkan di rumah tangga Indonesia yang nyata, dengan contoh menu Nusantara, alternatif bahan yang terjangkau, serta panduan latihan yang aman untuk berbagai tingkat kebugaran.

Tujuan belajar dalam bab ini bersifat praktis dan terukur. Pembaca diajak memahami perubahan biologis inti selama transisi menopause agar dapat membaca gejala secara jernih dan tidak menyalahkan diri sendiri. Dari dasar biologis tersebut, pembaca akan mampu memilih pola makan yang tepat, bukan sekadar mengikuti

tren. Penekanan diberikan pada kepadatan gizi, kualitas karbohidrat, kecukupan protein harian, lemak sehat, serta peran serat dan hidrasi yang cerdas. Bab ini juga memandu cara menyusun rencana aktivitas fisik yang seimbang antara latihan aerobik, latihan kekuatan, latihan beban tulang, keseimbangan dan mobilitas, termasuk latihan dasar panggul untuk kesehatan urogenital. Semua rencana disesuaikan dengan kondisi sendi, waktu yang tersedia, serta preferensi budaya, sehingga terasa mungkin dijalankan dari minggu ke minggu. Bagian monitoring membantu pembaca memantau kemajuan dengan indikator sederhana yang bermakna, seperti energi harian, kualitas tidur, lingkaran pinggang baju kerja, kemampuan berdiri dari kursi tanpa bantuan, atau keberanian kembali mengikuti aktivitas sosial.

Agar tidak terjadi kerancuan, bab ini menyepakati beberapa istilah kunci yang digunakan konsisten. Istilah perimenopause, menopause, dan pascamenopause dipakai sebagaimana dijelaskan di atas. Gejala vasomotor digunakan untuk menyebut rasa panas mendadak dan keringat malam. Pola makan seimbang dimaknai sebagai susunan yang menekankan sayur dan buah berwarna, biji-bijian utuh, sumber protein berkualitas, lemak sehat, serta pembatasan gula, garam, dan lemak trans. Istilah hidrasi cerdas merujuk pada strategi memenuhi kebutuhan cairan harian sekaligus mengurangi gangguan berkemih malam dengan mengatur jenis dan waktu minum. Aktivitas fisik terencana meliputi porsi aerobik mingguan yang aman, latihan kekuatan dua sampai tiga kali per minggu, serta latihan keseimbangan yang singkat tetapi rutin. Keselamatan selalu menjadi batas, sehingga setiap anjuran akan disertai tanda bahaya yang perlu mendorong konsultasi langsung.

Manfaat praktis dari pendekatan terpadu ini diharapkan terasa sejak bulan pertama penerapan. Pemilihan menu dengan kepadatan gizi yang baik membantu menstabilkan energi dan suasana hati, sementara distribusi protein yang merata sepanjang hari mempertahankan massa dan kekuatan otot. Pengaturan indeks glikemik dan porsi realistis membantu mengendalikan lingkaran pinggang serta menekan risiko prediabetes dan dislipidemia. Latihan kekuatan dan latihan beban tulang, bila dilakukan konsisten dan aman, berkontribusi pada pencegahan penurunan massa tulang. Latihan dasar panggul dan kebiasaan berkemih sehat memperbaiki keluhan kebocoran urin yang sering membuat perempuan ragu beraktivitas di luar rumah. Higiene tidur dan manajemen stres yang sederhana namun konsisten memperbaiki kualitas istirahat malam, sehingga toleransi terhadap gejala harian meningkat. Bila strategi gaya hidup ini dijalankan dengan pendampingan dan penyesuaian bertahap, kebanyakan perempuan merasakan

gejala yang lebih terkendali, fungsi yang tetap terjaga, dan kualitas hidup yang meningkat.

Semua rekomendasi akan dibingkai dalam konteks Indonesia. Artinya, menu contoh menggunakan bahan pangan lokal yang mudah didapat, seperti ikan laut dan air tawar, tempe dan tahu sebagai sumber isoflavon dan protein, sayur daun dan sayur buah yang akrab di pasar, serta karbohidrat dari nasi, ubi, jagung, atau singkong yang diolah dengan cara lebih sehat. Bumbu dan rempah khas Nusantara tetap dipertahankan sepanjang tidak berlebihan garam, gula, atau lemak jenuh. Untuk memastikan rencana terasa adil terhadap dompet dan waktu, bab ini menyertakan strategi belanja cerdas, persiapan masak mingguan, serta cara menyiasati jam kerja dan tanggung jawab rumah tangga.

Pada saat yang sama, bab ini menaruh perhatian pada kesetaraan akses dan keberterimaan budaya. Tidak semua orang nyaman dengan aplikasi gawai untuk mencatat makanan atau langkah harian. Karena itu, alternatif non digital seperti kartu harian sederhana tetap ditawarkan. Tidak semua lingkungan memiliki ruang terbuka yang ramah berjalan kaki, sehingga latihan rumah yang aman dan singkat diberikan sebagai pilihan. Nilai keluarga dan praktik tradisional yang memberi rasa tenang akan dirangkul selama aman dan tidak mengganggu terapi utama. Rujukan ke tenaga kesehatan lain disarankan bila muncul tanda yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya perdarahan abnormal, nyeri dada, pusing berat, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.

Pendeknya, pendahuluan ini mengajak pembaca memasuki bab dengan cara pandang yang menyeimbangkan ilmu dan realitas hidup. Menopause adalah fase yang dapat dilalui dengan baik ketika strategi gizi dan gaya hidup dipilih secara cerdas, diterapkan secara bertahap, dan dievaluasi secara jujur. Dengan kompas tujuan yang jelas, bahasa yang membumi, serta alat bantu yang sederhana, perempuan perimenopause sampai pascamenopause memiliki kesempatan yang sangat nyata untuk menurunkan gejala, menjaga fungsi, dan merasakan kualitas hidup yang meningkat dari hari ke hari.

B. Fisiologi Menopause dan Implikasi Gizi

Menopause adalah peristiwa biologis ketika fungsi ovarium meredup dan produksi estrogen serta progesteron menurun menetap. Pergeseran hormon ini berdampak luas: cara tubuh menyimpan dan membakar energi berubah, tulang kehilangan massa lebih cepat, jaringan urogenital menipis dan menjadi lebih sensitif, pola tidur mudah terganggu, dan profil risiko kardiometabolik meningkat. Karena itu, strategi gizi dan kebiasaan hidup perlu disesuaikan. Bukan sekadar “makan lebih

sedikit”, melainkan makan dengan komposisi, kualitas, dan waktu yang lebih cerdas, serta menggabungkannya dengan gerak badan yang terukur.

1. Perubahan hormon, metabolisme, dan sensitivitas insulin.

Turunnya estrogen memengaruhi dua hal penting: distribusi lemak dan cara tubuh mengelola glukosa. Banyak perempuan mendapati lemak lebih mudah terkumpul di area perut sehingga lemak visceral meningkat. Lemak visceral aktif secara metabolik dan berasosiasi dengan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel kurang responsif terhadap insulin sehingga gula darah cenderung naik. Pada saat yang sama, massa otot perlahan berkurang seiring usia. Otot adalah “gudang” glukosa terbesar, sehingga bila otot menyusut, pengendalian gula darah kian menantang. Penurunan estrogen juga dapat mengubah sinyal lapar–kenyang, membuat sebagian orang lebih mudah menginginkan makanan tinggi gula atau lemak ketika lelah atau kurang tidur.

Implikasi gizinya jelas. Pertama, kualitas karbohidrat menjadi kunci. Pilih karbohidrat dari pangan utuh seperti nasi merah atau campuran nasi putih dan merah, jagung, ubi, singkong, oat, dan roti gandum, lalu padukan dengan protein serta lemak sehat pada tiap makan agar penyerapan glukosa lebih lambat dan rasa kenyang bertahan lebih lama. Kedua, protein harian perlu cukup dan merata sepanjang hari, bukan menumpuk di malam hari. Target praktis yang sering dipakai untuk usia paruh baya dan lanjut adalah sekitar 1,0 sampai 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari, dibagi rata ke dua sampai tiga waktu makan. Setiap porsi makan utama diusahakan mengandung sekitar 25 sampai 30 gram protein berkualitas dari lauk seperti tempe, tahu, telur, ikan, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, atau kombinasi kacang-kacangan dan sereal. Pola ini membantu menjaga massa dan kekuatan otot yang pada gilirannya memperbaiki kontrol glukosa. Ketiga, lemak sehat dari ikan, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati yang baik seperti minyak zaitun atau canola mendukung profil lipid yang lebih bersahabat, selama lemak jenuh dan lemak trans dibatasi.

2. Kepadatan mineral tulang, kalsium–vitamin D, dan latihan beban.

Estrogen berperan menahan laju perombakan tulang. Saat estrogennya menurun, laju kehilangan massa tulang meningkat, terutama pada awal pascamenopause. Tanpa pencegahan, risiko tulang rapuh dan patah di pergelangan tangan, panggul, dan tulang belakang bertambah. Tiga pilar menjaga tulang adalah gizi, vitamin D melalui sinar matahari atau pangan, dan rangsangan mekanik melalui latihan beban.

Dari sisi gizi, usahakan kecukupan kalsium harian dari kombinasi pangan dan, bila perlu, fortifikasi: susu atau yoghurt tinggi kalsium, ikan bertulang lunak seperti pindang atau sarden, tahu–tempe yang diolah dengan penggumpal

kalsium, serta sayuran hijau seperti daun kelor, bayam, dan kailan. Vitamin D membantu penyerapan kalsium. Sumbernya sinar matahari pagi, ikan berlemak seperti tongkol, kembung, atau salmon, telur, serta bahan pangan fortifikasi. Magnesium, protein yang cukup, dan vitamin K dari sayur daun serta kedelai fermentasi juga mendukung kualitas tulang. Perlu diingat, tulang tidak hanya membutuhkan mineral, tetapi juga rangsangan. Latihan menahan beban seperti berjalan cepat, naik tangga, senam dengan langkah meloncat ringan bagi yang aman, serta latihan kekuatan dua sampai tiga kali per minggu memberi sinyal pada tulang untuk tetap padat. Untuk yang memiliki nyeri sendi atau risiko jatuh, program disesuaikan. Fokus pada latihan kekuatan bertahap, keseimbangan, dan langkah kecil tetapi konsisten, dengan pengawasan tenaga kesehatan bila perlu.

3. Jaringan urogenital, hidrasi, serat, dan kebiasaan berkemih.

Penurunan estrogen menipiskan dan mengeringkan jaringan vagina dan uretra, mengubah pH dan flora mikroba, serta melemahkan penopang dasar panggul. Hasilnya bisa berupa rasa kering atau nyeri saat berhubungan, anyang-anyangan, sering kencing, urgensi, hingga kebocoran urin saat batuk atau tertawa. Di sisi lain, sebagian perempuan justru menahan minum karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya terjadi dehidrasi, sembelit, dan iritasi kandung kemih yang menciptakan lingkaran masalah.

Pendekatan gizinya menyeimbangkan hidrasi cerdas dan kesehatan pencernaan. Target harian cairan disesuaikan kondisi, cuaca, dan penyakit penyerta, namun sebagai patokan banyak perempuan nyaman di kisaran 1,6 sampai 2 liter per hari. Triknya adalah mendistribusikan minum sejak pagi hingga sore, mengurangi porsi besar menjelang malam untuk mengurangi terbangun, dan memilih minuman yang tidak mengiritasi kandung kemih pada sore atau malam hari dengan membatasi kopi, teh kental, minuman bersoda, atau minuman energi. Serat 25 sampai 30 gram per hari dari sayur, buah, kacang-kacangan, dan sereal utuh membantu mencegah sembelit. Ingat untuk menambah cairan seiring peningkatan serat agar tidak tersendat. Kebiasaan berkemih juga dibenahi: jangan menahan terlalu lama, lakukan latihan pengaturan kandung kemih dengan interval ke kamar kecil yang teratur di siang hari, dan latih otot dasar panggul secara rutin. Perubahan ini sering kali cukup untuk mengurangi urgensi, kebocoran, dan rasa tidak nyaman sehingga aktivitas harian kembali leluasa.

4. Gejala vasomotor, tidur, dan pengaturan makan serta minum.

Rasa panas mendadak dan keringat malam adalah gejala khas yang dapat mengganggu tidur. Kurang tidur pada gilirannya meningkatkan rasa lapar,

keinginan camilan manis, dan kelelahan pada siang hari. Siklus ini perlu diputus dengan dua poros: kebersihan tidur dan pengaturan makan serta minum.

Di sisi kebersihan tidur, jaga rutinitas jam tidur dan bangun yang konsisten, sejutkan kamar, pilih pakaian tidur yang menyerap keringat, dan batasi kafein setelah tengah hari. Makan malam sebaiknya tidak terlalu larut dan tidak terlalu besar karena pencernaan yang berat dapat memicu rasa panas dan memperburuk tidur. Banyak perempuan terbantu dengan porsi makan malam lebih kecil, kaya protein tanpa lemak dan sayur, serta karbohidrat secukupnya. Jika sering lapar sebelum tidur, camilan kecil kombinasi karbohidrat kompleks dan protein seperti sepotong roti gandum dengan selai kacang tipis atau yoghurt dengan potongan buah dapat membantu tanpa memicu lonjakan gula. Perhatikan pula pemicu vasomotor pribadi. Makanan sangat pedas, minuman panas, alkohol, dan ruang panas sering menjadi pencetus. Catatan harian sederhana untuk mengenali pemicu dan waktu munculnya gejala membantu menyesuaikan pola makan dan lingkungan tidur secara lebih akurat.

5. Risiko kardiometabolik dan pentingnya kualitas lemak, serat, serta pola makan menyeluruh.

Memasuki pascamenopause, profil lipid cenderung bergeser. Kolesterol LDL naik, HDL bisa turun atau stagnan, dan trigliserida mudah meningkat bila asupan gula sederhana tinggi. Bersamaan dengan naiknya lemak visceral dan kemungkinan menguatnya tekanan darah, risiko kardiometabolik meningkat. Pencegahannya tidak cukup dengan “diet rendah lemak”. Yang lebih penting adalah kualitas lemak dan keseluruhan pola makan.

Pola makan berbasis pangan utuh yang kaya sayur dan buah berwarna, sereal utuh, kacang-kacangan dan polong, ikan dua sampai tiga kali per minggu, serta minyak nabati yang baik mendukung perbaikan profil lipid dan tekanan darah. Lemak jenuh dari gorengan berulang, krim nabati padat lemak, daging berlemak, dan santan kental dikurangi. Sebagai gantinya, pilih cara masak berkuah bening, tumis cepat dengan sedikit minyak, kukus, atau panggang. Serat larut dari oat, kacang merah, buncis, alpukat, dan buah seperti apel atau jeruk membantu menurunkan LDL. Batasi gula tambahan dan minuman manis untuk mengendalikan trigliserida dan berat badan. Garam juga diperhatikan. Menahan natrium hingga setara sekitar 2.000 miligram per hari atau sekitar 5 gram garam dapur membantu tekanan darah, apalagi bila sensitif garam. Bagi yang menyukai kedelai, isoflavon dalam tempe, tahu, dan kedelai hitam dapat menjadi bagian pola makan. Pada sebagian perempuan, asupan kedelai yang teratur terasa membantu gejala vasomotor, meski responsnya bervariasi.

6. Nuansa praktis yang sering terlewat.

Kebutuhan zat besi biasanya menurun setelah haid berhenti, sehingga fokus gizi dapat bergeser ke protein, kalsium, vitamin D, serat, dan lemak sehat. Namun, bila ada kelelahan yang tidak wajar atau anemia, penyebab lain perlu dievaluasi tenaga kesehatan. Vitamin B12 patut diperhatikan pada usia lanjut karena penyerapan dapat menurun. Sumber yang baik antara lain telur, susu dan produk susu, ikan, daging, serta pangan fortifikasi. Iodium tetap penting untuk kesehatan tiroid. Garam beryodium dan ikan laut membantu, dengan tetap membatasi total garam. Bila berat badan ingin dikurangi, kurangi kalori secara moderat sambil mempertahankan protein dan melakukan latihan kekuatan. Pemangkasan kalori yang ekstrem akan menghilangkan massa otot dan berisiko mempercepat kehilangan tulang.

7. Menyatukan semuanya dalam rutinitas harian.

Bayangkan satu hari yang ramah menopause. Pagi dimulai dengan segelas air dan sarapan berprotein, misalnya telur dadar sayur dengan sepotong roti gandum, atau tempe tumis sayur dengan nasi merah porsi kecil. Minum air ditata merata sejak pagi hingga sore. Makan siang mengutamakan separuh piring berisi sayur berwarna, seperempat karbohidrat utuh, dan seperempat protein. Ikan atau tahu–tempe menjadi lauk utama. Sore hari diisi camilan buah atau yoghurt, bukan minuman manis. Kafein dihentikan setelah pukul tiga. Menjelang petang, lakukan latihan kekuatan singkat seperti duduk berdiri dari kursi, latihan karet resistensi, atau squat ringan, diikuti peregangan dan latihan dasar panggul. Makan malam tidak larut dan lebih ringan. Kamar tidur disiapkan sejuk. Bila sering berkeringat malam, gunakan lapisan pakaian tipis yang mudah diganti. Untuk yang mengalami kebocoran urin, jadwal minum disesuaikan agar porsi terbesar tidak berada malam hari, dan latihan dasar panggul dilanjutkan konsisten.

C. Prinsip Pola Makan Seimbang Selama Menopause

Prinsip pola makan seimbang pada masa menopause bertujuan mengimbangi perubahan fisiologis yang memengaruhi metabolisme, komposisi tubuh, tulang, dan suasana hati. Intinya bukan diet ketat, melainkan memilih makanan yang padat gizi, mengatur porsi dan waktu makan, serta memasak dengan cara yang menjaga kualitas bahan. Ketika diterapkan konsisten, pola ini membantu mengurangi gejala, menjaga kekuatan otot dan tulang, menstabilkan gula dan lemak darah, serta mempertahankan energi harian.

Bagian pertama adalah kepadatan gizi. Setiap piring diupayakan berisi setengah bagian sayur dan buah beragam warna, seperempat bagian sumber karbohidrat dari biji bijian utuh, dan seperempat bagian lauk berprotein berkualitas. Di rumah tangga Indonesia, sayur bening, tumis cepat, lalap dengan bumbu

sederhana, serta buah utuh sebagai pencuci mulut sangat memadai untuk memenuhi vitamin, mineral, dan antioksidan. Biji bijian utuh seperti nasi merah, campuran nasi putih dan merah, jagung, singkong kukus, ubi, atau roti gandum menyumbang serat dan vitamin B. Sumber protein berkualitas mencakup tempe, tahu, telur, ikan laut dan tawar, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, atau kombinasi kacang-kacangan dengan sereal. Prinsipnya sederhana: semakin banyak warna alami di piring dan semakin sedikit proses industri, semakin tinggi kepadatan gizinya.

Karbohidrat yang dipilih sebaiknya berkualitas dengan indeks glikemik lebih rendah, lalu dikendalikan porsi. Indeks glikemik menggambarkan seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Biji bijian utuh, umbi yang direbus atau dikukus, serta buah utuh menaikkan gula darah lebih lambat daripada tepung halus, kue, atau minuman manis. Porsi wajar untuk sumber pati pada makan utama kira-kira seperempat piring, lalu selalu dipasangkan dengan protein dan sayur agar penyerapan glukosa melambat. Teknik memasak ikut menentukan hasil. Rebus, kukus, panggang, atau tumis cepat lebih baik daripada menggoreng lama. Menyajikan nasi yang sudah didinginkan dan dipanaskan kembali dapat meningkatkan pati resisten yang membantu kesehatan usus, selama porsi tetap terkendali. Pilih buah utuh dan batasi jus, karena serat pada buah utuh membantu rasa kenyang dan stabilitas gula darah.

Lemak tetap dibutuhkan pada masa menopause, namun kualitasnya sangat menentukan. Lemak sehat dari ikan laut yang lebih berlemak seperti kembung, tongkol, sarden, atau salmon disarankan dua sampai tiga kali per pekan. Tambahkan kacang almond, mete, tanah, kenari, serta biji seperti chia, wijen, atau labu dalam takaran kecil sebagai taburan. Gunakan minyak nabati yang baik seperti zaitun, kanola, kacang tanah, atau minyak beras untuk menumis cepat. Hindari memanaskan minyak hingga berasap, jangan menggoreng berulang kali, dan batasi santan kental, krim padat lemak, serta daging berlemak. Untuk masakan bersantan, pilih santan encer, gunakan porsi kecil, atau kombinasikan dengan kuah bening sehingga cita rasa khas Nusantara tetap hadir tanpa beban lemak jenuh berlebihan.

Protein harian yang cukup dan tersebar setiap waktu makan penting untuk menghadapi penurunan massa otot seiring usia. Target praktis bagi banyak perempuan paruh baya sampai lanjut adalah sekitar satu sampai satu koma dua gram protein per kilogram berat badan per hari, dibagi rata ke dua atau tiga waktu makan utama. Setiap waktu makan diupayakan mengandung dua puluh lima sampai tiga puluh gram protein. Sebagai gambaran, paduan tahu tempe, telur, atau ikan ukuran sedang sudah mendekati target tersebut bila porsi cukup. Penyebaran

protein sepanjang hari membantu menstimulasi sintesis protein otot berulang kali, sehingga kekuatan fungsional lebih terjaga. Pada hari latihan kekuatan, makan yang mengandung protein dalam dua jam setelah latihan akan semakin mendukung pemulihan otot.

Serat dan cairan merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Serat dua puluh lima sampai tiga puluh gram per hari membantu pencernaan, menahan rasa kenyang lebih lama, menstabilkan gula darah, serta menurunkan kolesterol LDL. Sumber terbaik adalah sayur hijau dan berwarna, buah utuh, kacang-kacangan, serta sereal utuh. Tambahkan serat secara bertahap agar perut nyaman, dan tingkatkan minum air seiring kenaikan serat. Kebutuhan cairan harian umumnya berada di kisaran satu koma enam sampai dua liter, disesuaikan cuaca, aktivitas, dan kondisi medis. Distribusikan minum sejak pagi hingga sore. Bila ada keluhan berkemih malam, porsi minum terbesar dilakukan lebih awal dan kurangi minuman yang mengiritasi kandung kemih pada sore hingga malam seperti kopi kental, teh pekat, minuman bersoda, atau minuman energi.

Pembagian porsi yang realistis, makan mindful, dan ritme makan yang konsisten membantu pola makan terasa ringan untuk dijalankan. Prinsip piring adalah alat yang mudah diingat: setengah sayur dan buah, seperempat lauk berprotein, seperempat karbohidrat utuh. Makan mindful berarti duduk tenang, mengunyah perlahan, menilai rasa lapar dan kenyang di awal dan pertengahan makan, serta mematikan distraksi seperti gawai. Ritme makan yang teratur menjaga energi dan mencegah lapar berlebihan menjelang malam. Banyak perempuan nyaman dengan tiga kali makan utama dan satu camilan kecil yang terencana. Makan malam sebaiknya tidak terlalu larut dan tidak terlalu besar. Jika perlu camilan menjelang tidur, pilih porsi kecil yang mengandung protein dan karbohidrat kompleks, misalnya yoghurt tanpa gula dengan potongan buah atau roti gandum tipis dengan selai kacang tipis.

Agar prinsip ini mudah hidup di dapur, siapkan beberapa kebiasaan praktis. Rencanakan menu mingguan yang berulang seperlunya agar belanja lebih mudah. Cuci dan siangi sayur untuk dua sampai tiga hari sekaligus, masak sumber protein dalam jumlah lebih, lalu simpan dalam porsi kecil siap pakai. Simpan buah yang siap santap di tempat terlihat agar menjadi pilihan pertama saat lapar. Biasakan membaca label kemasan untuk mengenali gula tambahan, natrium, dan lemak jenuh. Untuk penyedap, gunakan bumbu aromatik seperti bawang, cabai, jahe, kunyit, serai, daun jeruk, dan perasan jeruk nipis sehingga kebutuhan garam berkurang. Di luar rumah, gunakan panduan piring: pesan porsi sayur yang cukup, pilih lauk panggang atau tumis cepat, dan minta nasi dalam porsi kecil.

Setiap orang memiliki titik awal yang berbeda. Ada yang perlu menurunkan lingkaran pinggang, ada yang lebih fokus pada tulang, ada yang ingin tidur lebih nyenyak. Tetapkan satu dua perubahan yang paling realistis untuk dua pekan pertama, catat respons tubuh, lalu tambah langkah kecil berikutnya. Dengan pola makan yang padat gizi, karbohidrat berkualitas, lemak sehat, protein yang cukup dan merata, serat dan cairan yang memadai, serta porsi dan ritme yang tertata, masa menopause dapat dijalani dengan tubuh yang lebih bertenaga, pikiran yang lebih jernih, dan kualitas hidup yang lebih baik.

D. Mikronutrien Kunci: Kalsium, Vitamin D, B12, Folat, dan Antioksidan

Selama transisi hingga pascamenopause, tubuh bekerja lebih keras menjaga kestabilan tulang, otot, darah, saraf, dan sistem kekebalan. Penurunan hormon ovarium mengubah cara kita menyimpan mineral, memetabolisme energi, serta merespons stres oksidatif. Pola makan yang padat mikronutrien menjadi penopang utama agar fungsi harian tetap prima. Yang dibutuhkan bukan suplemen berderet, melainkan strategi cerdas memilih pangan, mengatur porsi, waktu konsumsi, serta memahami interaksi antargizi.

1. Kalsium dan vitamin D untuk tulang yang kuat.

Setelah menopause, laju pembongkaran tulang meningkat sehingga tulang lebih cepat kehilangan kepadatan. Kalsium adalah bahan baku struktur, sedangkan vitamin D bertugas membantu penyerapan kalsium di usus sekaligus mendukung fungsi otot. Sumber kalsium yang ramah dapur Indonesia meliputi susu dan yoghurt tinggi kalsium, ikan bertulang lunak seperti pindang atau sarden, tahu dan tempe yang dibuat dengan penggumpal kalsium, serta sayuran hijau seperti daun kelor, bayam, dan kailan. Banyak orang mengira semua kalsium datang dari susu, padahal kombinasi ikan bertulang lunak dan kedelai olahan dapat menyumbang porsi besar kebutuhan harian. Penyerapan kalsium lebih optimal bila asupannya dibagi dua sampai tiga kali dalam porsi kecil, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Perhatikan pula penghambat penyerapan, seperti konsumsi teh sangat pekat tepat bersamaan dengan sumber kalsium. Vitamin D dapat diperoleh dari ikan berlemak seperti kembung, tongkol, salmon, dari telur, serta dari pangan yang diperkaya. Paparan sinar matahari pagi yang singkat dan aman membantu pembentukan vitamin D. Kulit yang lebih gelap memerlukan waktu paparan sedikit lebih lama dibanding kulit cerah, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu paparan singkat yang rutin, menghindari jam terik, dan tetap memperhatikan perlindungan kulit. Bagi yang jarang keluar rumah, menutup sebagian besar kulit karena alasan keyakinan atau pekerjaan, atau memiliki

penyakit tertentu, evaluasi kadar vitamin D bisa dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan.

2. Magnesium untuk otot yang rileks, tidur yang lebih mantap, dan metabolisme energi.

Magnesium ikut bekerja dalam ratusan reaksi enzim, termasuk pembentukan energi di dalam sel, kontraksi dan relaksasi otot, serta regulasi sistem saraf. Sumbernya ada di makanan sehari-hari yang sering luput diperhatikan, seperti kacang almond, mete, dan tanah, biji labu, wijen, dan chia, sereal utuh, sayuran hijau gelap, serta cokelat hitam dengan kadar kakao tinggi. Asupan yang cukup membantu mengurangi kram otot malam hari, mendukung kualitas tidur, dan menyeimbangkan suasana hati. Jika memilih suplemen, bentuk yang ramah pencernaan seperti magnesium sitrat atau glisinat umumnya lebih nyaman, tetapi tetap utamakan sumber pangan dahulu. Ingat bahwa magnesium, kalsium, zat besi, dan zink saling berebut jalur penyerapan di usus. Jeda waktu konsumsi membantu masing-masing diserap lebih baik.

3. Vitamin B12 dan folat untuk darah dan saraf.

Keduanya bekerja sebagai pasangan yang mendukung pembentukan sel darah merah dan menjaga selubung saraf. Vitamin B12 terutama terdapat pada pangan hewani seperti ikan, daging, telur, dan susu. Folat berlimpah pada sayuran hijau, kacang kering, polong, serta buah sitrus. Pada pola makan yang rendah bahan hewani atau pada kondisi penyerapan yang kurang baik, misalnya penggunaan obat tertentu atau gangguan lambung, risiko kekurangan B12 meningkat. Kekurangan B12 dapat menimbulkan kesemutan, mudah lelah, dan gangguan konsentrasi. Di sisi lain, folat yang cukup menurunkan homosistein yang berhubungan dengan risiko kardiovaskular. Perlu kehati-hatian bila mengonsumsi folat dosis tinggi dalam bentuk suplemen, karena dapat menyamarkan gejala kekurangan B12. Pendekatan yang aman adalah mengupayakan sumber pangan beragam, mempertahankan porsi protein hewani atau pangan yang diperkaya B12 bila diperlukan, dan melakukan evaluasi klinis bila muncul keluhan neurologis.

4. Zat besi mengikuti fase kehidupan.

Kebutuhan zat besi menurun setelah menstruasi berhenti. Walau begitu, kekurangan besi masih mungkin terjadi pada pola makan dengan asupan hewani yang rendah, pendarahan abnormal yang belum terdiagnosis, atau kondisi penyerapan yang terganggu. Sumber besi heme dari daging dan ikan lebih mudah diserap tubuh. Sumber non heme dari kacang kering, polong, sayuran hijau, dan sereal utuh tetap penting, tetapi penyerapannya bergantung pada pendamping. Vitamin C dari jeruk, jambu, pepaya, atau cabai membantu

meningkatkan penyerapan besi non heme. Teh dan kopi dapat menghambat penyerapan bila diminum berdekatan dengan sumber besi. Jika mengonsumsi suplemen besi, jangan satukan dengan kalsium dalam waktu yang sama. Bila terjadi perdarahan setelah menopause, sesingkat apa pun, hal itu perlu dievaluasi tenaga kesehatan karena bukan kondisi yang wajar.

5. Antioksidan dan polifenol dari warna warni tanaman.

Perubahan hormonal dan penuaan meningkatkan kebutuhan tubuh akan pertahanan terhadap stres oksidatif. Antioksidan vitamin C, vitamin E, karotenoid, serta polifenol membantu menetralkan radikal bebas, mendukung kesehatan pembuluh darah, dan berpotensi meringankan gejala vasomotor pada sebagian perempuan. Pilih sayuran dan buah yang beragam warna setiap hari. Warna oranye dan merah memberi karotenoid seperti beta karoten dan likopen. Warna hijau gelap kaya folat dan vitamin K. Warna ungu dan biru membawa antosianin. Teh seduh, kopi berkualitas, kakao pahit, serta rempah seperti kunyit, jahe, dan kayu manis menyumbang polifenol. Teknik memasak memengaruhi ketersediaan gizi. Kukus atau tumis cepat lebih baik untuk menjaga vitamin larut air, sedangkan menambahkan sedikit lemak sehat saat mengolah sayuran kaya karotenoid membantu penyerapan vitamin larut lemak. Variasi adalah kunci. Tidak ada satu superfood yang menebus pola makan yang miskin ragam.

6. Seng, selenium, dan yodium untuk imunitas dan tiroid.

Seng berperan dalam penyembuhan luka, regulasi kekebalan, dan rasa pengecap. Sumbernya meliputi daging, ikan, kerang, telur, susu, serta kacang dan biji. Kekurangan seng dapat menurunkan nafsu makan dan menghambat pemulihan. Selenium bekerja sebagai bagian dari enzim antioksidan yang melindungi sel. Ikan, telur, dan sebagian kacang biji adalah sumber yang baik. Kacang Brazil sangat tinggi selenium sehingga cukup satu sampai dua butir kecil saja agar tidak berlebihan. Yodium adalah mineral penting untuk produksi hormon tiroid yang memengaruhi metabolisme. Garam beryodium adalah cara praktis memenuhi kebutuhan, tetapi total garam tetap dibatasi agar tekanan darah terjaga. Pada mereka yang harus sangat membatasi garam, sumber lain seperti ikan laut dan produk yang diperkaya yodium dapat dipertimbangkan. Bagi yang memiliki gangguan tiroid, pemilihan suplemen sebaiknya mengikuti saran klinis agar tidak mengganggu terapi.

7. Menyatukan mikronutrien dalam rutinitas harian.

Cara termudah memastikan kecukupan adalah menjadikan piring makan sebagai alat kendali. Isi setengah piring dengan sayur dan buah berwarna, lalu tambahkan lauk berprotein dan sumber karbohidrat utuh. Kombinasi ini secara alami membawa masuk kalsium, magnesium, folat, vitamin C, karotenoid,

polifenol, serta serat yang memperlambat penyerapan glukosa dan memberi rasa kenyang lebih lama. Untuk tulang, pastikan ada pangan kaya kalsium setiap hari dan atur paparan sinar matahari pagi yang aman untuk mendukung vitamin D. Untuk darah dan saraf, sisipkan lauk hewani atau pangan yang diperkaya B12, dibarengi sayuran hijau dan polong yang kaya folat. Untuk kekebalan dan tiroid, jaga variasi lauk ikan, telur, kacang serta gunakan garam beryodium secukupnya. Perhatikan interaksi praktis. Jangan meminum suplemen kalsium bersamaan dengan suplemen besi. Jangan menenggak teh sangat pekat tepat bersamaan dengan lauk kaya besi. Jika minum obat tiroid, patuhi jeda waktu dengan suplemen mineral agar penyerapan obat tidak terganggu.

8. Kapan suplemen diperlukan.

Pangan seharusnya menjadi sumber utama mikronutrien. Suplemen bermanfaat pada kondisi tertentu, misalnya vitamin D pada mereka yang jarang mendapat matahari, kalsium bila asupan pangan tidak mencukupi, B12 pada pola makan tanpa hewani, atau zat besi pada defisiensi yang terbukti. Dosis yang terlalu tinggi tidak membuat lebih sehat dan dapat berisiko. Diskusikan dengan tenaga kesehatan, terutama bila Anda menggunakan obat rutin atau memiliki penyakit ginjal, hati, atau tiroid.

E. Pola Makan Berbasis Bukti dan Adaptasi Nusantara

Pola makan yang paling konsisten mendukung kesehatan perempuan selama perimenopause hingga pascamenopause adalah pola yang kaya bahan pangan utuh, tinggi sayur dan buah, cukup protein berkualitas, serta lemak sehat dengan garam dan gula yang terkendali. Prinsip itu sejalan dengan tiga pola yang banyak diteliti: Mediterania, DASH, dan pola rendah indeks glikemik. Kabar baiknya, seluruhnya dapat diterjemahkan ke dapur Nusantara tanpa kehilangan cita rasa. Kuncinya ada pada pilihan bahan, cara masak, porsi, dan bumbu.

1. Pola Mediterania dan terjemahannya di Indonesia

Inti pola Mediterania adalah sayur dan buah beraneka warna setiap hari, biji-bijian utuh sebagai sumber karbohidrat, lauk ikan dan polong-polongan yang rutin, kacang dan biji sebagai taburan, serta minyak nabati yang baik untuk menumis cepat. Terjemahan praktisnya: jadikan lalap, urap, sayur bening, tumis cepat, atau salad sederhana sebagai setengah isi piring pada makan utama. Untuk karbohidrat, pilih nasi merah, campuran nasi putih dan merah, jagung, ubi kukus, singkong rebus, atau roti gandum. Sediakan lauk utama dari ikan lokal seperti kembung, tongkol, sarden, bandeng, atau patin minimal dua kali seminggu. Lengkapi hari-hari lain dengan tempe dan tahu sebagai sumber protein nabati sekaligus pembawa isoflavon yang pada sebagian perempuan terasa membantu

gejala vasomotor. Gunakan minyak kanola, kacang tanah, minyak beras, atau zaitun untuk menumis singkat. Kurangi santan kental, gorengan berulang, dan daging berlemak. Untuk mempertahankan identitas rasa, manfaatkan rempah dan bumbu dasar yang melimpah: bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, ketumbar, kunyit, jahe, serai, daun jeruk, daun salam, serta perasan jeruk nipis. Bumbu aromatik ini memungkinkan pengurangan garam tanpa membuat masakan terasa hambar.

2. Pola DASH untuk tekanan darah yang lebih stabil

Pola DASH menekankan sayur, buah, sumber protein rendah lemak, olahan susu rendah lemak bagi yang cocok, serta pembatasan natrium. Cara menerapkannya di rumah: pilih kaldu bening daripada kaldu instan asin, batasi kecap dan saus tinggi natrium, dan biasakan mencicipi sebelum menambahkan garam. Jika menggunakan santan, pilih santan encer atau sebagian diganti emulsifikasi tahu halus agar kuah tetap lembut tanpa terlalu tinggi lemak jenuh. Untuk lauk, utamakan ikan, ayam tanpa kulit, telur rebus, tempe dan tahu. Bila menyantap daging merah, atur porsi kecil dan frekuensi jarang. Produk susu rendah lemak dapat hadir sebagai yoghurt polos atau susu tinggi kalsium untuk melengkapi kalsium dan vitamin D. Jika tidak cocok susu, ikan bertulang lunak dan tahu yang diproses dengan penggumpal kalsium adalah alternatif yang baik.

3. Pola rendah indeks glikemik agar gula darah lebih stabil

Indeks glikemik rendah membantu menjaga lonjakan gula darah. Terapkan dengan memilih biji-bijian utuh, umbi yang direbus atau dikukus, dan buah utuh. Pasangkan selalu karbohidrat dengan protein dan lemak sehat serta sayur berserat agar penyerapan glukosa lebih lambat. Contoh sederhana: nasi merah porsi seperempat piring dipadu tumis buncis dan tempe serta ikan bakar. Ubi kukus dapat menjadi pengganti camilan manis. Buah dikonsumsi utuh, bukan dalam bentuk jus, agar serat utuh tetap hadir. Teknik masak memengaruhi hasil: rebus, kukus, panggang, atau tumis cepat lebih bersahabat dibanding menggoreng lama. Menyajikan nasi yang sempat didinginkan lalu dipanaskan kembali akan menambah pati resisten sehingga respons glikemik lebih terkendali, asalkan porsinya tetap wajar.

4. Contoh alur menu harian yang realistis

Mulailah hari dengan sarapan tinggi protein agar kenyang lebih lama dan menjaga massa otot. Misalnya telur dadar sayur dan sepotong roti gandum, atau tumis tempe bayam dengan sepiring kecil nasi merah. Tambahkan potongan buah sebagai penutup. Makan siang mengikuti panduan piring: setengah sayur beragam warna, seperempat karbohidrat utuh, dan seperempat protein. Contoh: pepes ikan, sayur asem, lalap timun dan tomat, serta nasi merah porsi kecil. Sore

hari, pilih camilan yang terencana seperti yoghurt polos dengan buah, kacang panggang tanpa garam segenggam kecil, atau ubi kukus. Makan malam dibuat ringan dan tidak terlalu larut. Misalnya sup bening ayam tanpa kulit dengan banyak sayur dan tahu, plus satu potong kecil buah. Jika masih lapar sebelum tidur, camilan kecil kombinasi karbohidrat kompleks dan protein seperti biskuit gandum tipis dengan olesan selai kacang tipis sudah cukup. Pola ini menjaga energi harian, membantu kualitas tidur, serta menghindarkan lapar berlebihan di malam hari.

5. Belanja cerdas dan persiapan masak mingguan

Strategi yang baik dimulai di pasar. Buat daftar belanja yang mengikuti menu satu minggu agar hemat waktu dan biaya. Pilih ikan lokal yang segar dan akrab di kantong seperti kembung, tongkol, lele, patin, atau bandeng. Beli sayur yang tahan beberapa hari, lalu cuci, siangi, dan simpan dalam wadah kedap agar mudah diambil. Masak sumber protein dalam jumlah lebih untuk dua atau tiga kali makan, lalu bagi ke porsi kecil dan bekukan. Siapkan bumbu dasar tumis dan bumbu kuning dalam jumlah banyak di akhir pekan sehingga memasak harian menjadi singkat. Simpan buah yang siap santap di meja agar menjadi pilihan pertama saat lapar. Untuk bahan kemasan, biasakan membaca label. Pilih natrium per saji yang lebih rendah, gula tambahan yang minimal, dan lemak jenuh yang kecil. Produk dengan daftar bahan yang pendek dan mudah dikenali umumnya lebih bersahabat.

6. Menjaga rasa lokal sambil setia pada tujuan gizi

Cita rasa Nusantara tetap dapat hadir tanpa mengorbankan sasaran gizi. Santan dapat dikurangi kekentalannya atau sebagian diganti dengan tahu halus agar kuah tetap gurih. Sambal tetap boleh ada dalam porsi kecil, dibuat dengan sedikit garam, dan ditambah perasan jeruk nipis untuk menonjolkan rasa. Kuah bening dengan bumbu lengkap adalah sahabat terbaik untuk menekan lemak jenuh. Untuk lauk berbalut tepung, panggang atau gunakan alat pemanggang udara sebagai pengganti goreng dalam minyak banyak. Jika terbiasa makan di luar, gunakan panduan piring: pesan porsi sayur yang cukup, pilih lauk panggang atau pepes, minta kuah bening, dan mintalah nasi porsi kecil. Bagi penyuka kudapan tradisional, pilih yang dikukus, tidak terlalu manis, dan jadwalkan sebagai bagian dari total asupan, bukan tambahan tanpa hitung.

7. Mengapa pola ini relevan bagi menopause

Ketiga pola tersebut bertemu pada titik yang sama, yaitu kualitas bahan dan keteraturan. Kualitas karbohidrat yang tinggi dan serat yang cukup membantu menstabilkan gula darah serta rasa kenyang. Lemak sehat dari ikan, kacang, dan biji mendukung profil lipid yang lebih baik. Protein yang tersebar sepanjang hari

menjaga massa otot, yang penting bagi kekuatan, metabolisme, dan pencegahan jatuh. Kekayaan sayur dan buah memberi vitamin, mineral, dan polifenol yang mendukung pembuluh darah, suasana hati, dan kualitas tidur. Bila dilakukan konsisten, kombinasi ini membantu mengendalikan lingkaran pinggang, menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil lemak, serta membuat gejala harian terasa lebih bersahabat.

8. Langkah kecil yang mudah dimulai hari ini

Tetapkan satu perubahan yang paling mungkin dijalankan selama dua minggu. Misalnya, separuh piring selalu berisi sayur pada makan siang dan malam. Setelah nyaman, tambah satu sesi memasak menu ikan per minggu menggantikan satu kali daging merah. Minggu berikutnya, pindahkan setengah porsi gorengan menjadi tumis cepat atau panggang. Buat pengingat sederhana untuk minum air sejak pagi agar tidak menumpuk malam hari. Lakukan evaluasi kecil setiap akhir pekan: energi harian, kualitas tidur, rasa lapar di malam hari, dan kelonggaran pakaian kerja. Perubahan kecil yang diulang dengan sabar inilah yang membangun pola makan berbasis bukti yang benar-benar hidup di dapur dan di meja makan keluarga.

F. Hidrasi Cerdas serta Kesehatan Urogenital

Hidrasi yang tepat selama perimenopause sampai pascamenopause bukan sekadar soal “delapan gelas per hari”. Tubuh pada fase ini mengalami perubahan hormonal yang memengaruhi rasa haus, cara ginjal mempertahankan cairan, serta sensitivitas kandung kemih. Karena itu, target cairan perlu disesuaikan dengan cuaca, tingkat aktivitas, dan kondisi medis yang menyertai. Pada banyak perempuan, asupan minuman harian yang nyaman berada pada kisaran satu koma enam sampai dua liter, dibagi rata sejak pagi hingga sore. Angka ini adalah titik berangkat yang kemudian disesuaikan. Jika berolahraga, tinggal di daerah panas, atau bekerja di luar ruangan, kebutuhan cenderung meningkat. Jika memiliki penyakit ginjal atau gagal jantung, pembatasan cairan justru mungkin diperlukan sehingga rencana harus mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Cara paling sederhana memantau kecukupan adalah melihat warna urin. Warna kuning muda seperti jerami biasanya menandakan hidrasi yang baik, sedangkan urin yang sangat pekat, bau menyengat, atau jumlahnya sangat sedikit menandakan perlunya menambah minum.

Kenyamanan malam hari sangat dipengaruhi cara menyusun jadwal minum. Banyak perempuan mengeluhkan sering terbangun untuk berkemih pada malam hari. Masalah ini sering membaik ketika porsi minum terbesar dipindahkan ke paruh pertama hari. Air putih diminum lebih sering dari pagi hingga sore, lalu porsi dikurangi mulai menjelang petang. Minuman yang mengiritasi kandung kemih

dihindari pada sore dan malam, misalnya kopi pekat, teh kental, minuman bersoda, minuman berenergi, serta alkohol. Kuah sup yang sangat asin pada makan malam juga dapat memperberat berkemih malam. Sebagian orang mendapatkan manfaat dari kebiasaan mengistirahatkan kaki di sore hari selama sekitar tiga puluh menit. Cara ini membantu mengembalikan cairan yang tertahan di tungkai ke sirkulasi sehingga dikeluarkan lebih awal, bukan saat tidur. Bagi yang memiliki varises atau bengkak tungkai, anjuran khusus seperti penggunaan stoking kompresi dapat dipertimbangkan bersama tenaga kesehatan.

Kesehatan urogenital memerlukan kebersihan yang lembut dan kebiasaan berkemih yang sehat. Jaringan vagina dan uretra menjadi lebih kering dan sensitif setelah menopause. Pilihan pembersih yang lembut dan tidak berpewangi membantu mencegah iritasi. Pembersihan bagian dalam vagina tidak dianjurkan karena dapat mengganggu keseimbangan flora alami. Saat membersihkan setelah buang air, usap dari depan ke belakang agar bakteri dari anus tidak berpindah ke saluran kemih. Pakaian dalam dari bahan yang menyerap keringat seperti katun dan tidak terlalu ketat membantu kulit bernapas dan mengurangi kelembapan berlebih. Bila sering berkeringat, ganti pakaian dalam secara teratur dan segera berganti setelah berenang. Pada hubungan intim yang terasa tidak nyaman karena kering, pelembap vagina yang digunakan rutin dan pelumas berbasis air saat berhubungan dapat membantu. Jika terdapat perdarahan setelah menopause, nyeri panggul yang menetap, atau rasa perih berkemih disertai demam, segera lakukan evaluasi klinis.

Cara berkemih juga memengaruhi kenyamanan kandung kemih. Kebiasaan menahan terlalu lama dapat mengiritasi kandung kemih, sedangkan terlalu sering berkemih "jaga jaga" membuat kandung kemih menjadi terbiasa menampung volume yang sangat kecil. Pendekatan yang seimbang berupa jadwal ke kamar kecil yang teratur pada siang hari, misalnya setiap dua sampai tiga jam, kemudian dievaluasi menurut kenyamanan pribadi. Mengosongkan kandung kemih dengan tuntas memerlukan waktu. Duduk dengan tenang, condongkan tubuh sedikit ke depan, dan beri jeda beberapa detik sebelum berdiri. Pada gejala urgensi yang tiba-tiba, teknik menenangkan napas dan kontraksi cepat otot dasar panggul sering membantu menahan sensasi mendesak sampai mencapai toilet. Latihan otot dasar panggul yang teratur, dikombinasikan dengan pola minum yang tertata, biasanya menurunkan kejadian kebocoran saat batuk, tertawa, atau berolahraga.

Kesehatan dasar panggul sangat dipengaruhi kondisi pencernaan. Konstipasi memaksa perempuan mengejan kuat berulang kali sehingga menambah tekanan pada dasar panggul. Serat dan cairan bekerja sebagai pasangan. Serat yang cukup, sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh gram per hari, membantu melunakkan tinja dan memperlancar gerak usus. Sumber terbaik terdapat pada sayuran hijau dan

berwarna, buah utuh, kacang kering, polong, serta sereal utuh. Tambahkan serat secara bertahap agar perut nyaman, dan tingkatkan minum air seiring kenaikan serat. Buah tinggi sorbitol seperti plum, pir, dan pepaya sering membantu melancarkan. Minyak masak tidak perlu berlebihan karena tidak menggantikan peran serat dan cairan. Bagi yang sudah menjalani intervensi untuk wasir atau prolaps, jadwal buang air yang teratur di pagi hari dan posisi yang mendukung (lutut sedikit lebih tinggi dari pinggul menggunakan bangku kecil) dapat mengurangi mengejan.

Cuaca panas dan aktivitas fisik menuntut strategi hidrasi yang lebih cermat. Saat suhu udara tinggi, keringat menguap lebih cepat sehingga rasa haus sering tidak terasa seketika, padahal cairan tubuh sudah banyak hilang. Mulailah hari dengan segelas air, lalu minum sedikit sedikit tetapi sering. Sebelum beraktivitas di luar ruangan, pastikan sudah minum dengan cukup, bawa botol air, dan pilih pakaian yang menyerap keringat. Pada aktivitas fisik ringan hingga sedang dengan durasi kurang dari satu jam, air putih biasanya cukup. Bila berkeringat deras dalam waktu lebih lama, terutama di udara sangat panas, cairan yang mengandung elektrolit dapat membantu mengganti natrium yang hilang. Hindari minum air dalam jumlah sangat besar sekaligus karena berisiko mual atau bahkan mengencerkan natrium darah. Cara sederhana memantau adalah menimbang sebelum dan sesudah aktivitas. Penurunan berat badan lebih dari satu persen akibat keringat menandakan perlunya menambah asupan cairan dan elektrolit pada sesi berikutnya.

Rencana harian yang sederhana membuat kebiasaan hidrasi lebih mudah dijalankan. Bayangkan satu hari kerja biasa. Pagi dimulai dengan segelas air suhu ruang dan sarapan berprotein. Air putih diminum satu gelas kecil setiap beberapa jam, lalu segelas teh hangat yang tidak terlalu pekat jika diinginkan. Menjelang sore, pilih air putih atau infus air dengan irisan buah, bukan kopi pekat. Makan malam tidak terlalu larut dan tidak terlalu asin. Jika perlu minum obat malam, ambil teguk kecil yang cukup untuk menelan obat, bukan satu gelas penuh. Sebelum tidur, pastikan jalur ke kamar mandi aman dan terang. Bagi yang kerap terbangun, sediakan lampu malam dan alas anti selip di kamar mandi agar perjalanan singkat lebih aman.

Semua anjuran ini bertujuan membuat kandung kemih merasa dihormati, bukan dipaksa. Hidrasi cerdas berarti memberi cairan yang cukup pada waktu yang tepat, memilih jenis minuman yang tidak memicu iritasi, dan menata kebiasaan pencernaan agar dasar panggul tidak terbebani. Ketika strategi ini disatukan dengan latihan dasar panggul yang benar, pilihan pakaian yang nyaman, serta kebersihan area intim yang lembut, sebagian besar perempuan merasakan penurunan urgensi, berkurangnya kebocoran, tidur malam yang lebih utuh, dan keberanian untuk

kembali aktif di rumah maupun komunitas. Jika keluhan tidak membaik atau justru muncul tanda bahaya seperti darah pada urin, demam, nyeri pinggang, atau perih berkemih yang berat, segera lakukan pemeriksaan langsung agar rencana gaya hidup yang baik tetap berjalan berdampingan dengan penanganan medis yang tepat.

G. Aktivitas Fisik: Aerobik, Kekuatan, Keseimbangan, dan Latihan Dasar Panggul

Aktivitas fisik pada masa perimenopause sampai pascamenopause bekerja seperti resep multi-komponen. Aerobik menjaga jantung dan metabolisme, latihan kekuatan mempertahankan otot, rangsangan beban menjaga tulang, latihan keseimbangan mencegah jatuh, sementara latihan dasar panggul melindungi kenyamanan urogenital. Semua bagian saling menguatkan, dan keselamatan menjadi benang merah di setiap sesi.

Mulailah dari aerobik intensitas sedang dengan tujuan akumulasi 150 sampai 300 menit per minggu. Intensitas sedang berarti napas terbangun namun masih mampu bercakap kalimat pendek. Patokan sederhana lainnya adalah skala persepsi usaha 5 sampai 6 dari 10. Pilih yang paling mudah diakses: jalan cepat di lingkungan rumah, bersepeda santai, berenang, senam ritmik, atau menari ringan. Jika baru memulai atau lama tidak aktif, pecah target mingguan menjadi potongan 10 sampai 20 menit dan tambahkan 5 menit per sesi tiap satu sampai dua minggu sesuai kenyamanan sendi dan napas. Tubuh merespons ritme yang konsisten, jadi lebih baik sering dan singkat daripada jarang tetapi sangat berat. Bagi yang memiliki tekanan darah tidak stabil atau gula darah mudah turun, rencanakan waktu makan dan obat agar latihan aman, dan bawa air minum untuk menjaga hidrasi.

Latihan kekuatan adalah penyangga utama agar massa dan kekuatan otot tidak menyusut. Dua sampai tiga kali per minggu sudah memberi manfaat, dengan jeda setidaknya satu hari antar sesi untuk kelompok otot yang sama. Fokus pada gerak fungsional seluruh tubuh: duduk berdiri dari kursi untuk pola squat, menunduk dengan punggung netral untuk hip hinge, dorong dan tarik elastik atau beban tangan untuk pola dorong tarik, angkat barang dari lantai dengan teknik aman, serta latihan untuk bahu dan inti. Satu sesi dapat diisi dua set delapan sampai dua belas ulangan per gerakan. Pilih beban atau elastik yang membuat ulangan terakhir terasa menantang tetapi formasi tubuh tetap rapi dan napas tidak tertahan. Ketika dua belas ulangan terasa mudah, naikkan beban perlahan. Pada hari latihan, asupan protein berkualitas dalam dua jam setelah sesi membantu pemulihan otot. Jika ada nyeri sendi, kecilkan rentang gerak ke area nyaman, gunakan tempo lambat, dan pilih variasi yang tidak memicu nyeri tajam.

Tulang membutuhkan rangsangan mekanik agar tetap padat. Rangsangan itu hadir dari latihan menahan beban tubuh seperti jalan cepat, naik turun tangga, dan variasi lompatan kecil yang dipilih dengan cermat. Pada mereka yang sehat sendi dan tidak memiliki risiko jatuh tinggi, sisipkan meloncat ringan di tempat, langkah samping dinamis, atau naik turun bangku rendah selama beberapa menit di tengah sesi. Pada mereka dengan osteopenia atau osteoporosis, pilih rangsangan tanpa benturan keras: jalan cepat dengan ayunan lengan, naik tangga dengan pegangan, berdiri satu kaki, atau latihan kekuatan bertahap. Hindari membungkuk dalam dan memutar tulang punggung secara tiba-tiba dengan beban karena posisi itu menekan tulang belakang. Bila pernah mengalami patah tulang atau memiliki skoliosis, konsultasikan variasi gerak yang paling aman sebelum menaikkan intensitas.

Keseimbangan dan mobilitas adalah gardu terdepan pencegahan jatuh. Sisihkan lima sampai sepuluh menit setiap hari untuk tugas singkat: berdiri satu kaki sambil berpegangan ringan pada sandaran kursi, berjalan tumit ke ujung jari di koridor, duduk berdiri lima kali dengan kontrol, serta latihan mobilitas pergelangan kaki dan pinggul agar langkah lebih mantap. Latihan sederhana ini memperkuat otot kecil penstabil, menajamkan refleks, dan membuat transisi posisi dari duduk ke berdiri lebih aman. Bagi yang pernah hampir jatuh, tambahkan latihan pengalihan berat badan kanan kiri dan berputar perlahan sambil tetap menatap satu titik, selalu di lingkungan yang terang dan bebas halangan.

Kesehatan urogenital mendapatkan manfaat langsung dari latihan dasar panggul yang terstruktur. Otot dasar panggul bekerja seperti “ayunan” yang menopang kandung kemih, rahim, dan usus. Untuk menemukan ototnya, bayangkan menahan keluarnya gas dan menghentikan aliran urin, lalu lepaskan kembali. Kontraksi yang benar terasa seperti mengangkat ke arah dalam, bukan mendorong ke bawah, dan napas tetap mengalir. Mulailah dalam posisi berbaring atau setengah duduk agar gravitasi ringan, lalu maju ke duduk dan berdiri seiring kemajuan. Sesi harian ideal memadukan dua jenis kontraksi. Pertama, kontraksi lambat untuk daya tahan, tahan enam sampai delapan detik lalu lepas durasi yang sama, ulangi delapan sampai dua belas kali. Kedua, kontraksi cepat untuk refleks, kencangkan dan lepaskan secepat mungkin sepuluh kali berturut-turut, istirahat, lalu ulangi dua sampai tiga set. Lakukan dua sampai tiga kali sehari. Setelah teknik mapan, terapkan kebiasaan yang disebut “knack”, yaitu mengontraksikan dasar panggul sesaat sebelum batuk, tertawa, mengangkat, atau melompat. Banyak perempuan melaporkan kebocoran urin berkurang nyata setelah empat sampai delapan minggu konsisten.

Semua program di atas perlu dibungkus dengan prinsip keselamatan yang sederhana. Pemanasan lima sampai sepuluh menit menyiapkan persendian dan

sistem kardiovaskular. Jalan santai, putaran bahu, ayunan lengan, dan mobilisasi pergelangan kaki sudah cukup. Pendinginan menurunkan denyut jantung bertahap dan membantu relaksasi. Latihan peregangan lembut untuk betis, paha, panggul, punggung tengah, dan bahu terasa nyaman setelah sesi. Alas kaki yang menutup tumit, bertapak tidak licin, dan menyangga lengkung kaki membuat langkah lebih stabil. Ruang latihan perlu terang, lantai kering, karpet tidak menggelombang, serta jalur bebas kabel. Bawa air, terutama saat cuaca panas, dan atur minum sejak pagi agar tidak menumpuk malam hari. Dengarkan sinyal tubuh. Hentikan latihan dan evaluasi bila muncul nyeri dada, sesak tidak biasa, pusing berputar, pandangan kabur, lemas mendadak pada satu sisi tubuh, nyeri sendi tajam, atau nyeri otot yang menetap lebih dari dua hari. Pada kondisi seperti tekanan darah tidak terkendali, gula darah sangat fluktuatif, prolaps berat, perdarahan setelah menopause, atau riwayat patah tulang terbaru, jadwalkan penilaian klinis untuk menyesuaikan program.

Supaya mudah dijalankan, jadikan gerak sebagai bagian dari hari, bukan hanya sesi terpisah. Bayangkan satu minggu yang realistis. Tiga sore diisi jalan cepat 30 menit di lingkungan rumah atau treadmill sambil mendengarkan murottal atau musik yang disukai. Dua pagi lainnya menjadi hari latihan kekuatan singkat 25 menit di rumah: duduk berdiri dari kursi, dorong tarik elastik, hip hinge dengan botol air sebagai beban, plank lutut, dan latihan bahu ringan, diakhiri lima menit latihan dasar panggul. Setiap hari, selipkan latihan keseimbangan satu menit saat menunggu air mendidih atau iklan televisi. Saat ada tangga, pilih naik satu sampai dua lantai jika sendi nyaman. Bila harus banyak duduk, bangun tiap 45 sampai 60 menit untuk berjalan kecil dan melakukan tiga sampai lima kali duduk berdiri. Pola kecil yang diulang berkali-kali inilah yang menambah durasi aerobik mingguan, mempertahankan otot, memberi rangsangan tulang, dan menajamkan keseimbangan tanpa terasa membebani.

Perempuan sering menunda gerak karena khawatir dengan kebocoran urin, nyeri lutut, atau kelelahan. Justru di sinilah kekuatan program terintegrasi. Latihan dasar panggul yang rutin mengurangi kebocoran, latihan kekuatan yang bertahap mengurangi beban pada sendi lutut, aerobik ringan memperbaiki energi harian, dan latihan keseimbangan mengembalikan rasa percaya diri melangkah. Tidak ada sesi yang harus sempurna. Yang lebih penting adalah kesinambungan, penyesuaian bertahap, dan keberanian untuk melambat ketika tubuh meminta. Dengan cara ini, aktivitas fisik menjadi teman yang menyenangkan: jantung lebih kuat, otot lebih sigap, tulang lebih tangguh, kandung kemih lebih bersahabat, dan hari-hari terasa lebih ringan.

H. Higiene Tidur dan Manajemen Stres

Tidur yang dalam dan pulih adalah fondasi energi, keseimbangan emosi, dan pengendalian nafsu makan. Pada masa perimenopause hingga pascamenopause, penurunan hormon ovarium mengubah ritme suhu tubuh, mengganggu kestabilan suasana hati, dan menurunkan ambang terbangun pada malam hari. Akibatnya banyak perempuan mengalami rasa panas mendadak di malam hari, keringat berlebih, mudah terjaga, lalu kesulitan tidur kembali. Kabar baiknya, kualitas tidur dapat ditata kembali melalui kebiasaan harian yang konsisten, pengaturan lingkungan kamar, dan manajemen stres yang sederhana namun terarah.

Rutinitas tidur yang tetap membantu otak mengenali kapan saatnya memulai dan mengakhiri hari. Pilih jam tidur dan jam bangun yang sama setiap hari termasuk akhir pekan dengan toleransi sekitar tiga puluh menit. Satu jam sebelum tidur jadwalkan ritual yang tenang. Redupkan lampu, pelankan ritme, hentikan pekerjaan kognitif berat, dan sisipkan kegiatan yang mengirim sinyal relaksasi seperti membaca ringan, menulis tiga hal yang disyukuri, atau berdoa. Paparan cahaya pagi sangat menolong penataan ulang jam biologis. Begitu bangun, buka gorden atau berjalan singkat di luar selama sepuluh sampai lima belas menit. Cahaya pagi memberi sinyal kuat bagi ritme sirkadian sehingga rasa kantuk tiba di jam yang tepat pada malam hari.

Lingkungan kamar perlu sejuk, gelap, dan senyap agar otak lebih mudah bertahan dalam tidur dalam. Suhu nyaman biasanya berada di kisaran delapan belas sampai dua puluh dua derajat celcius. Gunakan tirai gelap atau penutup mata jika ada lampu jalan yang masuk ke kamar. Atur kebisingan dengan menutup jendela, menggunakan penenang suara yang halus atau penutup telinga bila diperlukan. Pilih sprei yang menyerap keringat dan bahan pakaian tidur yang tipis. Jauhkan jam digital yang terang dari pandangan. Melihat waktu ketika terbangun memicu kecemasan yang justru membuat sulit tidur kembali.

Asupan menjelang malam ikut menentukan kualitas tidur. Kafein sebaiknya dihentikan pada awal hingga pertengahan sore karena efeknya dapat bertahan lama. Teh kental, kopi, minuman energi, serta cokelat pekat termasuk sumber kafein yang patut dibatasi di jam jelang malam. Makanan tinggi gula dan karbohidrat halus mudah memicu naik turun gula darah yang berakhir pada terbangun dini. Alkohol tampak menidurkan di awal malam, tetapi cenderung memotong fase tidur dalam sehingga kualitas tidur buruk. Jarak makan malam dengan waktu tidur idealnya dua sampai tiga jam. Makan malam dibuat tidak terlalu besar, kaya sayur dan protein tanpa lemak, dengan karbohidrat secukupnya. Bila perlu camilan kecil sebelum tidur,

pilih kombinasi karbohidrat kompleks dan protein seperti yoghurt tanpa gula dengan potongan buah atau roti gandum tipis dengan olesan selai kacang tipis. Atur juga cairan. Penuhi kebutuhan minum sejak pagi hingga sore dan kecilkan porsi di malam hari agar tidak sering terbangun untuk berkemih.

Gejala vasomotor malam perlu ditangani secara spesifik. Gunakan sistem berlapis pada pakaian dan selimut agar mudah dibuka saat rasa panas datang. Sediakan kipas kecil di samping tempat tidur atau bantal yang menyerap panas. Simpan handuk kecil dan air minum hangat tanpa kafein di meja. Banyak perempuan merasa lebih nyaman dengan minuman hangat ringan seperti air jahe tipis atau teh herbal tanpa kafein. Catat pemicu pribadi. Makanan sangat pedas, minuman panas, dan ruangan pengap sering memperberat keringat malam. Catatan harian singkat membantu mengenali pola sehingga penyesuaian menjadi lebih tepat sasaran.

Teknik relaksasi sebelum tidur berfungsi mematikan mode waspada yang sering terlalu aktif saat stres. Latihan napas pelan dengan rasio hembus lebih panjang dari tarik napas efektif menurunkan ketegangan. Contoh yang mudah adalah menarik napas selama empat hitungan, menahan dua hitungan, lalu menghembus perlahan selama enam hitungan. Ulangi tiga sampai lima menit. Relaksasi otot progresif juga bermanfaat. Tegangkan kelompok otot selama lima detik lalu lepaskan selama sepuluh detik dan lanjut ke kelompok berikutnya mulai dari kaki hingga wajah. Meditasi singkat dengan perhatian pada sensasi napas, imajinasi tempat yang menenangkan, atau doa terstruktur mengantarkan pikiran ke keadaan yang lebih tenang. Pilih satu teknik yang paling cocok dan lakukan setiap malam pada jam yang sama agar tubuh membangun asosiasi kuat antara teknik tersebut dan rasa kantuk.

Stres siang hari sangat menentukan kualitas tidur malam. Tubuh yang menahan beban emosi dan beban kerja tanpa jeda akan membawa ketegangan itu ke tempat tidur. Sisipkan jeda mikro beberapa kali sehari. Tutup mata satu menit dan lakukan lima siklus napas panjang. Melangkah keluar sebentar mencari cahaya dan angin segar. Pilih satu kegiatan bermakna yang membuat Anda merasa terhubung. Berkebun singkat, membaca Alquran atau buku rohani, menjahit, atau mengajar cucu mengerjakan tugas sekolah. Interaksi hangat dengan keluarga atau kelompok sebaya menurunkan hormon stres dan menenangkan sistem saraf. Olahraga ringan di pagi atau siang hari seperti jalan cepat dan latihan kekuatan membantu tidur malam menjadi lebih dalam. Hindari latihan berat terlalu dekat dengan waktu tidur karena detak jantung dan suhu tubuh yang masih tinggi dapat menunda rasa kantuk.

Jika terbangun di malam hari, pendekatannya lembut. Jangan menatap jam. Nyalakan lampu redup saja agar mata tidak terpapar cahaya terang. Lakukan napas

pelan atau relaksasi otot progresif di tempat tidur. Bila setelah kira kira dua puluh menit kantuk tidak datang juga, pindah ke kursi nyaman dan lakukan kegiatan tenang yang membosankan seperti membaca buku ringan. Kembali ke tempat tidur saat terasa mengantuk. Strategi ini melatih otak agar tempat tidur diasosiasikan dengan tidur, bukan dengan kekhawatiran. Tidur siang boleh hadir sebagai penolong, tetapi cukup sepuluh sampai dua puluh menit dan tidak lewat dari sore awal agar tidak mengganggu tidur malam.

Sebagian keluhan perlu disaring lebih serius. Konsultasi dibutuhkan bila sulit tidur atau terbangun dini setidaknya tiga malam per minggu selama lebih dari tiga bulan atau bila kantuk siang hari mengganggu keselamatan berkendara dan kerja rumah tangga. Waspadaai dengkur keras disertai hentian napas yang disaksikan, terbangun dengan rasa tersedak, sakit kepala pagi, atau kantuk berat di siang hari. Tandatanda tersebut dapat mengarah pada gangguan napas saat tidur. Sensasi tidak nyaman di betis saat istirahat yang memaksa untuk menggerakkan kaki juga patut dievaluasi karena dapat mengganggu tidur tanpa disadari. Obat tertentu seperti dekongestan, kortikosteroid, atau suplemen kafein dapat memperburuk tidur. Depresi, kecemasan, gangguan tiroid, dan nyeri kronik juga sering berperan. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia adalah pendekatan non obat dengan bukti kuat bagi insomnia kronik. Penanganan gejala vasomotor yang berat juga sering memperbaiki tidur secara tidak langsung.

Sebuah contoh rutin malam yang realistis dapat membantu memulai. Selepas magrib pekerjaan berat diselesaikan dan gawai dipakai seperlunya saja. Makan malam pukul tujuh dengan porsi tidak besar, kaya sayur dan protein tanpa lemak. Setelah itu dilakukan jalan santai sepuluh menit di pekarangan. Pukul delapan ruang keluarga dibuat lebih redup. Pukul delapan tiga puluh sesi relaksasi napas selama lima menit dan doa penutup hari dilakukan. Pukul sembilan kamar sudah sejuk dan rapi, baju tidur yang menyerap keringat telah disiapkan, serta kipas kecil berada di sisi tempat tidur. Pukul sembilan lima belas ponsel disimpan di luar kamar, lalu membaca ringan lima belas menit sampai mata terasa berat. Pukul sembilan tiga puluh lampu dimatikan. Jika terbangun, strategi napas dan relaksasi diterapkan tanpa melihat jam.

Kualitas tidur adalah hasil dari serangkaian pilihan kecil yang diulang setiap hari. Ketika rutinitas tetap, paparan cahaya pagi terjaga, kamar sejuk dan redup, asupan malam hari ditata, relaksasi dilatih, dan stres siang dibagi bersama orang terdekat, kebanyakan perempuan merasakan tidur yang lebih utuh dan pikiran yang lebih jernih keesokan hari. Bila upaya ini sudah konsisten namun keluhan tetap berat, evaluasi klinis adalah langkah bijak agar rencana gaya hidup yang baik berjalan berdampingan dengan penanganan profesional yang tepat.

I. Suplemen dan Herbal: Bukti, Keamanan, serta Interaksi Obat

Pendekatan terbaik selama perimenopause hingga pascamenopause selalu dimulai dari pangan. Sayur dan buah beragam warna, protein berkualitas, biji-bijian utuh, lemak sehat, dan hidrasi yang tertata memberi fondasi gizi yang sulit digantikan kapsul apa pun. Suplemen dan herbal baru dipertimbangkan ketika asesmen menunjukkan ada kesenjangan asupan, kebutuhan klinis khusus, atau tujuan yang jelas, misalnya menutup defisit kalsium, menormalkan kadar vitamin D, menurunkan trigliserida, melancarkan pencernaan, atau mengelola gejala tertentu. Prinsip ini mencegah belanja impulsif mengikuti tren dan melindungi dari kombinasi produk yang saling bertabrakan.

1. Kalsium dan vitamin D.

Setelah menopause, kepadatan mineral tulang menurun lebih cepat. Kalsium menjadi bahan baku struktur, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium dan mendukung fungsi otot. Prioritaskan sumber pangan: susu atau yoghurt tinggi kalsium, ikan bertulang lunak seperti pindang dan sarden, tahu dan tempe yang dibuat dengan penggumpal kalsium, serta sayuran hijau seperti daun kelor, kailan, atau bayam. Bila asupan harian dari pangan masih kurang, barulah pertimbangkan suplemen dengan target total harian yang disesuaikan usia dan kondisi medis. Perhatikan bahwa tubuh umumnya menyerap maksimal sekitar 500 sampai 600 miligram kalsium per kali konsumsi, sehingga jika perlu suplemen, bagi menjadi dua waktu minum dan ambil bersama makan untuk meningkatkan absorpsi dan mengurangi keluhan perut. Vitamin D dapat dipenuhi dari paparan cahaya pagi yang aman dan pangan. Suplemen vitamin D dipertimbangkan bila jarang mendapat matahari, berkulit lebih gelap, atau terdapat kondisi medis khusus. Evaluasi berkala membantu menilai apakah dosis sudah tepat atau justru berlebih.

2. Omega-3 dari ikan.

Asam lemak omega-3 (EPA dan DHA) mendukung kesehatan jantung, trigliserida, dan pembuluh darah. Cara paling sederhana adalah makan ikan laut berminyak dua hingga tiga kali per pekan, misalnya kembung, tongkol, sarden, atau salmon. Bila pola makan rendah ikan atau kadar trigliserida meningkat, suplemen minyak ikan bisa dipertimbangkan. Bacalah label dengan teliti karena yang penting adalah jumlah EPA dan DHA per kapsul, bukan berat minyak ikan secara keseluruhan. Mulailah dengan dosis rendah sesuai rekomendasi produk yang tepercaya dan pantau respons selama 4 sampai 8 minggu.

3. Magnesium untuk otot, tidur, dan energi.

Magnesium terlibat dalam kontraksi otot, produksi energi sel, dan regulasi sistem saraf. Sumber pangan yang kaya magnesium ada pada kacang, biji, sereal utuh, sayuran hijau, dan cokelat hitam. Bila keluhan kram malam, kualitas tidur, atau asupan pangan kurang, suplemen magnesium mungkin membantu. Perhatikan bahwa angka pada label adalah jumlah magnesium elemental, bukan berat senyawanya. Bentuk sitrat, glisinat, atau laktat cenderung lebih ramah pencernaan. Mulailah dari dosis rendah pada malam hari, pantau kenyamanan perut, dan hindari penggunaan bersamaan dengan antibiotik tertentu karena dapat mengganggu penyerapan obat.

4. Probiotik.

Probiotik dapat mendukung kesehatan pencernaan dan, pada sebagian perempuan, kenyamanan urogenital. Manfaatnya bersifat strain-spesifik. Pilih produk yang mencantumkan strain, jumlah mikroba hidup sampai akhir masa simpan, serta cara penyimpanan. Untuk pencernaan, kombinasi *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* sering digunakan. Untuk area urogenital, beberapa strain *Lactobacillus* tertentu telah diteliti. Probiotik sebaiknya dinilai manfaatnya setelah 4 sampai 8 minggu. Jika tidak ada perubahan berarti, ganti pendekatan daripada menambah produk lain di atasnya.

5. Fitokimia, terutama isoflavon kedelai.

Isoflavon dalam kedelai (tempe, tahu, edamame, susu kedelai) memiliki efek mirip estrogen yang sangat lemah dan pada sebagian perempuan dapat membantu gejala vasomotor yang ringan. Pangan utuh berbasis kedelai umumnya aman dikonsumsi rutin sebagai bagian pola makan. Suplemen isoflavon kedelai dapat dipertimbangkan bila asupan pangan kurang, tetapi respons tiap orang bervariasi. Bagi penyintas kanker payudara atau mereka yang menjalani terapi yang memengaruhi hormon, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan suplemen apa pun yang bertema fitoestrogen. Pilih produk dengan standar mutu yang jelas dan evaluasi manfaat setelah beberapa minggu.

6. Memilih produk yang aman dan berkualitas.

Pasar suplemen dan herbal sangat beragam. Utamakan produk dari produsen yang kredibel, terdaftar resmi, dan bila memungkinkan memiliki sertifikasi pihak ketiga mengenai kemurnian serta kandungan zat aktif. Hindari klaim yang terlalu indah seperti “menyembuhkan semua gejala”, “bekerja dalam hitungan hari”, atau “tanpa efek samping”. Pilih formula sederhana dengan satu zat aktif pada satu waktu. Semakin banyak bahan dalam satu kapsul, semakin sulit menilai mana yang memberi manfaat dan mana yang memicu keluhan. Baca label dengan seksama: dosis per porsi, bentuk senyawa (misalnya magnesium sitrat vs

oksida), tanggal kedaluwarsa, anjuran penyimpanan, serta peringatan penggunaan.

7. Waspada interaksi obat.

Interaksi adalah alasan utama mengapa suplemen perlu dikelola seperti obat. Beberapa contoh yang sering terlewat: kalsium, zat besi, dan magnesium dapat menurunkan penyerapan antibiotik tertentu dan obat tiroid jika diminum bersamaan; suplemen kalsium sebaiknya diberi jeda beberapa jam dari obat tiroid. Minyak ikan dosis tinggi, ginkgo, bawang putih dosis besar, kunyit pekat, dan beberapa herbal lain dapat meningkatkan risiko perdarahan bila dikombinasikan dengan pengencer darah. St John's wort berinteraksi dengan banyak obat karena memengaruhi enzim hati, termasuk obat jantung, antidepresan, dan kontrasepsi. Ginseng dapat memengaruhi kadar gula darah dan berinteraksi dengan obat antidiabetes. Bahkan minuman atau ekstrak teh hijau pekat pernah dilaporkan mengganggu fungsi hati pada individu yang sensitif. Karena daftar interaksi panjang dan dinamis, biasakan membawa daftar semua obat dan suplemen saat kontrol, serta catat kapan dan berapa dosis yang diminum.

8. Prinsip keamanan penggunaan.

Mulailah selalu dengan dosis terendah yang masuk akal. Naikkan bertahap bila memang ada manfaat dan tidak ada keluhan. Gunakan satu produk baru setiap kali agar mudah menilai penyebab bila muncul efek samping. Buat buku kecil atau catatan ponsel yang berisi nama produk, dosis, waktu minum, tujuan, dan gejala yang dipantau. Tinjau ulang setiap 8 sampai 12 minggu. Jika gejala tidak membaik atau ternyata memburuk, hentikan dan cari pendekatan lain. Berhenti segera dan konsultasi apabila muncul reaksi seperti ruam luas, bengkak wajah atau bibir, napas terasa berat, jantung berdebar kuat yang tidak biasa, pusing berat, nyeri perut hebat, atau perubahan warna urin dan mata menjadi kuning.

9. Contoh alur pengambilan keputusan yang realistis.

Misalkan asesmen harian menunjukkan asupan kalsium baru setengah dari target dan Anda jarang terkena matahari pagi. Langkah pertama adalah menambah porsi pangan kaya kalsium dan menjadwalkan paparan cahaya pagi yang aman. Setelah dua minggu, bila asupan masih kurang, pilih suplemen kalsium dengan dosis kecil dua kali sehari dan tambahkan vitamin D sesuai kebutuhan. Catat energi harian, kualitas tidur, kram malam, dan kenyamanan pencernaan. Bila trigliserida tetap tinggi walau diet sudah membaik dan ikan jarang dikonsumsi, pertimbangkan minyak ikan dengan isi EPA dan DHA yang jelas, lalu nilai kembali setelah 6 minggu. Untuk keluhan kram malam, cobalah

memperkaya pangan tinggi magnesium terlebih dahulu; barulah tambah suplemen magnesium elemental rendah jika perlu. Untuk gejala vasomotor ringan, optimalkan gaya hidup (berat badan sehat, tidur rapi, bumbu pedas dikurangi di malam hari), lalu coba peningkatan konsumsi kedelai utuh secara teratur sebelum melangkah ke suplemen isoflavon.

10. Kapan harus berkonsultasi.

Segera diskusikan dengan tenaga kesehatan bila Anda memiliki penyakit ginjal, hati, jantung, atau gangguan tiroid; jika menggunakan banyak obat harian; bila Anda penyintas kanker; atau bila muncul gejala baru yang tidak biasa setelah memulai produk tertentu. Konsultasi juga bijak dilakukan sebelum operasi, karena beberapa suplemen memengaruhi pembekuan darah dan perlu dihentikan sementara.

Ringkasnya, suplemen dan herbal dapat menjadi penopang, bukan pemeran utama. Pilih berdasarkan kebutuhan yang terukur, gunakan produk yang jelas mutunya, mulai dari dosis rendah, pantau respon, dan hentikan bila tidak memberi manfaat atau menimbulkan keluhan. Ketika dikelola dengan prinsip ini dan selalu ditempatkan di atas fondasi pola makan dan gaya hidup yang sehat, suplemen berkontribusi nyata untuk menjaga tulang, jantung, pencernaan, dan kenyamanan harian, tanpa menambah risiko yang tidak perlu.

J. Implementasi Praktis, Peran Keluarga, Monitoring, dan Tindak Lanjut

Keberhasilan perubahan pola makan dan gaya hidup selama menopause tidak semata ditentukan oleh apa yang dimakan atau jenis latihan yang dipilih, melainkan oleh cara menjalankannya dari hari ke hari. Kuncinya adalah tujuan yang jelas, rencana dapur yang sederhana, jadwal gerak yang realistis, dukungan keluarga yang hangat, serta pemantauan yang jujur agar rencana bisa disesuaikan tepat waktu.

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan gaya yang benar-benar relevan dengan prioritas pribadi. Gunakan kerangka SMART agar tujuan menjadi terang dan terukur. Misalnya, daripada "ingin lebih sehat," rumuskan "dalam empat minggu saya berjalan cepat selama tiga puluh menit setiap Senin, Rabu, dan Jumat setelah subuh." Daripada "mau makan sayur," rumuskan "setiap makan utama separuh piring berisi sayur berwarna." Tujuan seperti ini spesifik, ada angka waktunya, dapat dicapai, penting bagi diri sendiri, dan punya tenggat evaluasi. Dua atau tiga tujuan sudah cukup untuk satu siklus empat minggu. Terlalu banyak target membuat tubuh dan pikiran cepat lelah.

Tujuan yang jelas memudahkan perencanaan dapur. Rancang menu mingguan yang berulang seperlunya agar belanja hemat waktu. Pilih tiga sampai empat lauk inti yang mudah diputar, misalnya ikan bakar, tumis tempe sayur, sop ayam bening,

dan pepes tahu. Tambahkan dua jenis sayur harian yang bisa disiapkan cepat, serta buah yang mudah diambil. Setelah daftar belanja dibuat, sisihkan satu waktu di akhir pekan untuk persiapan singkat: cuci dan siangi sayur dua sampai tiga hari ke depan, rebus atau panggang sumber protein sekaligus lalu bagi ke wadah kecil, siapkan bumbu dasar tumis dan bumbu kuning dalam botol bersih. Dengan persiapan ini, memasak di hari kerja tinggal merakit. Buah diletakkan di tempat yang terlihat agar menjadi pilihan pertama saat lapar. Di luar rumah, gunakan panduan piring yang sama: minta porsi sayur memadai, pilih kuah bening, dan minta nasi porsi kecil.

Latihan fisik perlu dijadwalkan seperti janji penting agar benar-benar terjadi. Pilih bentuk yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika waktu pagi sempit, jadwalkan dua sesi jalan cepat tiga puluh menit di sore hari serta satu sesi dua puluh menit di akhir pekan. Sisipkan latihan kekuatan dua kali per minggu dengan pola gerak fungsional di rumah: duduk berdiri dari kursi, dorong tarik karet elastik, hip hinge dengan botol air, dan latihan dasar panggul. Untuk hari sangat sibuk, siapkan rencana cadangan berupa paket gerak sepuluh menit yang dapat dilakukan kapan saja, seperti tiga set duduk berdiri, plank lutut pendek, peregangan pinggul, dan latihan dasar panggul. Jadwal yang fleksibel membuat ritme latihan bertahan melewati pekan yang padat tanpa rasa bersalah.

Keluarga adalah sumber daya, bukan polisi gaya hidup. Libatkan mereka sejak awal dengan cara yang menjaga otonomi. Sampaikan tujuan pribadi dan minta bantuan spesifik yang ringan. Misalnya, pasangan menyiapkan air minum botol di pagi hari, anak menaburi kacang panggang di salad, atau menantu mengantar ke pasar ikan di akhir pekan. Bagi peran sesuai minat agar dukungan terasa alami. Atur bahasa pengingat yang ramah. Alih-alih "jangan makan itu," gunakan "bagaimana kalau kita bagi dua dan tambah sayurnya." Pengingat seperti ini meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan perasaan diawasi. Jika keluarga ikut makan bersama, sajikan piring sendiri terlebih dahulu mengikuti panduan, lalu biarkan anggota lain menambahkan sesuai selera mereka. Cara ini menjaga tujuan pribadi tanpa mengubah total kebiasaan keluarga dalam semalam.

Pemantauan adalah kompas yang menunjukkan apakah rencana berjalan ke arah yang diinginkan. Pilih beberapa indikator yang sederhana tetapi bermakna. Energi harian dapat dinilai dengan skala satu sampai sepuluh setiap malam. Kualitas tidur dicatat singkat: butuh berapa lama untuk tertidur, berapa kali terbangun, dan bagaimana rasa segar di pagi hari. Kekuatan fungsional dipantau lewat uji duduk berdiri lima kali berturut-turut dan catat durasinya, atau hitung berapa kali mampu berdiri dari kursi dalam tiga puluh detik. Ukuran pakaian dipakai sebagai penanda yang ramah, misalnya apakah celana kerja terasa lebih longgar di pinggang. Dua atau tiga indikator cukup, yang penting dicatat konsisten.

Untuk mencatat, gunakan cara yang paling mudah diakses. Buku kecil di dapur, formulir satu halaman di pintu kulkas, atau aplikasi ponsel sederhana yang hanya memerlukan centang. Catatan tidak perlu panjang, cukup tanda bahwa target hari itu tercapai atau belum, ditambah satu kalimat hambatan utama. Setiap akhir pekan, luangkan sepuluh menit meninjau catatan. Apa yang berjalan baik dipertahankan, apa yang macet dicari penyebabnya. Mungkin menu terlalu rumit, mungkin jadwal latihan berbenturan dengan jadwal keluarga, atau mungkin tidur larut karena layar gawai. Perbaiki hambatan dengan langkah kecil. Ganti satu menu yang rumit dengan pilihan yang lebih cepat, majukan jadwal latihan tiga puluh menit, atau letakkan ponsel di luar kamar mulai jam sembilan malam. Evaluasi bulanan menjadi momentum mengukur capaian terhadap tujuan SMART, lalu memperbarui target untuk empat minggu berikutnya.

Untuk menjaga keselamatan, kenali tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera. Perdarahan dari jalan lahir setelah menopause, nyeri dada atau sesak yang tidak biasa, pusing berat yang membuat sulit berdiri, dan penurunan berat badan tanpa sebab jelas adalah sinyal untuk menghentikan eksperimen gaya hidup dan mencari penilaian klinis. Catat juga obat dan suplemen yang digunakan, termasuk jamu, beserta jadwal minumnya. Ringkasan satu halaman yang memuat keluhan utama, lama keluhan, rencana yang sudah dijalankan, serta indikator pemantauan akan membantu tenaga kesehatan memahami konteks dan memberi saran yang tepat.

Sebuah skenario dapat menggambarkan alur ini menjadi nyata. Bayangkan seorang ibu yang menargetkan kembali nyaman mengikuti pengajian dua kali seminggu dan tidur lebih utuh. Tujuan empat minggunya adalah jalan cepat tiga kali seminggu, separuh piring sayur di makan siang dan malam, dan latihan dasar panggul dua kali sehari. Menu mingguan diputar sederhana: dua kali ikan, dua kali tempe tahu, sekali sop ayam bening, dengan sayur tumis cepat setiap hari. Keluarga membantu menyiapkan air minum pagi dan menata ulang dapur agar buah selalu terlihat. Indikator yang dicatat adalah energi harian, jumlah terbangun malam, dan uji duduk berdiri. Pada evaluasi pekan kedua, terlihat makan malam agak larut dan kafein sore masih ada. Perubahan kecil dibuat dengan memajukan makan malam tiga puluh menit dan mengganti kopi sore dengan air hangat jahe tipis. Pekan keempat, tidur lebih utuh, energi harian naik, dan celana kerja terasa lebih longgar. Target berikutnya adalah menambah satu sesi latihan kekuatan mingguan dan mempertahankan pola makan yang sudah nyaman.

K. Simpulan

Menopause adalah fase hidup yang memengaruhi hampir setiap sistem tubuh sekaligus ritme keseharian. Karena dampaknya menyeluruh, kunci sukses bukan satu intervensi ajaib, melainkan rangkaian pilihan kecil yang konsisten: pola makan padat gizi, gerak tubuh yang teratur, tidur yang tertata, manajemen stres yang realistis, hidrasi yang cerdas, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Ketika semua bagian ini disatukan, gejala harian menjadi lebih bersahabat, risiko kardiometabolik dan kerapuhan tulang menurun, dan rasa percaya diri untuk tetap aktif di keluarga serta komunitas kembali tumbuh.

Pada ranah gizi, plate model sederhana bekerja efektif dan mudah diikuti: setengah piring sayur dan buah berwarna, seperempat protein berkualitas, dan seperempat karbohidrat utuh. Distribusi protein merata sepanjang hari membantu menjaga massa dan kekuatan otot, sementara pemilihan karbohidrat berindeks glikemik lebih rendah menstabilkan gula darah dan rasa kenyang. Lemak sehat dari ikan, kacang, dan biji mendukung profil lipid yang lebih baik. Tiga pola makan berbasis bukti yaitu Mediterania, DASH, dan rendah indeks glikemik dapat diterapkan tanpa meninggalkan cita rasa Nusantara dengan teknik masak lebih sehat, bumbu aromatik yang kaya, serta porsi yang realistis.

Mikronutrien memegang peran pengaman. Kalsium dan vitamin D menopang kepadatan tulang, didampingi magnesium untuk otot dan kualitas tidur, vitamin B12 dan folat untuk darah serta saraf, serta zat besi yang disesuaikan dengan fase pascamenstruasi. Antioksidan dan polifenol dari sayur buah berwarna, teh, kakao, dan rempah membantu meredam stres oksidatif, sementara seng, selenium, dan yodium mendukung imunitas dan fungsi tiroid. Prinsip utamanya tetap pangan sebagai sumber pokok. Suplemen dipakai selektif setelah asesmen, mutu produk terjamin, dosis dimulai rendah, respon dipantau, interaksi obat diperhitungkan, dan dihentikan bila tidak bermanfaat atau menimbulkan keluhan.

Hidrasi cerdas dan perawatan urogenital membuat malam lebih tenang dan siang lebih leluasa. Asupan cairan dibagi sejak pagi hingga sore, minuman pengiritasi dikurangi menjelang malam, dan kebiasaan berkemih ditata agar kandung kemih tidak mudah terpicu. Serat dan cairan yang cukup mencegah konstipasi yang dapat membebani dasar panggul. Latihan dasar panggul terstruktur menurunkan kebocoran urin dan meningkatkan kenyamanan aktivitas, terutama bila dipadukan dengan latihan aerobik, latihan kekuatan, rangsangan beban tulang, serta latihan keseimbangan harian untuk mencegah jatuh. Keselamatan selalu di depan: pemanasan dan pendinginan, alas kaki yang stabil, ruang latihan yang terang dan bebas halangan, serta kepekaan terhadap tanda bahaya.

Tidur dan stres menentukan keberlanjutan perubahan. Rutinitas tidur yang tetap, paparan cahaya pagi, kamar yang sejuk dan redup, serta pembatasan kafein, gula tinggi, dan layar gawai di malam hari memperbaiki kualitas pulih. Teknik napas, relaksasi otot progresif, meditasi singkat, atau doa terstruktur membantu mematikan mode waspada. Aktivitas bermakna dan jejaring sosial yang hangat menurunkan beban emosi harian, sementara olahraga ringan di pagi atau siang hari membuat tidur lebih dalam.

Semua itu menjadi nyata ketika diikat oleh implementasi yang rapi. Tujuan gaya SMART menjaga arah perubahan, menu mingguan dan persiapan masak memudahkan konsistensi, jadwal latihan yang menyenangkan memperbesar peluang bertahan, dan keluarga dilibatkan sebagai penguat ramah, bukan pengontrol. Monitoring sederhana melalui energi harian, kualitas tidur, uji fungsional duduk berdiri, dan kelonggaran pakaian memberi umpan balik jujur untuk menyesuaikan rencana setiap bulan. Di sisi lain, kewaspadaan klinis harus tetap hidup. Perdarahan setelah menopause, nyeri dada, pusing berat, atau penurunan berat badan tanpa sebab adalah sinyal rujukan segera.

L. Referensi

- American Heart Association. (2021). Dietary guidance to improve cardiovascular health: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 144(23), e472–e487. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001031>
- Barnard, N. D., Kahleová, H., Holtz, D. N., Ashot, F., Neabore, M., Carter, L. M., & Holtz, R. (2021). The Women's Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms (WAVS): A randomized, controlled trial of a plant-based diet and whole soybeans for postmenopausal women. *Menopause*, 28(10), 1150–1156. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001812>
- Edinger, J. D., Arnedt, J. T., Bertisch, S. M., Carney, C. E., Harrington, J. J., Lichstein, K. L., ... Wickwire, E. M. (2021). Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(2), 255–262. <https://doi.org/10.5664/jcsm.8986>
- Gonçalves, C., Moreira, H., & Santos, R. (2024). Systematic review of Mediterranean diet interventions in menopausal women. *AIMS Public Health*, 11(1), 110–129. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2024005>
- Guirguis-Blake, J. M., Perdue, L. A., Coppola, E. L., & Bean, S. I. (2024). Interventions to prevent falls in older adults: Updated evidence report and systematic review

- for the USPSTF. *JAMA*, 332(1), 58–69. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.4166>
- LeBoff, M. S., Greenspan, S. L., Insogna, K. L., Lewiecki, E. M., Saag, K. G., Singer, A., ... Siris, E. S. (2022). The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. *Osteoporosis International*, 33, 2049–2102. <https://doi.org/10.1007/s00198-021-05900-y>
- North American Menopause Society. (2020). The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 27(9), 976–992. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001609>
- Shufelt, C. L., Brown, V., Carpenter, J. S., Chism, L. A., Faubion, S. S., Joffe, H., ... Thurston, R. C. (2023). The 2023 nonhormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 30(6), 573–590. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002200>
- U.S. Preventive Services Task Force; Nicholson, W. K., Silverstein, M., Wong, J. B., ... Brooks, L. (2024). Interventions to prevent falls in community-dwelling older adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 332(1), 51–57. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.8481>
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A. J., Hooper, L., Kiesswetter, E., ... Bischoff, S. C. (2022). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 41(4), 958–989. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2022.01.024>
- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2024). Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care (2nd ed.). Geneva: WHO.
- Silva, T. R., Oppermann, K., Reis, F. M., & Spritzer, P. M. (2021). Nutrition in menopausal women: A narrative review. *Nutrients*, 13(7), 2149. <https://doi.org/10.3390/nu13072149>

M. Glosarium

ADL, aktivitas dasar kehidupan sehari hari: Kegiatan paling mendasar untuk mandiri seperti mandi, berpakaian, makan, berpindah posisi, dan memakai toilet.

Ageisme: Stereotip, prasangka, atau diskriminasi berbasis usia yang dapat membuat keluhan lansia dianggap wajar lalu diabaikan.

Ajak ulang, teach back: Teknik komunikasi untuk memastikan pemahaman dengan meminta klien mengulang inti informasi dengan kata kata sendiri.

Anamnesis: Wawancara klinis yang menggali riwayat kesehatan, pola makan, obat, kebiasaan, konteks sosial, dan tujuan hidup.

Antioksidan: Senyawa pelindung sel dari kerusakan oksidatif, misalnya vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan polifenol.

B12, vitamin B12: Vitamin yang penting untuk pembentukan darah dan fungsi saraf. Banyak pada ikan, daging, telur, susu, atau pangan fortifikasi.

Bladder training, pelatihan kandung kemih: Jadwal berkemih teratur untuk mengurangi kebiasaan menahan terlalu lama atau terlalu sering berkemih.

Cultural humility: Sikap rendah hati budaya. Tenaga kesehatan mengakui keterbatasan pengetahuan dan aktif belajar dari klien.

Cultural safety: Kondisi layanan yang dirasakan aman dan bebas prasangka oleh klien, dengan persetujuan yang benar benar bermakna.

DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension: Pola makan tinggi sayur dan buah, protein rendah lemak, susu rendah lemak, serta rendah garam untuk menstabilkan tekanan darah.

Defisit energi moderat: Pengurangan kalori yang wajar untuk menurunkan berat badan tanpa mengorbankan massa otot dan kesehatan tulang.

Delirium: Kebingungan akut yang berfluktuasi, sering dipicu infeksi, dehidrasi, atau obat. Memerlukan penilaian medis segera.

Distribusi protein merata: Cara membagi asupan protein di setiap waktu makan agar sintesis protein otot terstimulasi berulang.

GSM, genitourinary syndrome of menopause: Kumpulan keluhan urogenital pascamenopause seperti kering dan nyeri vagina, urgensi, sering berkemih, dan penurunan kenyamanan seksual.

Hidrasi cerdas: Pemenuhan cairan harian dengan jenis dan waktu minum yang tepat. Fokus pada kebutuhan siang hari agar tidur malam tidak terganggu.

Higiene tidur: Kebiasaan dan lingkungan yang mendukung tidur pulih. Termasuk jadwal tetap, cahaya pagi, kamar sejuk dan redup, serta pembatasan kafein malam.

IG, indeks glikemik: Ukuran kecepatan peningkatan gula darah setelah makan karbohidrat. Makin rendah biasanya makin stabil.

IADL, aktivitas instrumental kehidupan sehari hari: Kegiatan kompleks untuk mandiri seperti berbelanja, menyiapkan makanan, mengelola keuangan, dan memakai transportasi.

ICOPE, Integrated Care for Older People: Kerangka layanan terintegrasi untuk mempertahankan kapasitas dan kemandirian lansia.

Inkontinensia urin: Kebocoran urin yang tidak disengaja, misalnya saat batuk atau munculnya dorongan mendesak.

Interaksi obat: Perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersama obat lain, suplemen, atau herbal. Dapat menurunkan efektivitas atau meningkatkan risiko efek samping.

Isoflavon kedelai: Fitokimia mirip estrogen yang sangat lemah. Pada sebagian perempuan dapat membantu gejala vasomotor ringan.

Kalori padat gizi, nutrient density: Banyak vitamin, mineral, dan serat per kalori. Contoh sayur, buah, kacang, biji, ikan.

Kalsium: Mineral utama tulang dan gigi. Sumbernya susu tinggi kalsium, ikan bertulang lunak, tahu tempe dengan penggumpal kalsium, sayuran hijau.

Kandungan lemak sehat: Lemak tidak jenuh dari ikan, kacang, biji, dan minyak nabati yang diolah wajar agar tidak rusak.

Kandungan natrium, garam: Jumlah sodium pada pangan. Perlu dibatasi untuk membantu tekanan darah.

Kapasitas intrinsik: Gabungan kemampuan fisik dan mental yang menentukan fungsi harian.

Kardiometabolik, risiko: Risiko gabungan penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2. Dipengaruhi lemak visceral, profil lipid, tekanan darah, dan gula darah.

Katabolisme tulang: Proses pembongkaran jaringan tulang. Meningkat setelah menopause bila tanpa pencegahan.

Kebersihan area intim: Perawatan lembut tanpa pewangi dan tanpa pembersihan internal agar flora alami terjaga.

Kebutuhan protein menopause: Sekitar 1,0 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari, disesuaikan kondisi dan anjuran tenaga kesehatan.

Kelelahan siang hari: Rasa lelah berlebihan akibat tidur kurang pulih, anemia, atau beban stres. Perlu ditelusuri penyebabnya.

Keseimbangan dan mobilitas: Kemampuan menjaga postur dan keluwesan gerak yang menurunkan risiko jatuh.

Konstipasi: Sulit buang air besar karena asupan serat dan cairan kurang, aktivitas rendah, atau efek obat. Dapat memperberat keluhan dasar panggul.

Latihan beban tulang: Aktivitas menahan beban tubuh seperti jalan cepat dan naik tangga untuk merangsang kepadatan tulang.

Latihan dasar panggul: Kontraksi terarah otot lantai panggul untuk mengurangi kebocoran urin serta menunjang kenyamanan urogenital.

Latihan kekuatan: Latihan resistensi 2 sampai 3 kali per minggu untuk mempertahankan massa dan fungsi otot.

Latihan keseimbangan harian: Sesi singkat seperti berdiri satu kaki, jalan tumit ke ujung jari, atau duduk berdiri terkendali untuk mencegah jatuh.

Lemak jenuh: Lemak yang perlu dibatasi. Banyak pada daging berlemak, santan kental, krimer padat lemak, dan gorengan berulang.

Magnesium: Mineral yang berperan pada kontraksi otot, produksi energi, dan regulasi saraf. Sumbernya kacang, biji, sereal utuh, sayuran hijau.

Malnutrisi pada lansia: Kekurangan energi atau protein yang menurunkan berat, massa otot, dan meningkatkan kerentanan jatuh dan infeksi.

Mediterranean diet, pola Mediterania: Pola makan tinggi sayur, buah, biji bijian utuh, kacang, ikan, minyak nabati, rendah daging olahan.

Mindful eating: Cara makan sadar tanpa distraksi, mengunyah perlahan, mengenali rasa lapar dan kenyang.

Natrium, sodium: Mineral utama garam dapur. Kelebihan natrium terkait tekanan darah tinggi.

Nonhormonal therapy: Strategi non hormonal untuk gejala menopause seperti pola makan, latihan, higiene tidur, teknik relaksasi, dan sebagian suplemen terpilih.

Omega 3, EPA DHA: Asam lemak dari ikan berminyak yang mendukung profil lipid dan kesehatan pembuluh darah.

Osteopenia, osteoporosis: Penurunan kepadatan tulang hingga rentan patah. Memerlukan gizi, latihan beban, dan strategi pencegahan lain.

Paparan cahaya pagi: Paparan sinar natural 10 sampai 15 menit di awal hari untuk menguatkan ritme sirkadian.

Pati resisten: Fraksi pati yang tidak cepat dicerna dan bermanfaat bagi kesehatan usus. Meningkat pada nasi yang didinginkan lalu dipanaskan kembali, dengan porsi tetap wajar.

Perimenopause: Fase transisi menuju menopause saat siklus tidak teratur dan gejala mulai menonjol.

Pola makan rendah indeks glikemik: Pola yang mengutamakan karbohidrat utuh dan porsi terkendali agar lonjakan gula darah lebih landai.

Polifarmasi: Penggunaan banyak obat sekaligus yang meningkatkan risiko interaksi dan efek samping.

Polifenol: Senyawa tumbuhan dengan aktivitas antioksidan. Banyak pada teh, kopi, kakao, rempah, sayur, dan buah berwarna.

Probiotik: Mikroorganisme hidup yang memberi manfaat kesehatan bila jumlahnya cukup dan strainnya tepat.

Protein berkualitas: Sumber protein dengan asam amino esensial lengkap atau kombinasi yang saling melengkapi. Contohnya ikan, telur, ayam tanpa kulit, tempe tahu ditambah sereal.

SMART goal: Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Skrining gangguan tidur: Penapisan gejala insomnia, sleep apnea, kaki gelisah, atau gangguan lain yang mengganggu pulih malam.

Stres oksidatif: Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan pertahanan antioksidan yang merusak sel.

Teknik napas pelan: Pola napas terstruktur untuk menurunkan aktivasi sistem saraf. Contoh 4 2 6, tarik empat hitungan, tahan dua, hembus enam.

Tempe dan tahu kaya kalsium: Produk kedelai yang diolah dengan penggumpal kalsium sehingga kandungan kalsiumnya lebih tinggi.

Vasomotor, gejala: Rasa panas mendadak dan keringat malam yang khas pada transisi menopause.

Vitamin D: Zat gizi yang membantu penyerapan kalsium dan fungsi otot. Dipengaruhi paparan sinar matahari, asupan, dan faktor individu.

WHO ICOPE: Pedoman WHO untuk asesmen berpusat pada orang dan jalur intervensi primer, agar lansia tetap mandiri dan aktif.

PROFIL PENULIS



Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes Lahir di Madiun, 29 Januari 1980. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Madiun Tahun 1999. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Magetan Tahun 2002. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Makassar Tahun 2006. Lulus Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2012. Lulus Profesi Bidan Poltekkes Surabaya Tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah dibidang Kebidanan.

Penulis mengajar Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, KB dan Kesehatan Reproduksi, Etikolegal dalam Kebidanan, Askeb Menopause sejak tahun 2005 sampai sekarang, penulis juga aktif melaksanakan penelitian setiap tahun. Penulis juga aktif sebagai anggota IBI sejak tahun 2005-sekarang. Keinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan mendorong penulis untuk menulis buku. Kebidanan penulis juga ingin mewujudkan terbitnya buku-buku yang bermanfaat dan relevan dengan kebidanan dari hasil-hasil penelitian Ibu hamil dan Menyusui buku Monograf, buku Referensi. Semoga buku-buku yang kami tulis bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa Kebidanan dan Masyarakat umum. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: astinnur1980@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes. Lahir pada 4 Maret 1985 di Nganjuk, Jawa Timur. Riwayat Pendidikan: Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri (2006), DIV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran (2008), S2 Magister Kedokteran Keluarga (2014). Riwayat Pekerjaan: Dosen di Akbid Dharma Husada Kediri (2006-2024), Dosen di Universitas Strada Indonesia (2024-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lelykhulafaur.strada@gmail.com. Motto : "Baiti Jannati".

PROFIL PENULIS



Nama Penulis: **Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep.Ns, M.Kes.** Lahir di Gresik 01 Juni 1976, jenjang Pendidikan tinggi yang ditempuh Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004, Magister Kesehatan Promosi Kesehatan Keluarga Di Universitas Negeri Surakarta tahun 2014. Pekerjaan aktif sebagai Dosen mulai tahun 2004 sampai sekarang, Menjabat Wakil Dekan bidang Akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan mulai tahun 2023 – 2025. di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Penulis aktif pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik Workshop, Pengabdian Masyarakat, Penulis Buku, Publikasi pada Jurnal. Aktif Dalam sebagai anggota PPNI mulai 2004 - sekarang, Aktif dalam kegiatan Jalasenastri AL mulai 2014 - 2025 I. Penulis dapat dihubungi melalui Email : binarti.dwiwahyuni@gmail.com.

Motto:

"If you dont go after what you want, youll never have it. And if you dont ask, the answer is always no. Also if you dont step forward, youre always in the same place."



Leza Fidyah Restiana, S.S.T., Bdn., M.Keb. Penulis lahir di Bengkulu. Telah menyelesaikan studi DIII kebidanan di Poltekkes Provinsi Bengkulu (sekarang Universitas Bengkulu), lulus DIV Kebidanan Politeknik Karya Husada Jakarta, lulus S2 kebidanan Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas tahun 2020. Kemudian telah menyelesaikan pendidikan profesi bidan tahun 2023 di STIKes Pelita Ilmu Depok. Saat ini sebagai dosen tetap Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Pelita Ilmu Depok. Sebagai dosen penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulisan buku ini merupakan Langkah awal penulis dalam mengembangkan karakter sebagai dosen profesional. Penulis telah melakukan beberapa penelitian dalam kebidanan serta sudah dipublikasikan baik nasional dan internasional. Penulis akan terus mengembangkan potensi dan karir baik didalam Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Workshop, Publikasi dan lain-lain.

email: lezafidyah6@gmail.com

PROFIL PENULIS



drg Arnetty, M.Kes. Lahir di Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat 24 Juli 1967

di RS Bayangkara Padang. Saat ini penulis bekerja pada Kemenkes Poltekkes Padang dengan mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu, Exodonti. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter

Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dimana sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Pada tahun 1998 penulis sebagai dokter gigi

e-mail: arnetty0724@gmail.com

Motto: ""Learn From Failures."

Sinopsis

BUNGA RAMPAI PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE: STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN BERMARTABAT menghadirkan panduan komprehensif, berbasis bukti, dan peka budaya bagi bidan serta tenaga kesehatan dalam mendampingi perempuan melewati perimenopause hingga postmenopause. Berangkat dari gagasan bahwa transisi ini harus dilalui dengan martabat, buku ini merangkum strategi edukasi, manajemen gejala klinis secara holistik, skrining kesehatan yang tepat, pendampingan psikologis yang etis, serta penguatan nutrisi dan gaya hidup sehat. Disusun oleh akademisi dan praktisi, setiap bab dilengkapi referensi dan glosarium untuk memastikan kejelasan konsep sekaligus kemudahan implementasi di layanan primer, rumah sakit, maupun komunitas.

Bab 1 (Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.) menegaskan peran strategis bidan sebagai pendidik kesehatan memperinci pendahuluan, konsep dasar menopause, hingga keterampilan komunikasi dan edukasi yang sensitif terhadap nilai dan konteks budaya perempuan. Bab 2 (Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.) memperluas cakrawala manajemen gejala lewat pendekatan holistik: mengintegrasikan intervensi non-farmakologis, dukungan psikologis, terapi komplementer yang terpilih, serta penggunaan farmakoterapi yang bijak dalam kolaborasi tim kesehatan. Memperkuat pencegahan dan deteksi dini, Bab 3 (Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.) memaparkan tujuan dan landasan ilmiah skrining pada perimenopause dan postmenopause, daftar skrining yang direkomendasikan, panduan frekuensi dan metode, peran tenaga kesehatan, hambatan implementasi, serta strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam skrining.

Dimensi psikososial diperdalam di Bab 4 (Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.) yang merumuskan landasan teoritis, tujuan, prinsip dan etika pendampingan, teknik dan materi konseling, mekanisme evaluasi keberhasilan, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan dukungan yang berkesinambungan. Bab 5 (Drg. Arnetty, M.Kes.) menutup rangkaian dengan pilar nutrisi dan gaya hidup: implikasi gizi dari fisiologi menopause, pola makan seimbang, mikronutrien kunci, adaptasi pola makan Nusantara berbasis bukti, hidrasi cerdas dan kesehatan urogenital, latihan fisik (aerobik, kekuatan, keseimbangan, latihan dasar panggul), higiene tidur dan manajemen stres, hingga penilaian keamanan suplemen dan herbal. Diakhiri dengan profil penulis, buku ini menjadi rujukan praktis untuk memperkuat kapasitas bidan dan jejaring kesehatan dalam mewujudkan pengalaman menopause yang sehat, berdaya, dan bermartabat.

BUNGA RAMPAI PENDAMPINGAN KEBIDANAN DALAM MENOPAUSE: STRATEGI MENUJU MENOPAUSE SEHAT DAN BERMARTABAT menghadirkan panduan komprehensif, berbasis bukti, dan peka budaya bagi bidan serta tenaga kesehatan dalam mendampingi perempuan melewati perimenopause hingga postmenopause. Berangkat dari gagasan bahwa transisi ini harus dilalui dengan martabat, buku ini merangkum strategi edukasi, manajemen gejala klinis secara holistik, skrining kesehatan yang tepat, pendampingan psikologis yang etis, serta penguatan nutrisi dan gaya hidup sehat. Disusun oleh akademisi dan praktisi, setiap bab dilengkapi referensi dan glosarium untuk memastikan kejelasan konsep sekaligus kemudahan implementasi di layanan primer, rumah sakit, maupun komunitas.

Bab 1 (Bdn. Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.) menegaskan peran strategis bidan sebagai pendidik kesehatan memperinci pendahuluan, konsep dasar menopause, hingga keterampilan komunikasi dan edukasi yang sensitif terhadap nilai dan konteks budaya perempuan. Bab 2 (Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes.) memperluas cakrawala manajemen gejala lewat pendekatan holistik: mengintegrasikan intervensi non-farmakologis, dukungan psikologis, terapi komplementer yang terpilih, serta penggunaan farmakoterapi yang bijak dalam kolaborasi tim kesehatan.

Memperkuat pencegahan dan deteksi dini, Bab 3 (Binarti Dwi Wahyuningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.) memaparkan tujuan dan landasan ilmiah skrining pada perimenopause dan postmenopause, daftar skrining yang direkomendasikan, panduan frekuensi dan metode, peran tenaga kesehatan, hambatan implementasi, serta strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam skrining.

Dimensi psikososial diperdalam di Bab 4 (Leza Fidyah Restiana, S.ST., Bdn., M.Keb.) yang merumuskan landasan teoritis, tujuan, prinsip dan etika pendampingan, teknik dan materi konseling, mekanisme evaluasi keberhasilan, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan dukungan yang berkesinambungan. Bab 5 (Drg. Arnetty, M.Kes.) menutup rangkaian dengan pilar nutrisi dan gaya hidup: implikasi gizi dari fisiologi menopause, pola makan seimbang, mikronutrien kunci, adaptasi pola makan Nusantara berbasis bukti, hidrasi cerdas dan kesehatan urogenital, latihan fisik (aerobik, kekuatan, keseimbangan, latihan dasar panggul), higiene tidur dan manajemen stres, hingga penilaian keamanan suplemen dan herbal. Diakhiri dengan profil penulis, buku ini menjadi rujukan praktis untuk memperkuat kapasitas bidan dan jejaring kesehatan dalam mewujudkan pengalaman menopause yang sehat, berdaya, dan bermartabat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7426-06-2



9

786347

426062